



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PROGRAM KERJA RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA SUKOREJO
TAHUN 2025**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

DAFTAR ISI

BAB I.....	3
PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	3
BAB II	4
GAMBARAN UMUM	4
BAB III.....	2
KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN	2
3.1 PELAYANAN	2
3.2 PENUNJANG	22
3.3 UMUM dan KEUANGAN	60
3.4 PROGRAM dan KOMITE	74
BAB IV.....	174
MONITORING DAN EVALUASI	174
BAB V.....	175
PENCATATAN DAN PELAPORAN	175
BAB VI.....	176
PENUTUP.....	176

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah Sakit sebagai institusi penyelenggara pelayanan kesehatan dalam merealisasikan tujuan dan sasaran strategisnya membutuhkan acuan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan di Rumah Sakit untuk mewujudkan pelayanan yang paripurna dan bermutu sesuai kebutuhan masyarakat dan memperhatikan standart. Untuk mewujudkan kualitas pelayanan yang paripurna mendorong manajemen rumah sakit mengambil langkah-langkah strategis sesuai dengan regulasi di bidang kesehatan dan perumahsakitan, yang dituangkan ke dalam bentuk kebijakan pimpinan yang bersifat mengatur tata hubungan kerja sumber daya internal rumah sakit maupun program kerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis rumah sakit.

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit mempunyai karakteristik dan organisasai yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi satu sama lain.

Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo sebagai salah satu Rumah Sakit swasta di wilayah Pasuruan, memiliki peranan penting untuk menjaga dan meningkatkan mutu dan derajat kesehatan masyarakat. Penyusunan Program Kerja Rumah Sakit Tahun 2025 dimaksudkan sebagai wujud dari upaya penjabaran rencana jangka panjang dan rencana tahunan Rumah Sakit. Akhirnya Program Kerja Rumah Sakit Tahun 2025 yang tersusun secara baik dapat juga berfungsi sebagai alat pengendalian pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan mutu layanan dalam periode satu tahun.

1.2 Dasar Hukum

1. Program Kerja RS Prima Husada Sukorejo tahun 2025 disusun berdasarkan :
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Th 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit.
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen program kerja RS Prima Husada Sukorejo Tahun 2025 ini disusun sebagai panduan melaksanakan kegiatan dan sebagai instrumen untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja Bagian/Bidang/Instalasi di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Visi

Menjadi Rumah Sakit Berkualitas Prima Pilihan Seluruh Lapisan Masyarakat

2.2. Misi

1. Memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat dan akurat
2. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien
3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan

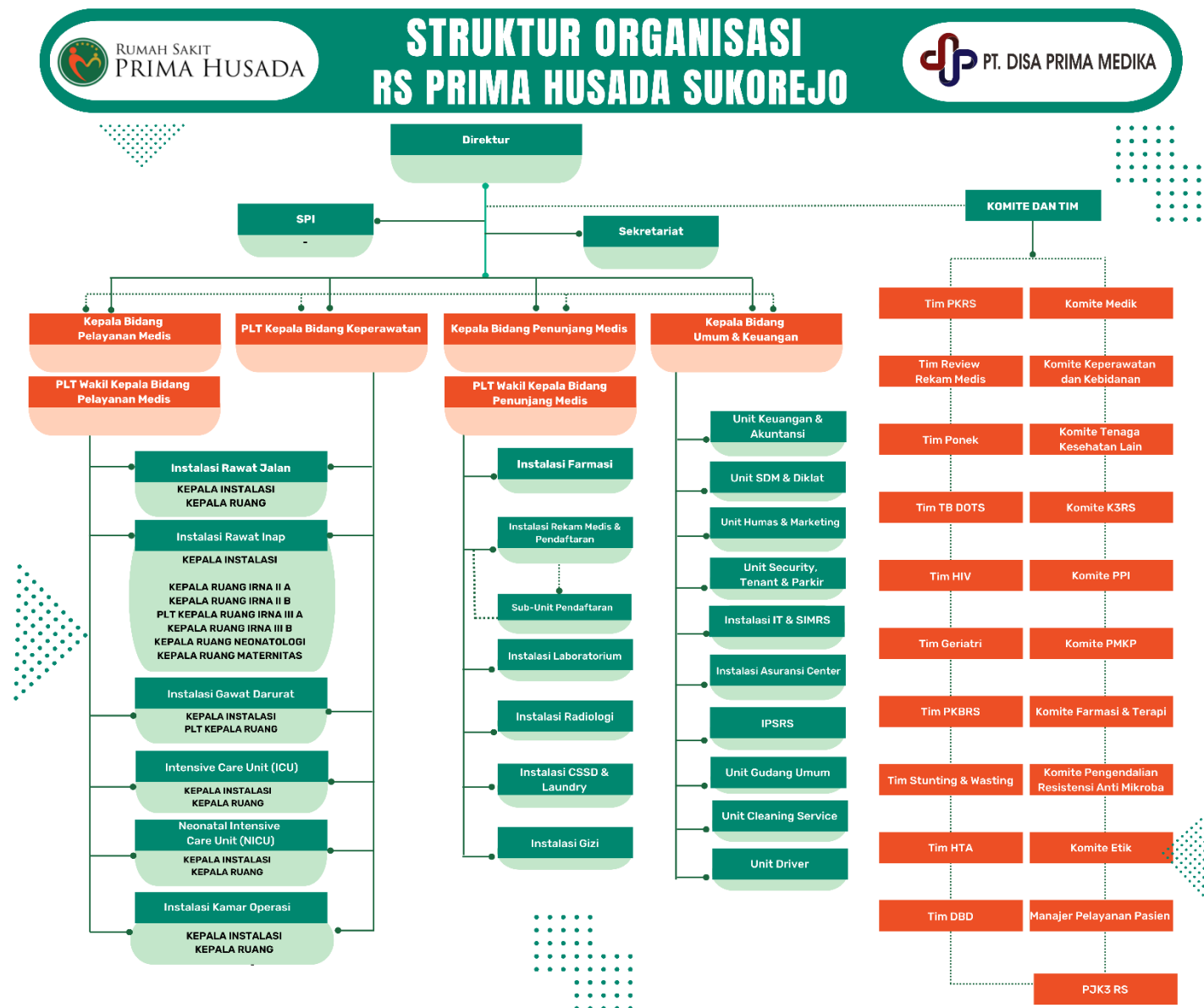
2.3. Motto

Motto kami adalah “**Sahabat Menuju Sehat**”, yang berarti berperan sebagai sahabat kepada pasien (sahabat) dalam memberikan pelayanan kesehatan. Menempatkan setiap pasien sebagai bagian keluarga, memposisikan diri kita sebagai pasien sehingga kami mengerti apa yang harus kami berikan kepada pasien

2.4. Tujuh Nilai Budi Utama

1. Jujur
2. Dipercaya
3. Tanggung Jawab
4. Visioner
5. Disiplin
6. Kerjasama
7. Adil
8. Peduli

2.5. SOTK



BAB III

KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN

3.1 PELAYANAN

A. ANALISA SWOT

Penyusunan strategi didasarkan pada analisis SWOT yang mencermati kondisi lingkungan internal organisasi berupa kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses) dan kondisi lingkungan eksternal organisasi, yaitu peluang (opportunities) dan ancaman (threats). Dengan tehnik SWOT dapat diketahui kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya controllable (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan organisasi serta kondisi-kondisi elemen eksternal organisasi yang sifatnya uncontrollable (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman. Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya. Dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. *Strength* (Kekuatan)

- 1) Komitmen Pemilik RS
- 2) Terakreditasi Paripurna
- 3) Jenis pelayanan kesehatan sesuai standar kelas tipe C
- 4) Sarana prasarana sesuai standar kelas tipe C
- 5) Lokasi rumah sakit yang strategis
- 6) Rumah Sakit sudah lama dikenal
- 7) Akses RS mudah dijangkau

b. *Weakness* (Kelemahan)

- 1) SIMRS tidak terintegrasi dan tidak berjalan optimal
- 2) Jadwal dokter spesialis yang tidak terdistribusi dengan merata
- 3) Angka keterlambatan praktek dokter spesialis tinggi
- 4) Kinerja SDM rumah sakit kurang optimal
- 5) Turn over yang cukup tinggi
- 6) Tidak maksimal pemanfaatan alat medis
- 7) Penataan lokasi pelayanan belum optimal
- 8) Angka kepuasan stakeholder rendah
- 9) Penetapan tarif lebih didasarkan pada kompetitor daripada unit cost
- 10) Marketing belum optimal
- 11) Kompetensi tenaga kesehatan yang rendah
- 12) Retensi DPJP terhadap tenaga medis baru
- 13) Terbatasnya lahan
- 14) Efisiensi belum optimal

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. *Opportunity* (Peluang)

- 1) Pembiayaan JKN dan asuransi Kesehatan lainnya
- 2) Adanya jejaring kemitraan dengan PPK 1, RS dengan pelayanan 2esehatan lainnya
- 3) Banyak perusahaan yang berada disekitar RS
- 4) Kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan 2esehatan terus meningkat
- 5) Kebutuhan masyarakat untuk pelayanan 2esehatan terus meningkat
- 6) Adanya sosial media
- 7) Banyaknya tenaga medis yang berminat bergabung di RS Prima Husada Sukorejo
- 8) Kemajuan teknologi di bidang Kesehatan yang terus berkembang

b. *Threats* (Ancaman)

- 1) Jarak dengan rumah sakit kompetitor dekat
- 2) ketidakpuasan pasien pada dokter spesialis
- 3) Managemen kurang kuat
- 4) Struktur gaji yang tidak sesuai standart
- 5) Munculnya rumah sakit baru

- 6)

Informasi hoaks yang beredar di masyarakat
- 7)

Persaingan dibidang Rumah Sakit yang cukup tinggi
- 8)

Ketergantungan pada produk impor (cost tinggi)
- 9)

Citra RS masih negative

3. Matriks IFAS dan EFAS

a. IFAS Posisi Strategi RS Prima Husada Sukorejo

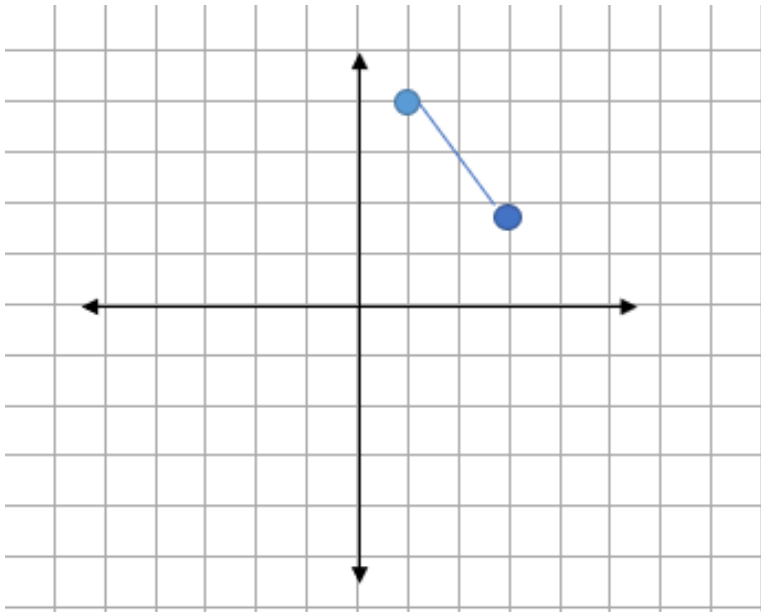
No.	Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor
1	2	3	4	5
A	Kekuatan (Strength)			
1.	Komitmen pemilik RS	0.20	80	16
2.	Terakreditasi Paripurna	0.15	75	11.25
3.	Lokasi RS yang strategis	0.15	80	12
4.	Rumah sakit sudah lama dikenal	0.15	80	12
5.	Sarana prasarana yang telah sesuai dengan standar	0.15	80	12
6.	Jensi pelayanan Kesehatan yang banyak	0.20	80	16
Total A				79.25
B	Kelemahan (weakness)			
1.	SIMRS tidak terintegrasi dan tidak berjalan optimal	0,10	80	8
2.	Jadwal dokter spesialis yang tidak terdistribusi dengan merata	0,10	80	8
3.	Angka keterlambatan praktek dokter spesialis tinggi	0,10	80	8
4.	Kinerja SDM rumah sakit kurang optimal	0,07	75	5.25
5.	Turn over yang cukup tinggi	0,04	60	2.4
6.	Tidak maksimal pemanfaatan alat medis	0,04	60	2.4
7.	Penataan lokasi pelayanan belum optimal	0,04	60	2.4
8.	Angka kepuasan stakeholder kurang	0,07	80	5.6
9.	Tidak ada costing rs	0,07	70	4.9
10.	Marketing belum optimal	0,06	70	4.2
11.	Kompetensi tenaga kesehatan yang rendah	0,09	70	6.3
12.	Retensi DPJP terhadap tenaga medis baru	0,10	85	8.5
13.	Efisiensi belum optimal	0.08	80	6.4
14.	Terbatasnya lahan	0.05	70	3.5
Total B		1		77.85
Total A+B				157.1

b. EFAS Posisi Strategi RS Prima Husada Sukorejo

No	Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Skor
1	2	3	4	5
A	Opportunity (Peluang)			
1.	Pembiayaan JKN dan asuransi Kesehatan lainny	0,15	85	12.75
2.	Adanya jejaring kemitraan dengan PPK 1, RS dengan pelayanan 3esehatan lainnya	0,15	85	12.75
3.	Banyaknya perusahaan yang berada disekitar RS	0,13	75	9.75

4.	Kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan 4esehatan terus meningkat	0,10	70	7
5.	Kebutuhan masyarakat untuk pelayanan 4esehatan terus meningkat	0,10	70	7
6.	Banyaknya tenaga medis yang berminat bergabung di RS Prima Husada Sukorejo	0,15	85	12.75
7.	Adanya media sosial	0,12	80	9.6
8.	Kemajuan teknologi di bidang Kesehatan yang terus berkembang	0,10	75	7.5
Total A		1		79.1
B	Ancaman (Threats)			
1.	Jarak dengan rumah sakit kompetitor dekat	0,12	80	9.6
2.	Ketidakpuasan pasien pada dokter spesiaiist	0,10	80	8
3.	Manajemen kurang kuat	0,13	85	11.05
4.	Struktur gaji yang tidak sesuai standar	0,10	75	7.5
5.	Munculnya RS baru	0,07	60	4.2
6.	Persaingan dibidang Rumah Sakit yang cukup tinggi	0,08	60	4.8
7.	Ketergantungan pada produk impor (cost tinggi)	0,06	60	3.6
8.	Citra RS negative yang berdampak ada kunjungan masyarakat	0,11	80	8.8
9.	Kebijakan JKN dan pentarifan (terutama INA CBG's) yang berubah-ubah	0,15	85	12.75
10.	Informasi hoaks yang beredar di masyarakat	0,08	80	6.4
Total B		1		76.8
Total A+B				155.05

DIAGRAM KARETESIUS



Dalam diagram kartesius dapat dilakukan sebagai berikut :
 Nilai sumbu X = nilai bobot kekuatan (S) dikurangi bobot kelemahan (W)

Nilai sumbu X
=
79.25
−
77.85
=
1.4
(+
1.4)

Nilai sumbu Y
=
nilai bobot peluang dikurangi bobot ancaman

Nilai sumbu Y
=
79.1
−
76.8
=
2.3
(+
2.3)

Sehingga posisi peta kekuatan organisasi rumah sakit berdasarkan data tersebut diatas berada pada kuadran I Tahap berikutnya berdasarkan Analisa Lingkungan

Internal dan Analisa Lingkungan External tersebut ditentukan strategi yang tepat untuk menjadi critical success factor dengan membagi kedalam 4 (empat) strategi sebagai berikut

1. Strategi SO (mengoptimalkan kekuatan untuk meraih peluang)
Pada kuadran SO merupakan pertemuan dua elemen kekuatan dan peluang sehingga memberikan kemungkinan bagi suatu organisasi untuk bisa berkembang lebih cepat dengan strategi antara lain :
a. Menambah jam pelayanan spesialis
b. Menambah tenaga speslis tetap
c. Mengembangkan program unggulan sesuai dengan perkembangan IPTEKDOK
d. Mengoptimalkan pelayanan dengan kerjasama BPJS Kesehatan dan asuransi lain
2. Strategi ST (Memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman)
Merupakan interaksi antara ancaman dan kekuatan. Di sini harus dilakukan upaya mobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan organisasi untuk memperlunak ancaman dari luar tersebut, bahkan kemudian merubah ancaman itu menjadi sebuah peluang.
a. Membangun kerjasama dengan rumah sakit dan pelayanan kesehatan lain yang merupakan pesaing untuk menjadi mitra kerja
b. Meningkatkan efisiensi belanja barang dan jasa, pengawasan yang ketat penggunaan fasilitas RS
c. Meningkatkan sistem mutu dengan standarisasi, dan sertifikasi untuk menghadapi pelayanan yang bermutu
3. Strategi WO (Menekan kelemahan untuk meraih peluang)
Merupakan interaksi antara kelemahan organisasi dan peluang dari luar. Peluang yang tersedia sangat meyakinkan namun tidak dapat dimanfaatkan karena kekuatan yang ada tidak cukup untuk menggarapnya.
a. Meningkatkan produktivitas setiap tenaga medis, paramedis dan non medis dengan membentuk budaya kerja yang mengarah pada kualitas pelayanan
b. Meningkatkan jumlah jam praktek dokter dengan menambah tenaga medis dengan SMF yang sama
c. Manfaatkan program cost containment untuk efisiensi belanja operasional
d. Optimalkan utilisasi alat kedokteran dengan mejalin kerjasama pihak ketiga/jejaring pelayanan RS
4. Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghadapi ancaman)
Area ini merupaka kondisi yang paling lemah dari semua sel karena merupakan pertemuan antara kelemahan organisasi dengan ancaman dari luar, dan karenanya keputusan yang salah akan membawa bencana yang besar bagi organisasi. Strategi yang harus diambil adalah mengendalikan kerugian, sehingga tidak menjadi lebih parah dari yang diperkirakan.
a. Memberikan perhatian yang lebih besar terhadap keluhan pelanggan untuk ditangani secara tuntas dan professional
b. Melaksanakan promosi program pelayanan unggulan untuk menghadapi pesaing

B. Analisa Dan Mitigasi Risiko

1. Identifikasi Risiko

Sasaran Strategis		Risiko
Perspektif Pendidikan dan Pembelajaran		
1	Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kesehatan	1. SDM yang berkompeten Pindah Ketempat Lain 2. Direkrut oleh instansi lain
2	Terwujudnya sarana prasarana sesuai standar klasifikasi kelas RS	1. Anggaran meningkat 2. SDM tidak sesuai dengan kualifikasi dan kompeten
Perspektif Bisnis		



1	Terwujudnya IT yang terintegrasi	1. Tenaga yang tidak siap dengan penggunaan IT 2. Anggaran yang besar 3. Tidak bisa support dengan kebutuhan eksternal
2	Terwujudnya pelayanan Kesehatan yang bermutu dan terkendali dalam pembiayaan	1. Jadwal pelayanan yang tidak merata 2. Kedatangan DPJP yang terlambat dalam praktek dan visite 3. Tidak tersedia PPK 4. Tarif RS > Tarif Ina CBGs 5. Ketidaksiapan sarpras dan SDM
3	Terwujudnya keypartners yang memadai	Ketidaksiapan SDM, sarpras, anggaran, dalam pelayanan
Persepektif Stakeholders		
1	Terwujudnya Kepuasan Stakholders Internal dan Eksternal	Menurunnya kualitas pelayanan (sarpras dan SDM)
Persepektif Keuangan		
1	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan RS	1. Tidak ada alokasi penganggarn yang tepat 2. Struktur gaji yang tidak memadai

C. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Rumah Sakit

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Prima Husada. Berikut ini beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap kinerja Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo, meliputi:

1. SIMRS tidak optimal
2. Belum efektif dan efisiennya perencanaan kegiatan serta pemanfaatan sarana dan prasarana, sehingga menjadikan biaya tinggi.
3. Fungsi pemasaran yang belum optimal, menjadikan masyarakat tidak mengetahui secara menyeluruh perkembangan dan kemajuan pelayanan rumah sakit.
4. Jumlah kamar yang kurang untuk mengantisipasi semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat kurang mampu akan pelayanan rumah sakit.
5. Luas kamar yang tidak sesuai dengan standar
6. Semakin banyaknya rumah sakit dan klinik kesehatan merupakan pesaing yang perlu diwaspadai.
7. Meningkatnya kesadaran hukum di masyarakat sehingga meningkatkan potensi terjadinya tuntutan hukum.
8. Perubahan organisasi rumah sakit dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi.

D. Analisa Situasi

1. Analisis Pesaing
 - a. Lokasi Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo dikelilingi rumah sakit umum swasta lain yang relatif dekat, dan memiliki kompetensi pelayanan dan fasilitas yang lebih lengkap.
 - b. Terdapat pula sarana pelayanan kesehatan lain yang memberikan pelayanan penunjang, klinik, rumah bersalin, dan lain-lain.
 - c. Jadwal dokter yang merata setiap jam
2. Analisis Stake Holder
 - a. Lokasi Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo berdekatan dengan pusat-pusat industri besar, yang memiliki jumlah karyawan yang cukup banyak sehingga mempunyai potensi sebagai cakupan pelayanan.
 - b. Masyarakat di sekitar Rumah Sakit Prima Husada dengan strata menengah ke atas merupakan pasar potensial bagi cakupan pelayanan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo
 - c. Pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu dijamin oleh Pemerintah melalui program BPJS Kesehatan dan UHC.

- d. PT. Disa Prima Medika memiliki dana yang cukup sebagai sumber dana untuk pengembangan pelayanan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo

E. Rancangan Peta Strategi Balanced Scorecard (BSC)



F. Indikator Kinerja

No	Perspektif	Sasaran Strategis	KPI	
1	Stakeholders	Terciptanya kepuasan stakeholders	1	Tingkat Kepuasan Pasien
			2	Persentasi klomplain yang ditindak lanjuti
			3	Tingkat Kepuasan Pegawai
			4	Tingkat Kepuasan jejaring
2	Proses Bisnis	Terwujudnya pelayanan prima yang terintegrasi	1	Terwujudnya akreditasi paripurna
			2	Capaian Indikator mutu
			3	Capaian PPK dan CP yang ditindak lanjuti
		Terwujudnya jejaring dan system rujukan yang optimal	1	Jumlah jejaring dengan RS, FKTP dan lainnya
			2	Jumlah rujukan dari FKTP yang optimal
		Persentase nilai indikator pelayanan rawat inap rumah sakit yang sesuai standar Kemenkes	3	BOR, AVLOS, BTO, TOI, GDR dan NDR
		Standar Sarana Prasarana	4	Persentase sarana dan prasarana alat kedokteran rumah sakit sesuai dengan yang ditetapkan pada standar Rumah Sakit Kelas C



		Kalibrasi Alat Medis	5	Persentasi sarana prasarana yang terlaibrasi
		Tersedianya Modul SIMRS	6	Modul SIMRS
3	Learning and Growth	Terwujudnya SDM yang kompeten	1	Persentasi SDM medik tetap
			2	Pesentasi SDM Sub. Spesialist
			3	Persentasi SDM yang memiliki kualifikasi perawat intensif care
		Terbangunnya sistem manajemen kinerja terpadu berbasis IT	1	Maturitas IT
		Terwujudnya budaya kinerja	1	Persentase kehadiran pegawai yang tepat waktu
			2	Persentasi pegawai berkinerja baik
4	Financial	Terwujudnya peningkatanrevenue Terwujudnya efisiensi	1	Persentase Peningkatan Revenue
			2	Cost Recovery

G. Rencana Kebutuhan Keuangan

No	Unit	Rencana Pengembangan	Analisa
1	IGD	1. Perluasaan IGD dengan adanya gedung baru 2. Pengeras suara untuk pemanggilan keluarga 3. integrasi rawat jalan maupun rawat inap 4. Penambahan Laptop untuk dokter 5. Penambahan kursi roda yang khusus untuk IGD 6. Membuat farmasi khusus di IGD 7. Hp Rujukan khusus kasus PONEK 8. Media poster menggunakan akrilik	Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo merupakan RS type C yang berada di sekitrar wilayah Pasuruan, sehingga ini menyebabkan banyak masyarakat sekitar yang melakukan pemeriksaan kesehatan di RS ini. Membuat kebutuhan bed di IGD semakin meningkat, karna load pasien yang semakin meninggi sehingga untuk mengurangi penumpukan pasien di IGD tidak menghambat pelayanan terkait pemeriksaan di IGD.
2	ICU	1. Penambahan ruang tunggu bagi keluarga pasien ICU 2. Melengkapi kebutuhan ICU isolasi yang sesuai standart 3. Ruang ICU yang standart dengan alat observasi yang mendukung 4. Diadakannya ruang PICU	1. Mengingat pasien ICU yang merupakan pasien tergolong high care maka penunggu pasien juga membutuhkan kenyamanan. Karena pasien tidak ditunggu di side bed, namun di luar. 2. Memenuhi kebutuhan sesuai dengan standar pelayanan RS Type dengan adanya ruang ICU isolasi. 3. Dibutuhkan media observasi yang mendukung seperti tersedianya TV yang bisa merekam semua monitor pasien secara



			central, serta UPS yang bisa membackup data pasien jika ada pemadaman. 4. Saat ini RS Prima Husada Sukorejo tidak memiliki ruang PICU, di tahun 2023 kebutuhan akan ruang pasien observasi pediatric sangat meningkat dibanding tahun 2022, maka disarankan untuk dilakukan pembangunan PICU. Selama ini jika ada pasien pediatric dilakukan observasi di ruang ICU (dewasa)
3	IKO	1. Ruang Tunggu Kamar Operasi dengan Sistem Informasi Daftar Tunggu Pelayanan Operasi dan Edukasi Keluarga secara elektronik 2. Pelayanan Kamar Operasi dengan C-Arm 3. Tersedianya Depo Farmasi 4. Pemeriksaan Swab Kuman secara berkala	1. Mengingat pasien yang dilakukan operasi merupakan pasien yang sangat high risk yang membuat kecemasan tersendiri pada keluarga/pendamping pasien. Maka diharapkan adanya sebuah media informasi yang dapat menyampaikan kondisi pasien secara terkini di ruang operasi. 2. Dengan adanya pelayanan C-Arm, maka dapat diperkirakan dapat menambah pelayanan dan daftar pasien operasi yang membutuhkan C-Arm 3. Dengan adanya pengajuan depo farmasi sehingga pemberian obat ke IKO tidak terjadi delay
4	IRJA	Pelayanan Poli Eksekutif	RS Prima Husada Sukorejo berada di area industry, dimana banyak pasien yang menggunakan asuransi lain selain BPJS ataupun pasien dengan pembayaran umum. Yang dari kesekian membutuhkan pelayanan poli yang tidak bercampur dengan sistem BPJS. Maka dari itu, dibutuhkan segera untuk ditambahkan Poli Eksekutif yang bisa melayani sesuai dengan standart eksekutif.
5	Maternitas	1. Pembukaan layanan Mom SPA untuk ibu hamil dan pasca melahirkan dan menyiapkan ruangnya	Dengan adanya Mom SPA dapat memberikan layanan yang lebih kepada pasien



		2. Memberikan Hampers pada Ibu bersalin yang melahirkan secara normal/SC	sehingga bisa menaikkan income untuk RS.
6	Neonatologi	1. Layanan Baby SPA 2. Layanan photo new born 3. Penambahan aksesoris foto baby newborn	Dengan adanya Baby SPA dapat memberikan layanan yang lebih kepada pasien sehingga bisa menaikkan income untuk RS. Dan jika ada layanan foto new born, akan memberikan kenangan tersendiri bagi keluarga pasien dan mmeberikan dampak positif bagi peningkatan jumlah pasien di RS Prima Husada Sukorejo khususnya di bagian Neonatologi.
7	NICU	Ruang tunggu untuk ibu yang bayinya sakit dengan dilengkapi fasilitas untuk memompa ASI (ruang ibu menyusui)	Untuk saat ini ruang tunggu khusus tidak ada, jika ada ibu pasien yang sedang di rawat bayi di NICU bisa lebih dekat dengan pasien dan memberika ASI yang fresh pada pasien.
8	IRNA 2A	1. Penambahan ruangan untuk ruang edukasi kepada keluarga pasien 2. Nursecall pasien dibuat Intercom yang berfungsi untuk komunikasi pasien isolasi dengan perawat rumah sakit untuk ruang Isolasi	1. Untuk saat ini, ruang KIE masih tidak ada yang sesuai dengan standar yang dapat memberikan hak privasi dan kenyamanan bagi penerima dan pemberi informasi dan edukasi. 2. Area RS Prima Husada merupakan area yang endemic dengan penyakit TB Paru, namun banyak dari keluarga pasien yang tidak paham akan proses pengobatan serta penularan penyakitnya. Dibuktikan dengan penunggu pasien bisa lebih dari 1 dan masih tidak menggunakan APD serta masih sering keluar masuk area perawatan isolasi. Maka dari itu dibutuhkan pintu smart lock yang membuat keluarga pasien/ penunggu akan patuh dan bisa membantu memutus tali penularan TB Paru itu sendir
9	IRNA 2B	Nurse station yang layak dan nyaman disertai dengan ruang edukasi yang nyaman bagi keluarga pasien yang privasi	Nurse station yang dilengkapi dengan kebutuhan dan luas yang disesuaikan dengan standart dan ruang KIE yang bisa memberikan hak

			privasi dan kenyamanan bagi penerima dan pemberi informasi dan edukasi.
10	IRNA 3A	1. Membuat playground untuk pasien anak 2. Penambahan asesoris perawat untuk visite 3. Penambahan mainan edukasi untuk pasien	Dengan adanya playground yang dekat dengan nurse station bisa bermanfaat untuk pasien anak sehingga tidak menimbulkan trauma hospital. Dan bisa memberikan kenyamanan serta rasa tidak jenuh kepada pasien anak. Dekat dengan nurse station juga bisa memberikan pantauan secara menjangkau kepada perawat Irna Anak (3A)

H. TABEL RINCIAN KEGIATAN

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN
1	SDM	1.Kebutuhan Dokter
		2.Rekrutimen dan Orientasi Dokter
		3.Diklat
		4.Rekredensial dan Kredensialing
		5.Evaluasi Kinerja Dokter
2	PENGEMBANGAN PELAYANAN	1.Pengembangan ruangan hemodialisa
		2.Poli Eksekutif
		3.Ruang tunggu kamar operasi dengan sistem informasi daftar tunggu
		4.Pemberian hampers pada ibu bersalin yang melahirkan
		5.Kegiatan swab kuman
		6.Diadakan doa bersama pada ruangan ICU
		7.Penambahan pada ruangan anggrek (handuk, sabun, cantolan pada kamar mandi)
		8.Penambahan ruangan obat khusus 2B agar tidak tercampur dengan ruangan 2A
		9.Persiapan terkait ERM pada rawat inap
3	PELAYANAN MEDIS	1.Revisi dan Review Pedoman , Panduan, Pelayanan Medis
		2. Review Dan Revisi SPO Pelayanan Medis
		3. Menyusun PROKER TH 2025
		4. Meningkatkan kunjungan
		5. Menyusun kebijakan teknis di bidang pelayanan medis
		6.Mengelola data dan informasi terkait pelayanan medis
		8.Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pelayanan medis
4	MUTU	Mengkoordinasikan kegiatan peningkatan mutu pelayanan
		Melaksanakan budaya keselamatan pasien
		Melaksanakan SSC (di IKO)
		Melaksanakan INM, IMPRS, IMP unit



5	MFK	Meningkatkan mutu kinerja peralatan medis
6	PPI	Pemantauan HH DPJP
		Pemantauan penggunaan APD
		Penempatan pasien oleh DPJP
7	PKRS	Kie ke pasien dan keluarga/individu
8	MONEV	1. Supervisi jam kerja DPJP
		2. Obervasi alur pelayanan irja , irna , igd, isolas, mater, ICU
		3.Survei kepuasan pelanggan terhadap DPJP
		4. Surbei CP Medis : TB,HT,DM
		5. Evaluasi – RTL Kinerja pelayanan medis
		6. Evaluasi kelengkapan RM Pasien
		7. Audit pelayanan BPJS
		2. Rapat Komite Medis
		3. Observasi pelaksanaan Mutu oleh DPJP
		10.Rapatkoordinasi insidentil, bulanan, triwulan, tahunan/rapat kerja
9	RR & PELAPORAN	1.Menyusun laporan pelaksanaan tugas isidentil
		2.Mebuat Laporan , Bulanan , Semeste, Tahunan.
		3.Laporan ekesternal, Kemenkes , Dinkes,Sektoral

I. SASARAN

Tabel Sasaran Kegiatan

No	Rincian Kegiatan	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Jenis	Target / Standart	Indikator Keberhasilan	Ket
1	SDM 1. Rekrutmen Dokter untuk Obgyn , Mata , Dokter KGA 2. Pelatihan eksternal dibidang anak 3. Pelatihan di masing masing dpjp yang dilaporkan ke SDM bagian diklat	1. Kebutuhan dokter obgyn , mata , dokter KGA untuk pemenuhan poli 2. Untuk meningkatkan terkait pemberian asuhan medis pada pasien anak	SDM Dokter spesialis	Untuk pelathan DPJP dapat di lakukan pelatihan eksternal atau pelatihan internal yang di hadari oleh staff yang berhubungan	Terpenuhi	1. Jumlah rekrutmen dokter baru sehingga dapat mengisi slot jam kosong di jadwal poli dan sebagai pengganti dokter yang resign 2. Pelatihan internal dan eksternal untuk meningkatkan kualitas pengetahuan DPJP dan meningkatkan pelayanan pada staff	
2	Pengembangan Pelayanan Keperawatan MASUK MANA? 1. Penambahan unit layanan dialisis 2. Pelaksanaan Doa bersama 3. Penambahan depo farmasi di IGD 4. Penambahan microfon pengeras suara untuk pemanggilan keluarga pasien 5. Penambahan depo farmasi di IKO 6. Kegiatan swab kuman secara berkala 7. Ruang tunggu kamar operasi dengan sistem informasi daftar tunggu pelayanan operasi dan edukasi keluarga secara elektronik	1. Peningkatan kesadaran dan kemauan staf dalam merubah, dan berinovasi dalam pelayanan sehingga tercipta mutu dan keselamatan pasien 2. Pemenuhan dan peningkatan faslitas	Seluruh staff	Internal	Terpenuhi	1. Kritik dan Saran terkait Pelayanan rawat inap yang baik 2. Tingkat kebosanan anak-anak selama masa rawat dapat teralihkan dengan adanya fasilitas terbaru yang tersedia dan memberikan rasa nyaman serta tidak meninggalkan rasa trauma saat di rawat 3. Terciptanya stimulasi anak sesuai dengan kategori usia	

	8. Pelayanan poli eksekutif 9. Memberikan hampers pada ibu bersalin yang melahirkan di rumah sakit phs secara SC/Normal 10. Mengadakan pelatihan penanganan kegawadaruratan maternal dan neonatal simulasi langsung dengan di hadiri dengan dokter obgyn dan dr anak dengan mengundang jejaring 11. Penambahan ascensoris foto baby newborn 12. Penambahan ruang isolasi ICU 13. Relokasi ICU ke gedung baru sesuai dengan standart ruang ICU 14. Pelayanan doa bersama seminggu 2x 15. Penambahan fasilitas pada ruang anggrek (handuk, sabun, cantolan baju) 16. Nursecall intercom untuk komunikasi dengan pasien isolasi dan adanya CCTV 17. Penambahan ruang edukasi kepada keluarga pasien 18. Penambahan ruang obat kusus 2B agar tidak tercampur dengan unit lain						
--	--	--	--	--	--	--	--

3	Pengembangan Pelayanan Dokter Mengelolah dan mengkoordinasi pelayanan medis 1. Menyusun rencana kegiatan bidang pelayanan medik 2. Membantu bagian administrasi dibagian ERM Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dalam bidang pelayanan medis (Khusus Dokter Gigi) 3. Kegiatan Pengembangan Dokter Spesialis (disesuaikan dengan bidang spesialis nya) 4. Melakukan pemantauan , pengawasan dan evaluasi kerja 5. Melakukan survey kepuasan pasien terhadap pelayanan yang di berikan oleh Rumah Sakit 6. Melaksanakan pengelolaan kebutuhan pelayanan medik rawat jalan , pelayanan rawat inap , utilitas peralatan pelayanan 7. Melakukan audit medis dalam kegiatan komite medis dalam kegiatan komiter medis						
4	Fasilitas 1. Pemeliharaan alat 2. Kalibrasi alat Penambahan alat baru	Pemenuhan dan peningkatan kapasitas pemberian asuhan berdasarkan fasilitas yang tersedia dan penambahan fasiitas	1. IPSRS 2. Pihak ketiga RS	1. Internal 2. Eksternal Internal	Terpenuhi	1. Alat bisa digunakan dengan baik dan benar 2. Akurasi alat Tersedianya alat sesuai dengan kebutuhan pasien di unit	

		sebagai upaya peningkatan pemberian dan keberhasilan dalam pelayanan					
--	--	--	--	--	--	--	--

J. Pelaksanaan Kegiatan

Tabel Pelaksanaan Kegiatan

No	Rincian Kegiatan	Cara Melaksanakan Kegiatan	Metode	Media	Jadwal	Bukti Pelaksanaan	Ket
1	Perekrutan SDM sesuai dengan kebutuhan dokter IGD dan Dokter Spesialis	1. Membuat (telaah staf) 2. Pemberitahuan ke seketariatan	Wawan cara Tes tulis	Media sosial	Menyesuikan	Laporan	PIC SDM
2	Pengembangan Pelayanan 1. Penambahan unit layanan dialisis 2. Pelaksanaan Doa bersama 3. Penambahan depo farmasi di IGD (sudah ada) 4. Penambahan microfon pengeras suara untuk pemanggilan keluarga pasien 5. Penambahan depo farmasi di IKO Kegiatan swab kuman secara berkala 6. Ruang tunggu kamar operasi dengan sistem informasi daftar tunggu pelayanan operasi dan edukasi keluarga secara elektronik 7. Pelayanan poli eksekutif 8. Memberikan hampers pada ibu bersalin yang melahirkan	Menambah fasilitas playground dengan berkoordinasi dengan Gudang Umum dan Kabid Keperawatan	Diskusi	Rollpay	1x dalam setahun	Laporan	

	di rumah sakit phs secara SC/Normal						
	9. Mengadakan pelatihan penanganan kegawadaruratan maternal dan neonatal simulasi langsung dengan di hadiri dengan dokter obgyn dan dr anak dengan mengundang jejaring						
	10. Penambahan ascesoris foto baby newborn						
	11. Penambahan ruang isolasi ICU						
	12. Relokasi ICU ke gedung baru sesuai dengan standart ruang ICU						
	13. Pelayanan doa bersama seminggu 2x						
	14. Penambahan fasilitas pada ruang anggrek (handuk, sabun, cantolan baju)						
	15. Penambahan ascesoris perawat untuk dipakai saat tindakan (topi animal, topi anime, gown karakter animal)						
	16. Penambahan mainan edukasi untuk pasien anak						
	17. Penambahan hiasan pada dinding disetiap ruang anak dan nurse station						
	18. Menjadikan unit khusus bangsal bedah						

	19. Nursecall intercom untuk komunikasi dengan pasien isolasi 20. Penambahan ruang edukasi kepada keluarga pasien 21. Penambahan nurse station untuk ruang isolasi 22. Penambahan ruang obat kusus 2B agar tidak tercampur dengan unit lain						
3	MFK	1. Keamanan dan Keselamatan 2. Melakukan pemerilharaan alat 3. Kalibrasi alkes 4. Perbaikan sapras alkes -aldok 5. Pengelolaan bahan dan limbah b3					
4	K3	1. Pemantauan dan laporan MCU 2. Pemantauan dan laporan imunisasi 3. Pemantauan dan laporan PMT 4. Pemantauan dan laporan konseling 5. Pemantauan mangkir kerja dokter 6. Pemantauan dan laporam papran - pajanan 7. Pemantauan dan pelaporam kecelakaan					

		kerja dan penyakit akibat kerja					
5	MUTU	1. Pemiilahan indikator mutu prioritas unit 2. Mengukur Mutu Unit 3. Perbaikan mutu yang belum mencapai standart 4. Mengelolah lkp					
6	PPI	1. Survilance PPI semua unit keperawatan 2. KIE PPI 3. Supervisi dan audit PPI					
7	MONEV	1. Rapat Unit 2. Rapat Koordinasi 3. Rapat Isidentil 4. Rapat Kerja Tahunan					
8	PKRS	1. KIE Individu 2. KIE Kelompok 3. KIE Massa 4. Pengembangan media dan metode promosi kesehatan di semua LIHAT unit 5. Pembinaan Komunikasi berbasis RSPHS					

K. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

Tabel 3.4 Jadwal Pelaksanaan disesuaikan jadwal di atas

No	Kegiatan	Sasaran	Bulan												Tempat	PIC	Sumber Dana	Ket
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	1. Perekrutan SDM sesuai dengan kebutuhan	1. SDM 2. Staff													RS External	SDM	RS	
	2. Mengikuti pelatihan Manajemen bangsal																	
	3. Mengikuti seminar eksternal mengenai rawat inap																	
	4. Mengikuti pelatihan internal rawat inap																	
2	Penambahan alat : 1. Vena Viewer 1 buah 2. Infuse pump sebanyak 3 buah 3. Pulse oximetry anak sebanyak 1 buah 4. Monitor mindrey 1 buah 5. Regulator 10 buah	Gudang Farmasi IPSRS													Irna	IPSRS Pengadaan PT	RS	
3	Pengembangan Pelayanan 1. Penambahan ruangan untuk ruang edukasi kepada keluarga pasien 2. Penambahan ruang untuk dijadikan playground anak-anak 3. Penambahan hiasan pada dinding di setiap ruangan dan nursestation	Ruang IRNA 3A													Irna 3A	Gudang Umum	RS	

L. KEBUTUHAN ANGGARAN

Semua anggaran akan dibiayai dari Rencana Bisnis Anggaran yang telah disetujui oleh PT.Disa Prima Medika

Tabel Kebutuhan Biaya Pelatihan

No	Kegiatan	Internal / Eksternal	Jumlah (satuan)	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Pelatihan PPGDON	Eksternal	1 orang	Rp.3.000.0000	Rp.3.000.0000
2	Update kegawat daruratan Pada Neo dan Anak	Internal	25 Orang	Rp.10.000	Rp. 250.000
3	Seminar Manajemen Resiko di IGD	Eksternal	2 Orang	Rp.2.000.000	Rp. 4.000.000
4	Pelatihan Komunikasi Efektif	Internal	25 Orang	Rp.10.000	Rp. 250.000
5	Pelatihan Knowlage mekanisme koping	Internal	25 Orang	Rp.10.000	Rp. 250.000
6	Pelatihan Internal tentang pelayanan NICU	Internal	9 orang	Rp. 100.000	Rp. 900.000
7	Manajemen BBLR	Eksternal	4 orang	Rp. 3.500.000	Rp. 14.000.000
8	Resusitasi Neonatus	Eksternal	4 orang	Rp. 6.500.000	Rp. 26.000.000
9	Pelatihan Dasar NICU	Eksternal	2 orang	Rp. 15.000.000	Rp. 30.000.000
10	Pelatihan Edukator pada keluarga pasienTBC	Internal	21 staf	Rp. 500.000/Org	Rp.10.500.000
11	Pelatihan Rawat Luka	Internal	21 staf	Rp. 500.000/Org	Rp.10.500.000
12	Pelatihan review pemasangan infus	Internal	21 staf	Rp. 500.000/Org	Rp.10.500.000
13	Pelatihan penulisan SBAR	Internal	21 staf	Rp. 500.000/Org	Rp.10.500.000
14	Management stres pada karyawan	External	21 staf	Rp. 500.000/Org	Rp.10.500.000
15	Pelatihan managemen bangsal	External	1 staf	Rp,3.000.000	Rp,3.000.000
16	Pelatihan perawatan luka post op	External	1 staf	Rp,3.000.000	Rp,3.000.000
17	Pelatihan PPI Dasar	Inhouse training	21 staff	Rp.500.000	Rp.500.000
18	Pelatihan Triage Disaster	Inhouse traning	23 staff	Rp.10.000	Rp.230.000

3.2 PENUNJANG

A. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan Penunjang

No	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1	Perencanaan	a. Review dan revisi regulasi sesuai perundangan yang berlaku - Perdir - Pedoman, panduan - SPO - Alur pelayanan b. Membuat program kerja bidang penunjang c. Membuat RBA
1.	SDM	
1.1.	Kebutuhan SDM	a. Melakukan perhitungan pola ketenagakerjaan pada masing-masing unit penunjang b. Mengumpulkan usulan kebutuhan SDM dari unit c. Merekap dan menganalisis usulan kebutuhan SDM dari unit dan menyerahkan ke SDM d. Mengajukan penambahan jumlah SDM sesuai dengan perhitungan kebutuhan pada masing-masing unit penunjang
1.2.	Orientasi	a. Menyiapkan bahan/materi orientasi khusus unit b. Mengatur jadwal orientasi khusus pada masing-masing unit c. Pemantauan pelaksanaan orientasi khusus yang dilakukan pada masing-masing unit d. Evaluasi orientasi khusus
1.3.	Pendidikan dan pelatihan	a. Melakukan pendataan pada masing-masing unit untuk kebutuhan pendidikan dan pelatihan baik secara internal maupun external b. Melakukan pengajuan pendidikan dan pelatihan kepada bagian diklat rumah sakit
	Pendidikan dan pelatihan wajib	a. Pelatihan PPI b. Pelatihan PMKP c. Pelatihan SKP d. Pelatihan BHD e. Pelatihan <i>Service excellent</i> dan komunikasi efektif f. Pelatihan HPK g. Pelatihan PKRS h. Pelatihan K3 RS/MFK
	Rekam Medis	a. Pelatihan Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik b. Pelatihan koding internal maupun external c. Pelatihan standar akreditasi MRMIK d. Pelatihan inhouse rekam medis e. Pelatihan Pengisian Rekam Medis Elektronik
	Farmasi	a. pelatihan dispensing obat steril External b. Pelatihan dispensing obat steril Internal c. Pelatihan / Study Banding Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) External d. Pelatihan Program Pengendalian resistensi Antimikroba (PPRA) e. Pelatihan Medication Error f. Pelatihan Pengelolaan Benar Obat g. Pelatihan/ study banding Managerial pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai, B3, dan Reagen h. Pelatihan/Webinar Update Kefarmasian TTK dan Apoteker
	GIZI	a. Pelatihan Eksternal PAGT untuk ahli gizi



		b. Pelatihan Eksternal Hygine Sanitasi untuk petugas dapur
	Laundry	a. Pendidikan dan Pelatihan management laundry
	CSSD	a. Pelatihan CSSD dasar eksternal b. Pelatihan CSSD tingkat lanjut
	Laborat	a. pelatihan internal pengambilan sampel darah b. pelatihan internal penanganan sampel darah pasien c. pelatihan internal pre-tranfusi d. pelatihan internal post-tranfusi e. pelatihan internal pelaporan reaksi tranfus f. Pelatihan external Phlebotomi g. Pelatihan external BDRS h. Pelatihan external Trouble shouting Lab i. Pelatihan external K3 Laborat j. Pelatihan esternak Pemantapan Mutu Internal Lab k. Pelatihan mikroskopis Malaria l. Pelatihan mikroskopik TB Paru
	Radiologi	a. Pelatihan C-Arm
3	Pengembangan pelayanan	Pengembangan pelayanan diperuntukkan untuk meningkatkan mutu pelayanan khususnya di penunjang
	Rekam Medis	a. Bridging SIMRS dan SIRANAP untuk update tempat tidur secara otomatis b. Penggunaan mesin APM (Anjungan Pendaftaran Mandiri) untuk pasien pasien yang sudah pernah berobat ke rumah sakit c. Pengajuan adanya sistem pendaftaran online yang dapat diakses oleh pasien/keluarga kapanpun dan dimanapun untuk pasien umum dan asuransi dapat berbasis WEB d. Penyempurnaan untuk Rekam Medis Elektronik Rawat Jalan sesuai aturan akreditasi e. Penggunaan Rekam Medis Elektronik Rawat Inap yang terintegrasi dengan baik f. Perluasan ruang rekam medis untuk penyimpanan dokumen rekam medis
	Farmasi	a. Pemeriksaan hapusan Pus IDO membuat untuk peta kuman b. Pengiriman obat Berbayar Rp 7500/ pengiriman
	GIZI	a. Pemberian edukasi pada Komunitas Persadia b. Cooking Class pada kelas ibu hamil
	Laundry	a. Penambahan mesin pengering
	CSSD	a. Penambahan mesin plasma
	Laborat	a. LIS (Laboratory informasi system) b. Pnematic tube (aerocrom) c. Alat Pemeriksaan SI, TIBC dan Feritin d. BSC (Biosafety Cabinet)
	Radiologi	a. Re-Desain denah atau tempat alat di radiologi untuk panoramik b. Pengiriman hasil bacaan atau tindakan radiologi menggunakan media social dan PACS

B. SASARAN

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KETERANGAN
1.	Kebutuhan SDM Melakukan identifikasi kebutuhan ketenagakerjaan merujuk pada analisis kebutuhan tenaga	Terpenuhinya standar kebutuhan SDM sesuai dengan perhitungan beban kerja	a. SDM b. Seluruh unit penunjang	Internal Rekrutmen yang dilakukan oleh SDM	Terpenuhi	1. Terpenuhinya staf pada masing-masing unit sesuai dengan perhitungan beban kerja 2. Terlaksananya orientasi bagi staf baru di masing-masing unit	
2.	Pendidikan dan pelatihan						
	Pendidikan dan pelatihan wajib a. Pelatihan PPI b. Pelatihan BHD c. Pelatihan Service excellent dan komunikasi efektif d. Pelatihan Mutu dan Keselamatan Pasien e. Pelatihan PKRS f. Pelatihan K3 RS/MFK	Meningkatkan kompetensi staf penunjang	Seluruh staf	Internal	Terpenuhi	1. Staf mampu menerapkan materi-materi pelatihan dalam unit masing-masing 2. Indikator pada masing-masing unit dapat tercapai sesuai dengan program yang telah ditetapkan 3. Adanya supervisi yang dilakukan oleh masing-masing PJ/kepala ruang pada masing-masing program 4. Sertifikat pelatihan	
	Rekam medis						
	a. Pelatihan Penyele nggара	Meningkatkan kompetensi	Staf rekam medis	Eksternal	Terpenuhi	1. petugas dapat menjalankan dan	



	an Rekam Medis Elektronik	petugas rekam medis dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di unit rekam medis				melakukan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan rekam medis elektronik 2. dapat memberikan sosialisasi kepada seluruh unit 3. terbit sertifikat sebagai bukti bahwa petugas telah melakukan pelatihan	
	b. Pelatihan koding internal maupun external	Meningkatkan kompetensi petugas rekam medis dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di unit rekam medis	Staf rekam medis	Eksternal/ internal	Terpenuhi	1. petugas dapat melakukan pengkodean secara benar sesuai dengan ketentuan ICD 10 maupun ICD 9 CM 2. petugas dapat mensosialisasikan pelatihan terkaif kodefikasi 3. terbit sertifikat sebagai bukti bahwa petugas telah melakukan pelatihan	
	c. Pelatihan standar akreditasi MRMIK	Meningkatkan kompetensi petugas rekam medis dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di unit	Staf rekam medis	Eksternal	Terpenuhi	1. petugas dapat memahami elemen-elemen penilaian dalam akreditasi MRMIK dan dapat mengimplementasikan nya 2. terbit sertifikat sebagai	



		rekam medis				bukti bahwa petugas telah melakukan pelatihan	
	d. Pelatihan inhouse rekam medis	Meningkatkan kompetensi petugas rekam medis dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di unit rekam medis	Staf rekam medis	Internal	Terpenuhi	1. petugas dapat memahami fungsi, tujuan dan kegunaan rekam medis 2. menjalankan pengisian rekam medis secara benar, tepat dan akurat dapat dilihat dari analisa kelengkapan dokumen rekam medis 3. terbit sertifikat sebagai bukti bahwa petugas telah melakukan pelatihan	

	e. Pelatihan Pengisian Rekam Medis Elektronik	Meningkatkan kompetensi petugas rekam medis dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di unit rekam medis	Staf rekam	Eksternal	Terpenuhi	1. petugas dapat menjalankan dan melakukan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan rekam medis elektronik 2. dapat memberikan sosialisasi kepada seluruh unit 3. terbit sertifikat sebagai bukti bahwa petugas telah melakukan pelatihan	
	Farmasi						
	a. pelatihan dispensing	Meningkatkan kompetensi petugas farmasi	Staf farmasi	Eksternal	Terpenuhi	1. Apoteker yang telah mengikuti	



	obat steril Eksternal	dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di unit farmasi				kegiatan pelatihan external tersebut dapat lebih tepat dalam menyusun materi rekonstitusi sediaan Steril 2. Sertifikat pelatihan	
	b. Pelatihan dispensing obat steril Internal	Meningkatkan kompetensi petugas farmasi dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di unit farmasi	Staf farmasi	Internal	Terpenuhi	1. Staff apoteker, Tenaga Teknis Kefarmasian, Perawat, dan bidan yang telah mengikuti pelatihan dapat melaksanakan materi yang di sampaikan saat melakukan pekerjaan setiap hari 2. Sertifikat pelatihan	

	c. Pelatihan / Study Banding Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) External	Meningkatkan kompetensi petugas farmasi dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di unit farmasi	Staf farmasi	Eksternal	Terpenuhi	Apoteker yang telah mengikuti kegiatan pelatihan external tersebut dapat mendalami dan memahami update terbaru untuk Program Pengendalian resistensi Antimikroba (PPRA)	
	d. Pelatihan Program Pengendalian resistensi Antimikroba (PPRA)	Meningkatkan kompetensi petugas farmasi dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di unit farmasi	Staf farmasi	Internal	Terpenuhi	Staff Apoteker, Tenaga Teknis Kefarmasian, Perawat, dan bidan yang telah mengikuti pelatihan dapat melaksanakan materi yang di sampaikan saat melakukan	

						pekerjaan setiap hari	
	e. Pelatihan Medication Error	Meningkatkan kompetensi petugas farmasi dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di unit farmasi	Staf farmasi	Internal	Terpenuhi	Staff Apoteker, Tenaga Teknis Kefarmasian, Perawat, dan bidan yang telah mengikuti pelatihan tidak melakukan kejadian Insiden Keselamatan pasien ataupun medication Error	
	f. Pelatihan Pengelolaan Benar Obat	Meningkatkan kompetensi petugas farmasi dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di unit farmasi	Staf farmasi	Internal	Terpenuhi	Staff Apoteker, Tenaga Teknis Kefarmasian, Perawat, dan bidan yang telah mengikuti pelatihan dapat selalu menjamin obat obat yang di pasien sudah mencakup 6 benar obat	

	g. Pelatihan/ study banding Managerial pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai, B3, dan Reagen	Meningkatkan kompetensi petugas farmasi dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di unit farmasi	Staf farmasi	Eksternal	Terpenuhi	1. Apoteker ataupun tenaga Teknis Kefarmasian dapat melakukan inovasi dan perubahan untuk penataan obat, 2. berkurangnya angka obat kosong di Instalasi Farmasi, dan perputaran obat dapat terjadi dengan lancar tanpa ada obat yang expired date	
	h. Pelatihan/ Webinar Update Kefarmasia	Meningkatkan kompetensi petugas farmasi dalam upaya meningkatkan mutu	Staf farmasi	Eksternal	Terpenuhi	Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian dapat membuat rangkuman	



	n TTK dan Apoteker	pelayanan di unit farmasi				materi, melakukan sosialisasi dan implementasi langsung pada pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit	
	GIZI						
	a. Pelatihan Eksternal PAGT untuk ahli gizi	Meningkatkan kompetensi petugas farmasi dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di unit Gizi	Staf gizi	Eksternal	Terpenuhi	1. peningkatan kompetensi petugas gizi dan petugas dapur dalam hal melakukan pengkajian, perencanaan pemberian gizi kepada pasien 2. terbit sertifikat sebagai bukti bahwa petugas telah melakukan pelatihan	

	b. Pelatihan Eksternal Hygiene Sanitasi untuk petugas dapur	Meningkatkan kompetensi petugas farmasi dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di unit Gizi	Staf gizi	Eksternal	Terpenuhi	1. petugas mampu menerapkan budaya hygiene sanitasi dimana dapat dilihat dari supervisi kepala ruang 2. terbit sertifikat sebagai bukti bahwa petugas telah melakukan pelatihan	
	Laundry						
	Pendidikan dan Pelatihan management laundry	a. Untuk meningkatkan skill dan keterampilan staf dalam manajemen linen dan laundry b. meningkatkan pengetahuan dan wawasan	Staf laundry	Eksternal	Terpenuhi	1. petugas dapat memahami manajemen laundry dan mengolah laundry secara menyeluruh 2. terbit sertifikat	



		terkait manajemen linen dan laundry				sebagai bukti bahwa petugas telah melakukan pelatihan	
	CSSD						
	a. Pelatihan CSSD dasar eksternal	a. Untuk meningkatkan skill dan keterampilan dasar staf di CSSD b. meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang CSSD	Staf CSSD	Eksternal	Terpenuhi	1. petugas dapat memahami bagaimana cara pengendalian infeksi secara menyeluruh 2. terbit sertifikat sebagai bukti bahwa petugas telah melakukan pelatihan	
	b. Pelatihan CSSD tingkat lanjut	a. Untuk meningkatkan skill dan keterampilan dasar staf di CSSD b. meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang CSSD	Staf CSSD	Eksternal	Terpenuhi	1. petugas dapat memahami bagaimana cara pengendalian infeksi secara menyeluruh 2. terbit sertifikat sebagai bukti bahwa petugas telah melakukan pelatihan	

	Laborat						
	a. pelatihan internal pengambilan sampel darah	untuk mengurangi kesalahan tentang pengambilan darah	Staf laborat	Internal	Terpenuhi	adanya sertifikat pelatihan petugas semakin kompeten dalam pengambilan sampling darah dapat dilihat dari supervisi karu	
	b. pelatihan internal penanganan sampel	untuk mengetahui tatacara penanganan	Staf laborat	Internal	Terpenuhi	staf diharapkan dapat melakukan	

	darah pasien	sampel darah pasien				pengolahan sampling darah dengan benar dapat dievaluasi oleh karu masing-masing unit	
	c. pelatihan internal pre-tranfusi	untuk mengetahui bagaimana penanganan sampel darah pre-tranfusi	Staf laborat	Internal	Terpen uhi	staf diharapkan dapat melakukan penanganan darah pre op dengan benar dapat dievaluasi oleh karu masing-masing unit	
	d. pelatihan internal post-tranfusi	untuk mengetahui bagaimana penanganan sampel darah prost-tranfusi	Staf laborat	Internal	Terpen uhi	staf diharapkan dapat melakukan penanganan darah post op dengan benar dapat dievaluasi oleh karu masing-masing unit	
	e. pelatihan internal pelaporan reaksi tranfus	untuk meningkatkan pengetahuan terkait dengan reaksi terhadap tranfusi pada pasien	Staf laborat	Internal	Terpen uhi	staf dapat mengidentifika si bila terjadi reaksi transfusi pada pasien dan segera memberikan pertolongan	
	f. Pelatihan external Phlebotomi	diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan keahlian dalam pengambilan sampling pada pasien	Staf laborat	Ekstern al	Terpen uhi	sertifikat kompetensi staf dapat memiliki kompetensi lebih dan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengambilan sampling	

	g. Pelatihan external BDRS	diharapkan dapat meningkatkan pemahaman staf terkait dengan pengolahan bank darah di rumah sakit	Staf laborat	Ekstern al	Terpen uhi	sertifikat kompetensi staf memiliki kemampuan dalam pengolahan bank darah di rumah sakit	
	h. Pelatihan external	diharapkan dapat meningkatkan pemahaman staf	Staf laborat	Ekstern al	Terpen uhi	sertifikat kompetensi staf memiliki	

	Trouble shouting Lab	terkait dengan trouble shouting				kemampuan dalam trouble shouting	
	i. Pelatihan external K3 Laborat	diharapkan dapat meningkatkan pemahaman staf terkait dengan K3 yang ada di unit laborat	Staf laborat	Eksternal	Terpenuhi	sertifikat kompetensi staf memiliki kemampuan dalam K3	
	j. Pelatihan esternal Pemantapan Mutu Internal Lab	diharapkan dapat meningkatkan pemahaman staf terkait mutu pelayanan laborat	Staf laborat	Eksternal	Terpenuhi	sertifikat kompetensi staf memiliki kemampuan dalam hal mutu dan terjadi peningkatan mutu yang signifikan	
	k. Pelatihan mikroskopis Malaria	untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam penentuan kasus malaria	Staf laborat	Eksternal	Terpenuhi	sertifikat kompetensi staf memiliki kemampuan dalam hal penentuan kriteria kasus malaria	
	l. Pelatihan mikroskopik TB Paru	untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam penentuan kasus TB paru	Staf laborat	Eksternal	Terpenuhi	sertifikat kompetensi staf memiliki kemampuan dalam hal penentuan kriteria kasus TB Paru	
	Radiologi						
	Pelatihan C-Arm	meningkatkan kemampuan dan pemahaman staf terhadap penggunaan/pengoperasian alat C-ARM	Staf radiologi	Eksternal/internal	Terpenuhi	staf mampu pengoperasian alat C-Arm sesuai dengan ketentuan yang telah ada	

3	Pengembangan pelayanan						
	Rekam Medis						
	a. Bridging SIMRS dan SIRANAP untuk update tempat tidur secara otomatis	memudahkan petugas dalam memantau ketersediaan tempat tidur di rumah sakit dapat dimanfaatkan pula oleh masyarakat untuk mengetahui jumlah tempat tidur di rumah sakit	IT/Programmer Staf rekam	Internal/eksternal	Terpenuhi	ketersediaan tempat tidur dapat diakses oleh masyarakat	
	b. Penggunaan mesin APM	sesuai dengan masukan dari dewan pengawas	IT/Programmer Staf rekam	Internal/eksternal	Terpenuhi	terpasangnya APM di rumah sakit bagi	



	(Anjungan Pendaftaran Mandiri) untuk pasien pasien yang sudah pernah berobat ke rumah sakit	BPJS Kesehatan, untuk mengurangi antrian pada pendaftaran pasien agar lebih efektif dan efisien dalam pelayanan kepada pasien				pasien BPJS kesehatan tidak adanya penumpukan pasien di loket pendaftaran	
c.	Pengajuan adanya sistem pendaftaran online yang dapat diakses oleh pasien/keluarga kapanpun dan dimanapun untuk pasien umum dan asuransi dapat berbasis WEB	memudahkan pasien dalam mendaftar pelayanan di rumah sakit, efektif dan efisien dalam pendaftaran pasien tidak memerlukan waktu yang cukup lama	IT/Programmer Staf rekam	Internal/eksternal	Terpenuhi	pasien umum dan asuransi dapat mengakses pendaftaran online tersebut yang terhubung dengan sistem	
d.	Penyempurnaan untuk Rekam Medis Elektronik Rawat Jalan sesuai aturan akreditasi	untuk pendokumentasian rekam medis secara akurat, efektif dan efisien serta untuk mewujudkan digitalisasi rekam medis secara menyeluruh	IT/Programmer Staf rekam	Internal/eksternal	Terpenuhi	seluruh dokumen rekam medis tidak ada yang manual	

e.	Penggunaan Rekam Medis Elektronik Rawat Inap yang terintegrasi dengan baik	meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit mewujudkan digitalisasi rekam medis rumah sakit masih menggunakan dokumen rekam medis secara manual	IT/Programmer Staf rekam	Internal/eksternal	Terpenuhi	seluruh dokumen rekam medis tidak ada yang manual	
f.	Perluasan ruang rekam medis untuk penyimpanan dokumen	penyimpanan dokumen rekam medis yang masih manual sebelum dilakukan retensi	Staf rekam	internal	Terpenuhi	tersedianya ruangan untuk penyimpanan dokumen rekam medis hard file	

	rekam medis						
	Farmasi						
	a. Pemeriksaan hapusan Pus IDO membuat untuk peta kuman	Untuk memiliki refrensi pola peta kuman di 2024	Staf farmasi	internal	Terpenuhi	dapat mengidentifikasi jenis kuman yang ada diunit	
	b. Pengiriman obat Berbayar Rp 7500/ pengiriman	Untuk Mengurangi respon time pelayanan resep dengan cara pasien tidak alam antri obat	Pihak ke tiga	external	Terpenuhi	MOU dengan pihak beetu terkait dengan ongkos kirim	
	GIZI						
	a. Pemberian edukasi pada Komunitas Persadia	Untuk memberikan edukasi gizi kepada penyakit DM via online(Grup Wa)	pasien DM	internal	Terpenuhi	terlaksananya edukasi secara kelompok di masyarakat/ pasien yang pernah dirawat di RS	
	b. Cooking Class pada kelas ibu hamil	Untuk memberikan edukasi secara langsung kepada ibu hamil dan lansia	ibu hamil	internal	Terpenuhi	terlaksananya cooking class saat di kegiatan senam hamil	
	Laundry						
	Penambahan mesin pengering	Pemenuhan pengering load linen meningkat	Staf laundry	internal	terpenuhi	terpenuhinya penambahan mesin pengering di rumah sakit untuk mendukung proses pelayanan laundry	

	CSSD						
	Penambahan mesin plasma	Untuk memenuhi mesin steril untuk alat semi critical	Staf laundry	internal	terpenuhi	terpenuhinya mesin plasma di unit CSSD dan dapat digunakan maksimal	
	Laborat						
	a. LIS (Laboratory informasi system)	Untuk mengurangi kesalahan input hasil laboratorium	Staf laborat	internal/ eksternal	terpenuhi	terlaksananya program LIS secara menyeluruh	
	b. Pnematic tube (aerocrom)	Untuk mengurangi waktu pengiriman sampel	Staf laborat	internal	terpenuhi		

c. Alat Pemeriksaan SI, TIBC dan Feritin	Untuk mengurangi waktu pengiriman sampel	Staf laborat	internal	terpenuhi	terlaksananya pemeriksaan SI, TIBC dan Feritin untuk pasien HD sehingga tidak adanya sampel yang dirujuk
d. BSC (Biosafety Cabinet)	Untuk pengerjaan sampel preparat gram dan BTA	Staf laborat	internal	terpenuhi	
e. instalasi air RO			internal	terpenuhi	
Radiologi					
a. Re-Desain denah atau tempat alat di radiologi untuk panoramik	Re-Desain denah atau tempat alat di radiologi untuk panoramik	Merubah tata letak tempat ruangan panoramic	internal	terpenuhi	alat panoramik terletak di area radiologi
b. Pengiriman hasil bacaan atau tindakan radiologi menggunakan media social dan PACS	Pengiriman hasil bacaan atau tindakan radiologi menggunakan media social dan PACS	Mengirim hasil bacaan atau tindakan ke RS lain atau rujukan dan pembacaan dokter	internal	terpenuhi	terlaksananya program PACS di radiologi sehingga tidak ada lagi pencetakan hasil radiologi melalui film

C. Cara Melaksanakan Kegiatan

No	Rincian Kegiatan	Cara Melaksanakan Kegiatan	Metode	Media	Jadwal	Bukti Pelaksanaan	Ket
1.	Kebutuhan SDM a. Menghitung kebutuhan jumlah SDM pada masing-masing unit b. Melakukan pengajuan penambahan SDM jika diperlukan	1. Melakukan telaah staf pada masing-masing unit 2. Melakukan perhitungan beban kerja pada masing-masing unit 3. Melakukan koordinasi dengan SDM	Wawancara Perhitungan beban kerja	Flyer kebutuhan SDM yang diunggah melalui media sosial	2 kali dalam setahun	Kebutuhan staf terpenuhi sesuai dengan standar	
2.	Pendidikan dan pelatihan						
	Pendidikan dan pelatihan wajib a. Pelatihan PPI b. Pelatihan BHD	1. Melakukan pengajuan Pendidikan dan pelatihan kepada diklat	Diklat internal	Seminar/workshop	1 tahun sekali	1. Laporan masing-masing unit 2. Sertifikat pelaksanaan	



	c. Pelatihan <i>Service excellent</i> dan komunikasi efektif d. Pelatihan Mutu dan Keselamatan Pasien e. Pelatihan PKRS f. Pelatihan K3 RS/MFK	2. Membuat TOR					
--	---	----------------	--	--	--	--	--

Rekam medis							
a. Pelatihan Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik	1. Melakukan pengajuan Pendidikan dan pelatihan kepada diklat 2. Mengikuti pelatihan sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan	Diklat eksternal	Seminar/workshop	1 tahun sekali	1. Laporan 2. Sertifikat		
b. Pelatihan koding internal maupun external	1. Melakukan pengajuan Pendidikan dan pelatihan kepada diklat 2. Pengajuan TOR	Diklat external/internal	Seminar/workshop	1 tahun sekali	1. Laporan 2. Sertifikat		
c. Pelatihan standar akreditasi MRMIK	1. Melakukan pengajuan Pendidikan dan pelatihan kepada diklat 2. Mengikuti pelatihan sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan	Diklat eksternal	Seminar/workshop	1 tahun sekali	1. Laporan 2. Sertifikat		
d. Pelatihan inhouse rekam medis	1. Melakukan pengajuan Pendidikan dan pelatihan kepada diklat	Diklat internal	Seminar/workshop	1 tahun sekali	1. Laporan 2. Sertifikat		



		2. Pengajuan TOR					
	e. Pelatihan Pengisian Rekam Medis Elektronik	1. Melakukan pengajuan Pendidikan dan pelatihan kepada diklat 2. Mengikuti pelatihan sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan	Diklat eksternal	Seminar/workshop	1 tahun sekali	1. Laporan 2. Sertifikat	

	Farmasi						
	a. pelatihan dispensing obat steril Eksternal	1. Melakukan pengajuan Pendidikan dan pelatihan kepada diklat 2. Mengikuti pelatihan sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan	Diklat Eksternal	Seminar/workshop	1 tahun sekali		
	b. Pelatihan dispensing obat steril Internal	1. Melakukan pengajuan Pendidikan dan pelatihan kepada diklat 2. Pengajuan TOR	Diklat Internal	Seminar/workshop	1 tahun sekali		
	c. Pelatihan / Study Banding Program Pegendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) External	1. Melakukan pengajuan Pendidikan dan pelatihan kepada diklat 2. Mengikuti pelatihan sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan	Diklat Eksternal	Seminar/workshop	1 tahun sekali		
	d. Pelatihan Program Pengendalian resistensi Antimikroba (PPRA)	1. Melakukan pengajuan Pendidikan dan pelatihan	Diklat Internal	Seminar/workshop	1 tahun sekali		



		kepada diklat 2. Pengajuan TOR				
	e. Pelatihan Medication Error	1. Melakukan pengajuan Pendidikan dan pelatihan kepada diklat 2. Pengajuan TOR	Diklat Internal	Seminar/workshop	1 tahun sekali	
	f. Pelatihan Pengelolaan Benar Obat	1. Melakukan pengajuan Pendidikan dan pelatihan kepada diklat 2. Pengajuan TOR	Diklat Internal	Seminar/workshop	1 tahun sekali	

	g. Pelatihan/ study banding Managerial pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai, B3, dan Reagen	1. Melakukan pengajuan Pendidikan dan pelatihan kepada diklat 2. Mengikuti pelatihan sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan	Diklat Eksternal	Seminar/workshop	1 tahun sekali	1. Laporan 2. Sertifikat	
	h. Pelatihan/Webinar Update Kefarmasian TTK dan Apoteker	1. Melakukan pengajuan Pendidikan dan pelatihan kepada diklat 2. Pengajuan TOR	Diklat Internal	Seminar/workshop	1 tahun sekali	1. Laporan 2. Sertifikat	
	GIZI					1. Laporan 2. Sertifikat	
	a. Pelatihan Eksternal PAGT untuk ahli gizi	1. Melakukan pengajuan Pendidikan dan pelatihan kepada diklat 2. Mengikuti pelatihan sesuai dengan jadwal	Diklat Eksternal	Seminar/workshop	1 tahun sekali	1. Laporan 2. Sertifikat	



		yang telah di tetapkan					
	b. Pelatihan Eksternal Hygine Sanitasi untuk petugas dapur	1. Melakukan pengajuan Pendidikan dan pelatihan kepada diklat 2. Mengikuti pelatihan sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan	Diklat Eksternal	Seminar/workshop	1 tahun sekali	1. Laporan 2. Sertifikat	
	Laundry					1. Laporan 2. Sertifikat	
	Pendidikan dan Pelatihan management laundry	1. Melakukan pengajuan Pendidikan dan pelatihan kepada diklat 2. Mengikuti pelatihan sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan	Diklat Eksternal	Seminar/workshop	1 tahun sekali	1. Laporan 2. Sertifikat	

	CSSD						
	a. Pelatihan CSSD dasar eksternal	1. Melakukan pengajuan Pendidikan dan pelatihan kepada diklat 2. Mengikuti pelatihan sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan	Diklat Eksternal	Seminar/workshop	1 tahun sekali	1. Laporan 2. Sertifikat	
	b. Pelatihan CSSD tingkat lanjut	1. Melakukan pengajuan Pendidikan dan pelatihan kepada diklat 2. Mengikuti pelatihan sesuai dengan jadwal	Diklat Eksternal	Seminar/workshop	1 tahun sekali	1. Laporan 2. Sertifikat	



		yang telah di tetapkan					
	Laborat				1 tahun sekali	1. Laporan 2. Sertifikat	
	a. pelatihan internal pengambilan sampel darah	1. Melakukan pengajuan Pendidikan dan pelatihan kepada diklat 2. Pengajuan TOR	Diklat Internal	Seminar/worksho p	1 tahun sekali	1. Laporan 2. Sertifikat	
	b. pelatihan internal penanganan sampel darah pasien	1. Melakukan pengajuan Pendidikan dan pelatihan kepada diklat 2. Pengajuan TOR	Diklat Internal	Seminar/worksho p	1 tahun sekali	1. Laporan 2. Sertifikat	
	c. pelatihan internal pre- tranfusi	1. Melakukan pengajuan Pendidikan dan pelatihan kepada diklat 2. Pengajuan TOR	Diklat Internal	Seminar/worksho p	1 tahun sekali	1. Laporan 2. Sertifikat	
	d. pelatihan internal post- tranfusi	1. Melakukan pengajuan Pendidikan dan pelatihan kepada diklat 2. Pengajuan TOR	Diklat Internal	Seminar/worksho p	1 tahun sekali	1. Laporan 2. Sertifikat	
	e. pelatihan internal pelaporan reaksi tranfus	1. Melakukan pengajuan Pendidikan dan pelatihan kepada diklat 2. Pengajuan TOR	Diklat Internal	Seminar/worksho p	1 tahun sekali	1. Laporan 2. Sertifikat	
	f. Pelatihan external Phlebotomi	1. Melakukan pengajuan Pendidikan dan pelatihan kepada diklat 2. Mengikuti pelatihan sesuai dengan jadwal	Diklat Ekternal	Seminar/worksho p	1 tahun sekali	1. Laporan 2. Sertifikat	

		yang telah di tetapkan					
	g. Pelatihan external BDRS	1. Melakukan pengajuan Pendidikan dan pelatihan kepada diklat 2. Mengikuti pelatihan sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan	Diklat Ekternal	Seminar/workshop	1 tahun sekali	1. Laporan 2. Sertifikat	
	h. Pelatihan external Trouble shouting Lab	1. Melakukan pengajuan Pendidikan dan pelatihan kepada diklat 2. Mengikuti pelatihan sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan	Diklat Ekternal	Seminar/workshop	1 tahun sekali	1. Laporan 2. Sertifikat	
	i. Pelatihan external K3 Laborat	1. Melakukan pengajuan Pendidikan dan pelatihan kepada diklat 2. Mengikuti pelatihan sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan	Diklat Ekternal	Seminar/workshop	1 tahun sekali	1. Laporan 2. Sertifikat	
	j. Pelatihan esternal Pemantapan Mutu Internal Lab	1. Melakukan pengajuan Pendidikan dan pelatihan kepada diklat 2. Mengikuti pelatihan sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan	Diklat Ekternal	Seminar/workshop	1 tahun sekali	1. Laporan 2. Sertifikat	
	k. Pelatihan mikroskopis Malaria	1. Melakukan pengajuan Pendidikan dan	Diklat Ekternal	Seminar/workshop	1 tahun sekali	1. Laporan 2. Sertifikat	



		pelatihan kepada diklat 2. Mengikuti pelatihan sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan					
	I. Pelatihan mikroskopik TB Paru	1. Melakukan pengajuan Pendidikan dan pelatihan kepada diklat 2. Mengikuti pelatihan sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan	Diklat Ekternal	Seminar/workshop	1 tahun sekali	1. Laporan 2. Sertifikat	
	Radiologi				1 tahun sekali	1. Laporan 2. Sertifikat	
	Pelatihan C-Arm	1. Melakukan pengajuan Pendidikan dan pelatihan kepada diklat 2. Mengikuti pelatihan sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan	Diklat Ekternal	Seminar/workshop	1 tahun sekali	1. Laporan 2. Sertifikat	
3.	Pengembangan pelayanan						
	Rekam Medis						
	a. Bridging SIMRS dan SIRANAP untuk update tempat tidur secara otomatis	1. Melakukan identifikasi kebutuhan 2. Melakukan koordinasi dengan tim IT, unit terkait 3. Melakukan pengajuan kepada programmer	Internal	SIM RS	Tahun 2025	Update TT dapat secara online	

b. Penggunaan mesin APM (Anjungan Pendaftaran Mandiri) untuk pasien pasien yang sudah pernah berobat ke rumah sakit	1. Melakukan identifikasi kebutuhan aplikasi 2. Melakukan koordinasi dengan tim IT 3. Membuat alur pemakaian APM 4. Melakukan pengajuan kepada programmer	Internal	SIM RS	Tahun 2025	1. Waktu tunggu pendaftaran tidak memanjang 2. Mesin APM tersedia di rumah sakit	
5. Pengajuan adanya sistem pendaftaran online yang dapat diakses oleh pasien/keluarga kapanpun dan dimanapun untuk pasien umum dan asuransi dapat berbasis WEB	1. Melakukan identifikasi kebutuhan aplikasi 2. Melakukan koordinasi dengan tim IT 3. Melakukan pengajuan kepada programmer	Internal	SIM RS	Tahun 2025	1. Terdapat website/aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat/pasien 2. Pasien melakukan pendaftaran melalui website/aplikasi yang telah disediakan	
4. Penyempurnaan untuk Rekam Medis Elektronik Rawat Jalan sesuai aturan akreditasi	1. Melakukan identifikasi kebutuhan kebutuhan E-RM rawat jalan 2. Melakukan koordinasi dengan tim programer 3. Melakukan pengajuan kepada programmer	Internal	SIM RS	Tahun 2025	Seluruh rekam medis rawat jalan menggunakan E-RM	
4. Penggunaan Rekam Medis Elektronik Rawat Inap yang terintegrasi dengan baik	1. Melakukan identifikasi kebutuhan kebutuhan E-RM rawat inap 2. Melakukan koordinasi dengan tim programer 3. Melakukan pengajuan kepada programmer	Internal	SIM RS	Tahun 2025	Seluruh rekam medis rawat inap menggunakan E-RM	
4. Perluasan ruang rekam medis untuk penyimpanan	1. Melakukan koordinasi dengan tim CS	Internal	Koordinasi	Maret 2025	Tidak terjadi penumpukan dokumen rekam medis di ruangan rekam medis	

	dokumen rekam medis	2. Melakukan pemidahan berkas RM					
	Farmasi						
	a. Pemeriksaan hapusan Pus IDO membuat untuk peta kuman	Melakukan pengajuan					
	b. Pengiriman obat Berbayar Rp 7500/ pengiriman	Melakukan koordinasi untuk dengan pihak beetu	Internal	Koordinasi	Tahun 2025	Pembiayaan pengiriman obat menjadi 7500 setiap pengiriman	
	GIZI						
	a. Pemberian edukasi pada Komunitas Persadia	1. Melakukan screening kebutuhan pasien 2. Berkoordinasi dengan tim PKRS	Internal	Edukasi kelompok	Tahun 2025	1. Terjalannya komunikasi dengan komuniyas persadia 2. Laporan hasil edukasi	
	b. Cooking Class pada kelas ibu hamil	1. Melakukan identifikasi kebutuhan peserta untuk cooking class 2. Membuar TOR 3. Melakukan koordinasi dengan PKRS	Internal	Edukasi kelompok	Tahun 2025	1. Terselenggaranya cooking clas pada kelas ibu hamil 2. Laporan penyelenggaraan	
	Laundry						
	Penambahan mesin pengering	1. Melakukan identifikasi jumlah linen setiap bulannya 2. Melakukan pengajuan penambahan mesin pengering	Internal	Alat	Maret 2025	Tersedianya mesin pengering di laundry	

	CSSD						
	Penambahan mesin plasma	1. Melakukan identifikasi jumlah linen setiap bulannya 2. Melakukan pengajuan penambahan mesin plasma	Internal	Alat	Maret 2025	Tersedianya mesin pengering di CSSD	
	Laborat						
	a. LIS (Laboratory informasi system)	Melakukan pengajuan penambahan software	Internal	Software	Tahun 2025	Terlaksananya sistem LIS di unit labobat	

b. Pnematic tube (aerocrom)	Melakukan pengajuan penambahan alat	Internal	Alat	Tahun 2025	Tersedianya alat pnematic tube di laborat dan dapat digunakan
c. Alat Pemeriksaan SI, TIBC dan Feritin	Melakukan pengajuan penambahan alat	Internal	Alat	Tahun 2025	Tersedianya alat SI, TIBC dan Feritin di laborat dan dapat digunakan
d. BSC (Biosafety Cabinet)	Melakukan pengajuan penambahan alat	Internal	Alat	Tahun 2025	Tersedianya alat BSC di laborat dan dapat digunakan
Radiologi					
a. Re-Desain denah atau tempat alat di radiologi untuk panoramic		Internal	-	Tahun 2025	Pemeriksaan panoramic tersedia dia ruang radiologi
b. Pengiriman hasil bacaan atau tindakan radiologi menggunakan media social dan PACS	Melakukan pengajuan penambahan software	Internal	Software	Tahun 2025	Terlaksananya sistem PACS

D. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

N O	KEGIAT AN	SASAR AN	BULAN												TE MP AT	PIC	SUMBE R DANA	K E T
			De c- 24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	1 2			
1	Pelatiha n Internal PPI	seluruh staf penunja ng														RS PH S	Dikla t	RS/PT
2	Pelatiha n Internal BHD	seluruh staf penunja ng														RS PH S	Dikla t	RS/PT
3	Pelatiha n internal service excellen t dan komunis kasi efektif	seluruh staf penunja ng														RS PH S	Dikla t	RS/PT
4	Pelatiha n internal mutu dan keselam	seluruh staf penunja ng														RS PH S	Dikla t	RS/PT

Jl. Raya Surabaya – Malang Km 54, Desa Lemahbang Kec. Sukorejo – Pasuruan
Telp : 0343 – 6745000 | Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com



10	Penyempurnaan untuk Rekam Medis Elektronik Rawat Jalan sesuai aturan akreditasi	IT/programer staf rekam medis																RS PH S	Programer	RS/PT	
11	Penggunaan Rekam Medis Elektronik Rawat Inap yang terintegrasi dengan baik	IT/programer staf rekam medis																RS PH S	Programer	RS/PT	
12	Perluasan ruang rekam medis untuk penyimpanan dokumen rekam medis	staf rekam medis																RS PH S	Programer	RS/PT	
13	Pelatihan Penyeleenggaraan Rekam Medis Elektronik	staf rekam medis																RS PH S	Diklat	RS/PT	
14	Pelatihan coding Eksternal	staf rekam medis																External	Diklat	RS/PT	
15	Pelatihan coding Internal	staf rekam medis																RS PH S	Diklat	RS/PT	



16	Pelatihan standar akreditasi MRMK	staf rekam medis																Ext ernal	Diklat	RS/PT	
17	Pelatihan inhouse rekam medis	seluruh staf rumah sakit																RS PH S	Diklat	RS/PT	
18	Pelatihan Pengisian Rekam Medis Elektronik	seluruh staf rumah sakit																RS PH S	Diklat	RS/PT	
19	Pembuatan Leaflet Edukasi	seluruh staf rumah sakit																RS PH S	PKR S	RS/PT	
20	Pengajuan Form RM yang tidak bisa dimasukkan di ERM	staf rekam medis																RS PH S	RM	RS/PT	
21	pelatihan dispensing obat steril External	Apoteker																Ext ernal	Diklat	RS/PT	
22	Pelatihan dispensing obat steril Internal	Semua Apoteker, Tenaga Teknis Kefarmasian, Bidan, dan Perawat																RS PH S	Diklat	RS/PT	

23	pelatihan / Study Banding Program Pengendalian Resistensi Antimikroba	Apoteker & Dokter																Ext ernal	Diklat	RS/ PT	
----	---	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------	-----------	--

Jl. Raya Surabaya – Malang Km 54, Desa Lemahbang Kec. Sukorejo – Pasuruan
Telp : 0343 – 6745000 | Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com



3 2	Melakukan kegiatan pengadaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai, B3, dan Reagen dalam 1 Tahun	Kebutu- han Ruma- h Sakit selam- a 1 tahun																RS PH S	Farm- asi	RS /PT	
3 3	Pengiriman obat Berbayar Rp 7500/ pengiriman	beetu																RS PH S	Farm- asi	RS /PT	
3 4	Kredensial	Semu- a Apote- ker & Tenag- a Teknis Kefar- masia- n																RS PH S	Farm- asi	RS /PT	
3 5	Rapat Bulanan Farmasi	Semu- a Apote- ker & Tenag- a Teknis Kefar- masia- n																RS PH S	Farm- asi	RS /PT	
3 6	Rapat Triwulan Komite Farmasi Terapi	Apote- ker dan Dokter																RS PH S	Farm- asi	RS /PT	
3 7	Rapat Triwulan Program Pengendalian resistensi Antimikroba (PPRA)	Apote- ker dan Dokter																RS PH S	Farm- asi	RS /PT	
3 8	Supervisi Tahunan Distributor	Distrib- utor yang sudah melak- ukan IKS denga- n PT Disa Prima Medik- a																RS PH S	Farm- asi	RS /PT	
3 9	Kalibrasi LAF	2 Ruang LAF Farma- si																RS PH S	Atem	RS /PT	
4 0	Printer thermal untuk KPO	Instala- si Farma- si, Unit																RS PH S	Farm- asi	RS /PT	

Jl. Raya Surabaya – Malang Km 54, Desa Lemahbang Kec. Sukorejo – Pasuruan
Telp : 0343 – 6745000 | Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com

53	Chemical Clax Soft 20 L	Staf Laundry															RS PH S	Laundry	RS /PT
54	Pewangi Kispray 5L	Staf Laundry															RS PH S	Laundry	RS /PT
55	Penambahan stok linen	Staf Laundry															RS PH S	Laundry	RS /PT
56	Mengetahui kelayakan Linen	Staf Laundry															RS PH S	Laundry	RS /PT
57	Pelatihan CSSD dasar eksternal	Staf CSSD															Ext ern al	Dikla t	RS /PT
58	Pelatihan CSSD tingkat lanjut	Staf CSSD															Ext ern al	Dikla t	RS /PT
59	Penambahan mesin sterilisasi semi critical	Unit Sterili sasi															RS PH S	CSS D	RS /PT
60	Penambahan pemotong kertas	Unit Sterili sasi															RS PH S	CSS D	RS /PT
61	Metracide	Unit Sterili sasi															RS PH S	CSS D	RS /PT
62	Metrazyme	Unit Sterili sasi															RS PH S	CSS D	RS /PT
63	Pouches flat 10cm/200m	Unit Sterili sasi															RS PH S	CSS D	RS /PT
64	Pouches flat 15cm/200m	Unit Sterili sasi															RS PH S	CSS D	RS /PT
65	Pouches flat 20cm/200m	Unit Sterili sasi															RS PH S	CSS D	RS /PT
66	Pouches gussete 15cmx5cm/100 M	Unit Sterili sasi															RS PH S	CSS D	RS /PT
67	Pouches gussete 20cmx5cm/100M	Unit Sterili sasi															RS PH S	CSS D	RS /PT
68	Pouches gussete 25X6,5/100M	Unit Sterili sasi															RS PH S	CSS D	RS /PT
69	Indikator strip	Unit Sterili sasi															RS PH S	CSS D	RS /PT
70	Indikator tapes	Unit Sterili sasi															RS PH S	CSS D	RS /PT

71	pelatihan internal pengambilan sampel darah	Staf Laborat														RS PH S	Dikla t	RS /PT
72	pelatihan internal penanganan sampel darah pasien	Staf Laborat														RS PH S	Dikla t	RS /PT
73	pelatihan internal pre-tranfusi	Staf Laborat														RS PH S	Dikla t	RS /PT
74	pelatihan internal post-tranfusi	Staf Laborat														RS PH S	Dikla t	RS /PT
75	pelatihan internal pelaporan reaksi tranfusi	Staf Laborat														RS PH S	Dikla t	RS /PT
76	Pelatihan external Phlebotomi	Staf Laborat														Ext ern al	Dikla t	RS /PT
77	Pelatihan external BDRS	Staf Laborat														Ext ern al	Dikla t	RS /PT
78	Pelatihan external Trouble shouting Lab	Staf Laborat														Ext ern al	Dikla t	RS /PT
79	Pelatihan external K3 Laborat	Staf Laborat														Ext ern al	Dikla t	RS /PT
80	Pelatihan external Pemantapan Mutu Internal Lab	Staf Laborat														Ext ern al	Dikla t	RS /PT
81	Pelatihan mikroskopis Malaria	Staf Laborat														Ext ern al	Dikla t	RS /PT
82	Pelatihan mikroskopik TB Paru	Staf Laborat														Ext ern al	Dikla t	RS /PT
83	pembukaan stand donor darah di wilayah rumah sakit	Staf Laborat dan PMI														RS PH S	Dikla t	RS /PT
84	LIS (Laboratory informasi system)	Staf Laborat														RS PH S	Progr amer	RS /PT
85	Pnematic tube (aerocrom)	Staf Laborat														RS PH S	Labo rat	RS /PT
86	pemeriksaan SI,TIBC,FERITIN	Staf Laborat														RS PH S	Labo rat	RS /PT
87	BIOSAFETY CABINET (BSC)	Staf Laborat														RS PH S	Labo rat	RS /PT
88	alkes dan BMHP laborat dan BDRS	Staf Laborat														RS PH S	Labo rat	RS /PT



89	pemantauan mutu external laborat	Staf Laborat																			Ext ernal	Mutu	RS /PT	
90	pemantauan mutu external BDRS	Staf Laborat																			Ext ernal	Mutu	RS /PT	
91	pelatihan C-ARM	Staf Radiologi																			Ext ernal	Dikla t	RS /PT	
92	Printer dry pix fuji film 2 tray	Staf Radiologi																			RS PH S	Radiologi	RS /PT	
93	Dry pix Fuji film (CT-Scan)	Staf Radiologi																			RS PH S	Radiologi	RS /PT	
94	Film blue inject (X-Ray)	Staf Radiologi																			RS PH S	Radiologi	RS /PT	
95	Paper USG	Staf Radiologi																			RS PH S	Radiologi	RS /PT	
96	USG GeL	Staf Radiologi																			RS PH S	Radiologi	RS /PT	
97	Re-Desain denah atau tempat alat di radiologi untuk panoramik	Staf Radiologi																			RS PH S	Radiologi	RS /PT	
98	Pengiriman hasil bacaan atau tindakan radiologi menggunakan media social dan PACS	Staf Radiologi																			RS PH S	Progr amer	RS /PT	

E. Kebutuhan Anggaran

Semua anggaran akan dibiayai dari anggaran RS Prima Husada Sukorejo yang telah disetujui oleh PT.DPM dengan rincian sebagaimana terlampir :

Perhitungan biaya berdasarkan pemakaian rata -rata perbulan sebagai berikut:

No	Bahan	Rata-rata/Bulan	Kebutuhan 1Th		Harga Satuan	Total
			Jumlah	Satuan		
1	Pengadaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai, B3, dan Reagen	12	12	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai, B3, dan Reagen	2.500.000.000	30.000.000.000
2	Chemical Clax Buit Lite 20 L	40L	480	Chemical (dalam liter)	1.271.500	610.320.000
3	Chemical Clax 100 Ob 20 L	40L	480	Chemical (dalam liter)	1.530.000	734.400.000
4	Chemical Clax Sunril Ultra 25 L	50L	600	Chemical (dalam liter)	1.445.000	867.000.000
5	Chemical Clax Soft 20 L	40L	480	Chemical (dalam liter)	742.050	356.184.000
6	Pewangi Kispray 5L	8L	96	Chemical (dalam liter)	250.000	24.000.000
7	Metracide	1 botol	12	chemical (botol)	2.925.000	35.100.000
8	Metrazyme	10 sachet	5	chemical (bungkus 1 bungkus 25 sachet)	860.000	4.300.000
9	Pouches flat 10cm/200m	1 ½ roll	13	BMHP (Roll)	895.000	11.635.000
10	Pouches flat 15cm/200m	1 roll	10	BMHP (Roll)	1.355.000	13.550.000
11	Pouches flat 20cm/200m	1 ½ roll	13	BMHP (Roll)	1.645.000	21.385.000
12	Pouches gussete 15cmx5cm/100 M	1 ½ roll	13	BMHP (Roll)	1.130.000	14.690.000
13	Pouches gussete 20cmx5cm/100 M	1 roll	10	BMHP (Roll)	1.360.000	13.600.000
14	Pouches gussete 25X6,5/100M	1 ½ roll	13	BMHP (Roll)	1.650.000	21.450.000

15	Indikator strip (instrumen di luar)	2 pcs	21	BMHP (Box) (PCS)	650.000	13.650.000
16	Indikator tapes (instrumen didalam)	2 pack	21	BMHP (PACK)	120.000	2.520.000
17	alkes dan BMHP laborat dan BDRS	1	1	alkes	500.000.000	500.000.000
18	Dry pix Fuji film (CT-Scan)	15	15	bmhp 1 box (isi 5)	2.192.250	32.883.750
19	Film blue inject (X-Ray)	15	15	bmhp 1 box (isi 10)	451.000	6.765.000
20	Paper USG	15	15	bmhp 2 box (1 box isi 5)	193.140	2.897.100
21	USG GeL	12	12	bmhp 1 jirigen	170.940	2.051.280
TOTAL						3.288.381.130

Kebutuhan biaya pengembangan SDM Penunjang 2025

No	Kegiatan/ rincian kegiatan	Internal/ Eksternal	Jumlah	Harga Satuan	Total
1	Pelatihan Internal PPI	pelatihan internal	129	10.000	1.290.000
2	Pelatihan Internal BHD	pelatihan internal	129	10.000	1.290.000
3	Pelatihan internal <i>service excellent</i> dan komunikasi efektif	pelatihan internal	129	10.000	1.290.000
4	Pelatihan internal mutu dan keselamatan pasien	pelatihan internal	129	10.000	1.290.000
5	Pelatihan internal PKRS	pelatihan internal	129	15.000	1.935.000
6	Pelatihan internal K3 RS/MFK	pelatihan internal	129	15.000	1.935.000
7	Pelatihan Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik	pelatihan eksternal	2	3.500.000	7.000.000
8	Pelatihan coding Eksternal	pelatihan eksternal	2	3.500.000	7.000.000
9	Pelatihan coding Internal	pelatihan internal	10	5.000	50.000
10	Pelatihan standar akreditasi MRMIK	pelatihan eksternal	2	3.500.000	7.000.000
11	Pelatihan inhouse rekam medis	pelatihan eksternal	10	5.000	50.000
12	Pelatihan Pengisian Rekam Medis Elektronik	pelatihan eksternal	400	5.000	2.000.000
13	pelatihan dispensing obat steril External	pelatihan eksternal	2	8.000.000	16.000.000
14	Pelatihan dispensing obat steril Internal	pelatihan internal	300	1.000	300.000
15	pelatihan / Study Banding Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) External	pelatihan eksternal	2	1.000.000	2.000.000



16	Pelatihan Program Pengendalian resistensi Antimikroba (PPRA) Internal	pelatihan internal	300	1.000	300.000
17	Pelatihan Medication Error	pelatihan internal	300	1.000	300.000
18	Pelatihan Pengelolaan Benar Obat	pelatihan internal	300	1.000	300.000
19	Pelatihan/ study banding Managerial pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai, B3, dan Reagen	pelatihan ekternal	1	300.000	300.000
20	pelatihan/Webinar Update Kefarmasian TTK dan Apoteker	pelatihan / Webinar eksternal pengajuan ke bagian diklat	6	150.000	900.000
21	Pelatihan Ekternal PAGT untuk ahli gizi	pelatihan eksternal pengajuan ke bagian diklat	5	1.500.000	7.500.000
22	Pelatihan Ekternal Hygine Sanitasi untuk petugas dapur	pelatihan eksternal pengajuan ke bagian diklat	3	550.000	1.650.000
23	Pendidikan dan Pelatihan management laundry	pelatihan eksternal pengajuan ke bagian diklat	1	6.000.000	6.000.000
24	Pelatihan CSSD dasar eksternal	pelatihan eksternal pengajuan ke bagian diklat	1	7.000.000	7.000.000
25	Pelatihan CSSD tingkat lanjut	pelatihan eksternal pengajuan ke bagian diklat	1	9.000.000	9.000.000
26	pelatihan internal pengambilan sampel darah	pelatihan internal	199	15.000	2.985.000
27	pelatihan internal penanganan sampel darah pasien	pelatihan internal	199	15.000	2.985.000
28	pelatihan internal pre-tranfusi	pelatihan internal	199	15.000	2.985.000
29	pelatihan internal post-tranfusi	pelatihan internal	199	15.000	2.985.000

30	pelatihan internal pelaporan reaksi tranfusi	pelatihan internal	199	15.000	2.985.000
31	Pelatihan external Phlebotomi	pelatihan eksternal pengajuan ke bagian diklat	1	6.500.000	6.500.000
32	Pelatihan external BDRS	pelatihan eksternal pengajuan ke bagian diklat	2	4.500.000	9.000.000
33	Pelatihan external Trouble shouting Lab	pelatihan eksternal pengajuan ke bagian diklat	1	2.500.000	2.500.000
34	Pelatihan external K3 Laborat	pelatihan eksternal pengajuan ke bagian diklat	1	2.500.000	2.500.000
35	Pelatihan esternak Pemantapan Mutu Internal Lab	pelatihan eksternal pengajuan ke bagian diklat	1	2.500.000	2.500.000
36	Pelatihan mikroskopis Malaria	pelatihan eksternal pengajuan ke bagian diklat	2	3.700.000	7.400.000
37	Pelatihan mikroskopik TB Paru	pelatihan eksternal pengajuan ke bagian diklat	2	3.700.000	7.400.000
38	pelatihan C-ARM	pelatihan eksternal pengajuan ke bagian diklat	8	2.000.000	16.000.000
TOTAL					152.405.000

Kebutuhan Anggaran Peralatan

No	Kegiatan	Kebutuhan	Harga Satuan	Total
1	Printer thermal untuk KPO	3	1.000.000	3.000.000
2	Kebutuhan Alat Oven Listrik	1	15.000.000	15.000.000
3	Kebutuhan Alat Insect Killer	1	400.000	400.000
4	Penambahan mesin pengering	1	150.000.000	150.000.000
5	Penambahan mesin sterilisasi semi critical	1	460.000.000	460.000.000
6	Penambahan pemotong kertas	1	500.000	500.000
7	Pnematic tube (aerocrom)	4	17.000.000	68.000.000
8	pemeriksaan SI,TIBC,FERITIN	1	50.000.000	50.000.000
9	BIOSAFETY CABINET (BSC)	1	100.000.000	100.000.000
10	Printer dry pix fuji film 2 tray	1	110.000.000	110.000.000
Total				956.900.000

Kebutuhan Anggaran Pengembangan unit

No	Kegiatan	Kebutuhan	Harga Satuan	Total
1	Bridging SIMRS dan SIRANAP untuk update tempat tidur secara otomatis	1	-	-
2	Penggunaan mesin APM (Anjungan Pendaftaran Mandiri) untuk pasien pasien yang sudah pernah berobat	1	20.000.000	20.000.000
3	Pengajuan adanya sistem pendaftaran online yang dapat diakses oleh pasien/keluarga kapanpun dan dimanapun untuk pasien umum dan asuransi dapat berbasis WEB	1	25.000.000	25.000.000
4	Penyempurnaan untuk Rekam Medis Elektronik Rawat Jalan sesuai aturan akreditasi	1	-	-
5	Penggunaan Rekam Medis Elektronik Rawat Inap yang terintegrasi dengan baik	1	-	-
6	Perluasan ruang rekam medis untuk penyimpanan dokumen rekam medis	1	-	-
7	Pemeriksaan hapusan Pus IDO membuat untuk peta kuman	1	10.000.000	10.000.000
8	Pengiriman obat Berbayar Rp 7500/ pengiriman	1	-	-
9	Cooking Class	20	200.000	4.000.000
10	LIS (Laboratory informasi system)	1	200.000.000	200.000.000
11	Pengiriman hasil bacaan atau tindakan radiologi menggunakan media social dan PACS	1	853.700.000	853.700.000
			TOTAL	1.112.700.000

3.3 UMUM dan KEUANGAN

N o	UNIT	Bidang	Kegiatan	Jumlah (Satuan)	Jenis	Satuan Harga (Rp)	USULAN ANGGARAN	TOTAL USURAN ANGGAR AN
1	Kasir	SDM	Pelatihan microsoft office	1x	pelatihan	Rp 315.000	Rp 315.000	2.090.000
2	Kasir	SDM	Pelatihan Komunikasi Efektif	1x	pelatihan	Rp 385.000	Rp 385.000	
3	Kasir	SDM	Pelatihan SIMRS	1x	pelatihan	Rp 315.000	Rp 315.000	
4	Kasir	SDM	Pelatihan pembuatan laporan keuangan / akuntansi	1x	pelatihan	Rp 385.000	Rp 385.000	
5	Kasir	SDM	Edukasi Jenis cara Bayar ke Pasien/ pengunjung	setiap bulan	Sosialisasi	Rp 320.000	Rp 320.000	
6	Kasir	SDM	Pemahaman petugas terhadap kelengkapan berkas yang harus dipenuhi pasien Jaminan	setiap bulan	Sosialisasi	Rp 270.000	Rp 270.000	
7	Kasir	Pengembangan Pelayanan	Pemberian bukti bayar atau kwitansi softfile	1x	Pengembangan	Rp 100.000	Rp 100.000	
8	Asura nsi Center	SDM	Penambahan SDM bagi staf yang akan resign	Menyesuai kan Staff yang akan resign	Rekrutmen	Mengikuti dana SDM	PT Disa Prima Medika	63.000.00 0
9	Asura nsi Center	SDM	Pelatihan kodefikasi diagnosa dan tindakan berdasarkan ICD 10 dan ICD 9 CM bedasarkan pending dan audit bpjs kesehatan.	2	Koding ICD 10 dan 9CM	Rp 5.500.000	Rp 11.000.000	
10	Asura nsi Center	SDM	Pelatihan pencegahan kecurangan klaim (Fraud).	2	Pencegahan fraud	Rp 5.500.000	Rp 11.000.000	
11	Asura nsi Center	SDM	Pelatihan komunikasi efektif terkait dengan komunikasi DPJP	2	Komunikasi efektif	Rp 2.000.000	Rp 4.000.000	

12	Asura nsi Center	SDM	Pelatihan terkait dengan kebijakan BPJS/penjamin lainnya	2	Kebijakan penjamin asuransi swasta dan Bpjs Kes	Rp 2.000.000	Rp 4.000.000	
13	Asura nsi Center	SDM	Pelatihan Microsoft office (terutama Microsoft excel)	2	Microsoft excel	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000	
14	Asura nsi Center	Fasilitas	Pemeliharaan peralatan	Komputer : 10 Scanner : 4 Printer 1	Maintenance alat	Mengikuti dana IT	PT Disa Prima Medika	
15	Asura nsi Center	Fasilitas	Komputer	3	Komputer AOC	Rp 6.000.000	Rp 18.000.000	
16	Asura nsi Center	Fasilitas	Meja komputer	4	Meja komputer informa	Rp 1.500.000	Rp 6.000.000	
17	Asura nsi Center	Fasilitas	Kursi Kantor	7	Kursi kantor informa	Rp 1.000.000	Rp 7.000.000	
18	Asura nsi Center	Pengembangan Pelayanan	Pengembangan pelayanan bridging tagihan antara SIM RS dengan E-klaim	1	Bridging SIM RS dan Eklaim	Mengikuti dana programmer	PT Disa Prima Medika	
19	Asura nsi Center	Pengembangan Pelayanan	Pengembangan pelayanan E-RM pada rawat inap	1	ERM pada rawat inap	Mengikuti dana programmer	PT Disa Prima Medika	
20	Asura nsi Center	SDM	Orientasi umum dan pelatihan internal terkait akreditasi MIRMK	1	pelatiham	mengikuti dana SDM	PT Disa Prima Medika	
21	Huma s Marke ting	SDM	Pengajuan diklat untuk humas marketing	2	pelatihan	Rp 2.000.000	Rp 4.000.000	Rp25.140.000
22	Huma s	FASILITAS	pengajuan kalibrasi alkes	1x	pengajuan	ikut anggaran IPSRS		

	Marke ting						
23	Huma s Marke ting	FASILITAS	pengajuan kapasitas data di link humas marketing	1x	pengajuan	ikut dengan anggaran IT	
24	Huma s Marke ting	FASILITAS	pengajuan terapi wicara untuk anak	144	fisioterapi	Rp 12.000	Rp 1.728.000
25	Huma s Marke ting	PELAYANA N HUMAS MARKETIN G	Kunjungan Perusahaan	144	BBM	Rp 12.000	Rp 1.728.000
26	Huma s Marke ting	PELAYANA N HUMAS MARKETIN G	kunjungan FKTP (klinik, PKM, bidan praktek, dokter praktek mandiri)	144	BBM	Rp 12.000	Rp 1.728.000
27	Huma s Marke ting	PELAYANA N HUMAS MARKETIN G	kunjungan inhouse clinic perusahaan	144	BBM	Rp 12.000	Rp 1.728.000
28	Huma s Marke ting	PELAYANA N HUMAS MARKETIN G	kunjungan yayasan disabilitas	144	BBM	Rp 12.000	Rp 1.728.000
29	Huma s Marke ting	PELAYANA N HUMAS MARKETIN G	kunjungan PNM, kejaksaan, pengadaan	1	BBM	-	PT DPM
30	Huma s Marke ting	PENGEMBA NGAN LAYANAN	<i>konten MCU perusahaan</i>	-	publikasi	-	-

31	Humas Marketing	PENGEMBA NGAN LAYANAN	<i>konten layanan in house clinic</i>	-	presentasi/ publikasi	-	-
32	Humas Marketing	PENGEMBA NGAN LAYANAN	konten layanan kesehatan dirumah sakit prima husada sukorejo	-	presentasi/ publikasi	-	-
33	Humas Marketing	PENGEMBA NGAN LAYANAN	ebook digital marketing	-	presentasi/ publikasi	-	-
34	Humas Marketing	PENGEMBA NGAN LAYANAN	promosi layanan disetiao tanggal kebesaran misal 17 agustu		presentasi/ publikasi		PT DPM
35	Humas Marketing	PENGEMBA NGAN LAYANAN	hospital expo	-	presentasi/ sosialisasi	-	-
36	Humas Marketing	PENGEMBA NGAN LAYANAN	acara gathering dengan pihak eksternal	250	konsumsi(makanan,snack)	Rp 50.000	Rp 12.500.000
37	Humas Marketing	MUTU	kenaikan jumlah pasien dari program humas marketing (MCU, inhouse clinic)	-	presentasi/ sosialisasi	-	-
38	Humas Marketing	MUTU	kenaikan jumlah kerjasama dengan pihak eksternal		kerjasama		
39	Humas Marketing	keselamatan pasien	MCU gratis Lansia	-	pemeriksaan	-	-

40	Huma s Marke ting	K3RS	MCU berkala staf		sample	-	-	
41	Huma s Marke ting	PPI	pemantauan cuci tangan	-	survey			
42	Securi ty	SDM	Pelatihan Gada madya	1 Staf	Diklat eksternal	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	
43	Securi ty	Fasilitas	Hardisk Eksternal (Seagate One Touch Eksternal SSD) 1 TB	1 Staf	Alat penunjang	Rp 1.590.000	Rp 1.590.000	Rp 8.762.000
44	Securi ty	Fasilitas	HT WLN	5	Alat penunjang	Rp 300.000	Rp 1.500.000	
45	Securi ty	Fasilitas	Kerta F4 SIDU 1 Rim (KTR dan Patroli Keamanan)	12	Alat penunjang Pelaporan	Rp 56.000	Rp 672.000	
46	Cleani ng Servic e	SDM	Rekrutmen staff			Anggaran ikut SDM	Anggaran ikut SDM	Rp 301.553.0 00
47	Cleani ng Servic e	SDM	Pendidikan & Pelatihan terkait K3RS		Diklat Internal	Anggaran ikut SDM	Anggaran ikut SDM	
48	Cleani ng Servic e	SDM	Pendidikan & Pelatihan Terkait PPI		Diklat internal	Anggaran ikut SDM	Anggaran ikut SDM	
49	Cleani ng Servic e	SDM	Pendidikan & Pelatihan Terkait Mutu		Diklat internal	Anggaran ikut SDM	Anggaran ikut SDM	

50	Cleaning Service	SDM	Evaluasi Kinerja					
51	Cleaning Service	Fasilitas pemeliharaan	Melakukan Monitoring, pengisian cek list, isi billing	Sesuai kebutuhan	Internal			
52	Cleaning Service	Fasilitas pengajuan	Melakukan monitoring Kelengkapan Alat2 kerja dan penunjang operasional CS dan Tukang	Rincian berada dalam proker CS Tahun 2025	Biaya fasilitas alat kerja	Rp 301.553.000	Rp 301.553.000	
53	Cleaning Service	Pengembangan Dan Pelayanan	Cleaning Terkait Gedung Baru	All Staf CS	0	Rp -	Rp -	
54	Cleaning Service	Keselamatan Pasien	Peningkatan Komunikasi Antar Petugas & Resiko infeksi Akibat Lingkungan RS	All Staf CS	0	Rp -	Rp -	
55	Cleaning Service	Keselamatan Kerja	Kepatuhan Penggunaan APD dan Cuci Tangan	PJ PPI & K3 Cleaning Service	0	Rp -	Rp -	
56	Parkir	Fasilitas	Relokasi mesin karcis dan portal motor - Pemindahan CCTV dan Setting	1	Renovasi bangunan / pemindahan titik CCTV parkir	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 12.460.000
57	Parkir	Fasilitas	Pemeliharaan ruang kerja	12	Pemeliharaan	Rp -	Rp -	
58	Parkir	Fasilitas	Pemeliharaan AC	2	Pemeliharaan	Rp -	Rp -	
59	Parkir	Fasilitas	Pengadaan kursi pos motor	2	Pengadaan barang	Rp 500.000	Rp 1.000.000	

60	Parkir	Fasilitas	Pengajuan Jas hujan	13	Pengadaan barang	Rp 150.000	Rp 1.950.000	
61	Parkir	Fasilitas	Pengajuan Sepatu boot	13	Pengadaan barang	Rp 100.000	Rp 1.300.000	
62	Parkir	Fasilitas	Pengajuan Topi	13	Pengadaan barang	Rp 60.000	Rp 780.000	
63	Parkir	Fasilitas	Pengajuan HT	3	Pengadaan barang	Rp 200.000	Rp 600.000	
64	Parkir	Fasilitas	Pengajuan Rantai	1	Pengadaan barang	Rp 400.000	Rp 400.000	
65	Parkir	Fasilitas	Pemeliharaan komputer dan portal oleh tim IT dan vendor	0	Pemeliharaan	Rp -	Rp -	
66	Parkir	Fasilitas	Mempermanenkan parkir motor di area IPAL	0	Pemeliharaan	Rp -	Rp -	
67	Parkir	Fasilitas	Penambahan rambu-rambu parkir	0	Pengadaan barang	Rp -	Rp -	
68	Parkir	Fasilitas	Parkir dokter (A4) + laminating	10	Pengadaan barang	Rp 10.000	Rp 100.000	
69	Parkir	Fasilitas	Dilarang parkir disini (A4) + laminating	10	Pengadaan barang	Rp 10.000	Rp 100.000	
70	Parkir	Fasilitas	Parkir penuh (Banner 0.5 m x 2m)	4	Pengadaan barang	Rp 50.000	Rp 200.000	
71	Parkir	Fasilitas	Selain ambulance di larang parkir (A3)	2	Pengadaan barang	Rp 15.000	Rp 30.000	
72	Parkir	Fasilitas	Dispenser	1	Pengadaan barang	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 46.150.000
73	IT	SDM	Pelatihan jaringan	1	Pelatihan	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	
74	IT	Fasilitas	Pergantian UPS	25	Penggantian alat	Rp 650.000	Rp 16.250.000	
75	IT	Fasilitas	Pergantian HDD ke SSD	7	Penggantian alat	Rp 700.000	Rp 4.900.000	

76	IT	Fasilitas	Penambahan RAM	10	Penambahan RAM	Rp 400.000	Rp 4.000.000	
77	IT	Fasilitas	Penambahan CCTV	1	Penambahan CCTV	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	
78	IT	Fasilitas	NAS (Network Atached Storage)	1	Penambahan NAS	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	
79	IT	Fasilitas	Hardisk untuk NAS	4	Penambahan NAS	Rp 1.000.000	Rp 4.000.000	
80	IT	Pengembangan Pelayanan	Pengembangan Pelayanan	0	Updating SIMRS dan ERM IRNA	Mengikuti timeline programmer	Mengikuti timeline programmer	
81	IT	Kepatuhan Mutu	Kepatuhan Mutu	0	Peningkatan Mutu	Peningkatan kepatuhan mutu	Peningkatan kepatuhan mutu	
82	IT	Kelengkapan APD	Kelengkapan APD	0	Melindungi APD	Kepatuhan penggunaan APD	Kepatuhan penggunaan APD	
83	SDM	SDM	Perencanaan Kebutuhan Tenaga	4 x 8 (kabid + dir+sdm)	Internal	Rp 5.000	Rp 160.000	Rp 367.639.000
84	SDM	SDM	Rekrutmen	15	Internal	Rp 25.000	Rp 375.000	
85	SDM	SDM	Orientasi	15	Internal	Rp 25.000	Rp 375.000	
86	SDM	SDM	Kontrak Kerja	1	Internal	Rp 2.999.000	Rp 2.999.000	
87	SDM	SDM	Kredensial dan Re-Kredensial	2	Internal	Rp 500.000	Rp 1.000.000	
88	SDM	SDM	Legalitas	0	Internal	Rp -	Rp -	
89	SDM	SDM	Pendidikan dan Pelatihan	1	Eksternal	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000	
90	SDM	SDM		1	Eksternal	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	
91	SDM	SDM		1	Eksternal	Rp 5.500.000	Rp 5.500.000	

92	SDM	SDM		1	Eksternal	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000	
93	SDM	SDM		50	Eksternal	Rp 50.000	Rp 2.500.000	
94	SDM	SDM		60	Eksternal	Rp 500.000	Rp 30.000.000	
95	SDM	SDM	Evaluasi Kinerja	0	Internal	Rp -	Rp -	
96	SDM	SDM	Persuratan	0	Internal	Rp -	Rp -	
97	SDM	SDM	Penggajian	0	Internal	Rp -	Rp -	
98	SDM	SDM	Rapat	8x12 = 96	Internal	Rp 5.000	Rp 480.000	
99	SDM	SDM	MONEV /Supervisi	2	Internal	Rp 50.000	Rp 100.000	
100	SDM	SDM	Couching & Counseling	2	Internal	Rp 50.000	Rp 100.000	
101	SDM	SDM	Pengangkatan Pegawai Tetap	0	Internal	Rp -	Rp -	
102	SDM	Fasilitas	Atribut Karyawan	450	Internal	Rp 400.000	Rp 180.000.000	
103	SDM	Mutu	Mutu SDM	0	Internal	Rp -	Rp -	
104	SDM	SDM	Kesehatan & Keselamatan Kerja	450	Internal	Rp 285.000	Rp 128.250.000	
105	SDM	SDM		450	Internal	Rp -	Rp -	
106	SDM	Fasilitas	Pengembangan Layanan : E-Kepegawaian	0	Eksternal	Rp -	Rp -	
107	SDM	SDM	Reward & Panishment Staf	5 x 4 = 20	Internal	Rp 300.000	Rp 6.000.000	

108	Driver	SDM	Pelatihan mengemudi	Diklat eksternal	Anggaran ikut SDM	Anggaran ikut SDM	Anggaran ikut SDM	Rp 144.600.000
109	Driver	SDM	Pendidikan & Pelatihan terkait K3RS	Diklat Internal	Anggaran ikut SDM	Anggaran ikut SDM	Anggaran ikut SDM	
110	Driver	SDM	Pendidikan & Pelatihan Terkait PPI	Diklat internal	Anggaran ikut SDM	Anggaran ikut SDM	Anggaran ikut SDM	
111	Driver	SDM	Pelatihan Mengemudi Ambulance	Diklat eksternal	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	
112	Driver	SDM	Sim B1	Surat ijin Mengemudi	Rp 1.700.000	Rp 6.800.000	Rp 6.800.000	
113	Driver	Fasilitas	1.Pemeliharaan alat 2.Penggantian atau penambahan	Internal	Anggaran mengikuti IPSRS	Anggaran Mengikuti IPSRS	Anggaran Mengikuti IPSRS	
114	Driver	Fasilitas	Stacer	Biaya fasilitas alat kerja	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	
115	Driver	Fasilitas	Ban	Biaya fasilitas alat kerja	Rp 1.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	
116	Driver	Fasilitas	Kebutuhan BBM	BBM	Rp 10.000	Rp 70.000.000	Rp 70.000.000	
117	Driver	Fasilitas	Service Kendaraan	Servis rutin	Rp 3.500.000	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000	
118	Driver	Fasilitas	Uji Kir	uji kir	Rp 400.000	Rp 800.000	Rp 800.000	
119	Driver	Fasilitas	Pajak tahunan	Pajak	Rp 3.500.000	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000	
120	Driver	Fasilitas	Ruangan Driver		Anggaran ikut IPSRS	Anggaran ikut IPSRS	Anggaran ikut IPSRS	

12 1	Driver	Mutu	(1).Angka ketersediaan ambulance sesuai kebutuhan 30 menit.(2)Kepuasan penggunaan ambulance.(3) Kepatuhan melaksanakan Dekontaminasi Ambulance.(4) Respon time driver ambulance 5 menit	Diklat internal	Anggaran ikut komite Mutu	Anggaran ikut Komite Mutu	Anggaran ikut Komite Mutu	
12 2	Driver	Keselamatan Pasien	1.Identifikasi pasien.2.Peningkatan komunikasi efektif.3.Pengurangan resiko pasien jatuh.	Diklat internal	Anggaran ikut K3	Anggaran ikut K3	Anggaran ikut K3	
12 3	Driver	Keselamatan Kerja	KepatuhabPenggunaan APD	Anggaran PPI	Anggaran PPI	Anggaran PPI	Anggaran PPI	
12 4	Driver	Keselamatan Kerja	Penggunaan APD	Diklat internal	Anggaran ikut K3	Anggaran ikut K3	Anggaran ikut K3	
12 5	IPSRS	SDM	Pelatihan Kelistrikan	4 Staf	Diklat internal	Anggaran Proker SDM	Anggaran Proker SDM	Rp 13.273.30 5.000
12 6	IPSRS	SDM	Pelatihan pengelolaan peralatan medis	2 Staff	Diklat Eksternal	Anggaran Proker SDM	Anggaran Proker SDM	
12 7	IPSRS	SDM	Pelatihan MFK	Semua Staff yang terlibat	Diklat Eksternal / Internal	Anggaran Proker SDM	Anggaran Proker SDM	
12 8	IPSRS	Fasilitas Lift	Pemeliharaan	4	Pemeliharaan Lift	Rp 12.000.000	Rp 48.000.000	
12 9	IPSRS	Fasilitas AC	Pemeliharaan	30	Pemeliharaan AC central	Rp 2.000.000	Rp 60.000.000	
13 0	IPSRS	Fasilitas Listrik dan Air	Memastikan ketersediaan air dan listrik 24 jam setiap hari dan dalam waktu 7 hari dalam seminggu	12	biaya pembayaran listrik dan air	Rp 120.000.000	Rp 1.440.000.000	
13 1	IPSRS	Fasilitas handrail,Nurse call.	Penyediaan fasilitas pendukung yang aman seperti handrail, penggantian nurse call, perbaikan handrail kamar mandi dsb	150	Penyediaan handrail,Nurse call dll	Rp 2.500.000	Rp 375.000.000	
13 2	IPSRS	Fasilitas dan lingkungan (ronde fasilitas)	Pemeriksaan fasilitas dan lingkungan (ronde fasilitas)	5	Pemeriksaan Rutin	Rp 1.000.000	Rp 5.000.000	

13 3	IPSRs	Fasilitas gas medis	Penyimpanan dan penanganan bahan-bahan mudah terbakar, misal gas medis	2	Pembuatan ruang / penyimpanan gas medis dan gas elpigi	Rp 20.000.000	Rp 40.000.000
	IPSRs	Fasilitas gas medis	Penyediaan kebutuhan gas medis	1	penyediaan gas medis dan gas lpg	Rp 950.000.000	Rp 950.000.000
13 4	IPSRs	Fasilitas potensi bahaya dan risiko kebakaran	Pengendalian potensi bahaya dan risiko kebakaran berkaitan konstruksi-pengadaan pintu/bangunan tahan api	200	Pembuatan tembok dan pintu anti api	Rp 7.800.000	Rp 1.560.000.000
13 5	IPSRs	Fasilitas rambu/jalur evakuasi	Penyediaan rambu/jalur evakuasi	40	Rambu Rambu jalur evakuasi	Rp 100.000	Rp 4.000.000
13 6	IPSRs	Fasilitas sistem pemadam kebakaran aktif maupun pasif	Penyediaan, inventarisasi, pemeriksaan, uji coba, pemeliharaan serta perbaikan (jika terdapat ada yang rusak) sistem pemadam kebakaran baik aktif maupun pasif	ATK, Sparepart (sil karet,selang nosel,)	Sistem pemadam kebakaran	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000
13 7	IPSRs	Fasilitas pengendalian asap dan api	Sistem pemisahan dan kompartemenisasi pengendalian asap dan api	(dapur,gen set)	Pembuatan cerobong dan pembuatan dinding anti api	Rp 5.000.000	Rp 15.000.000
13 8	IPSRs	Fasilitas kebutuhan dan uji fungsi alat medis	Identifikasi dan penilaian kebutuhan alat medik dan uji fungsi	380 alkes	Supervisi	Rp 200.000	Rp 200.000
13 9	IPSRs	Fasilitas recall alkes	Inventarisasi, pemeriksaan, pengujian, pemeliharaan dan perbaikan (jika ada alkes yang rusak) alkes serta recall alkes	380 alkes	Laporan Inventaris,hasil pemeriksaan,pengujian alat medis (supervisi)	Rp 480.000.000	Rp 480.000.000

140	IPSRS	Fasilitas palabelan tuas kontrol sistem kelistrikan RS	Inventarisasi, pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan, pemeriksaan, uji fungsi / pengujian , palabelan tuas kontrol sistem kelistrikan RS	25 panel	Supervisi	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000
141	IPSRS	Fasilitas sistem pengairan di rs	Inventarisasi, pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan, pemeriksaan, uji fungsi / pengujian , sistem pengairan di RS	2 unit	Supervisi	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000
142	IPSRS	Fasilitas utilitas	Inventarisasi, pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan, pemeriksaan, uji fungsi/ pengujian , sistem utilitas lainnya di RS	lift, genset, ac central, pemadam api	Supervisi	Rp 700.000.000	Rp 700.000.000
143	IPSRS	Fasilitas cadangan air bersih	Inventarisasi, pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan, pemeriksaan, uji fungsi/ pengujian , sistem cadangan air bersih alternatif	1 perusahaan	MOU dengan Vendor air isi ulang	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
144	IPSRS	Fasilitas kelistrikan	Inventarisasi, pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan, pemeriksaan, uji fungsi/ pengujian , sistem cadangan listrik alternatif / genset	2 genset	Supervisi	Rp 50.000.000	Rp 100.000.000
145	IPSRS	Fasilitas BBM genset	BBM Solar pada genset/ tahun	21600	Supervisi	Rp 7.800	Rp 168.480.000
146	IPSRS	Fasilitas Handril kamar mandi	Penyediaan handrail di kamar mandi pasien	360	handrail	Rp 1.200.000	Rp 432.000.000
147	IPSRS	Fasilitas Alat kesehatan	Kalibrasi	380	Alkes	Rp 900.000	Rp 342.000.000

148	IPSRS	Fasilitas Filter Air Minum	Pemeliharaan	120	Filter Air Bersih	Rp 100.000	Rp 12.000.000	
149	IPSRS	Fasilitas Alat kesehatan	Pengadaan Alat Simulator ECG	1 Unit	Alat Kerja	Rp 7.000.000	Rp 7.000.000	
150	IPSRS	Fasilitas Genset	Pemeliharaan Accu Genset,Olie dan filter olie	2 Unit	Accu Genset,olie dan filter	Rp 30.000.000	Rp 60.000.000	
151	IPSRS	Pengembangan Pelayanan	Pembangunan Gedung 6 lantai dan Pemasangan Sistem Utilitas di dalamnya	6 lantai	Kelengkapan di ruang lantai 6	Rp 6.000.000.000	Rp 6.000.000.000	
152	IPSRS	Fasilitas CCTV	Pemeliharaan Sistem Keamanan RS meliputi CCTV dan sebagainya	CCTV di area RS	Supervisi	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	
153	IPSRS	Gedung	Pembersihan gedung bagian luar	Gedung rs	Supervisi	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
154	IPSRS	Ecoenzyme	Pembuatan Ecoenzyme	365	Gula Pasir dll	Rp 25.000	Rp 9.125.000	
155	IPSRS	RO	Pemeliharaan RO	12	Mesin RO / Garam/ Filtrasi dll	Rp 2.000.000	Rp 24.000.000	
JUMLAH							Rp 14.244.699.000	

3.4 PROGRAM dan KOMITE

A. PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)

1. Rincian Kegiatan

No	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1	Penerapan Kewaspadaan Isolasi	a. Menyusun anggaran sarana dan prasarana <i>hand hygiene</i> dan APD b. Menyusun pedoman, SPO terkini sesuai dengan prinsip PPI c. Menyusun kebutuhan stiker PPI dan pemasangan pada semua area pelayanan dan tempat pengunjung rumah sakit d. Pengawasan penerapan kewaspadaan standar pada seluruh area pelayanan pasien, meliputi: - Kewaspadaan Standar 1) Asesmen risiko 2) Kebersihan tangan 3) Etika batuk 4) Penempatan pasien 5) Penggunaan APD 6) Penyuntikkan yang aman 7) Teknik aseptik 8) Pengendalian lingkungan 9) Penanganan linen 10) Penanganan limbah 11) Pemrosesan alat kesehatan - Kewaspadaan Transmisi 1) Kontak 2) <i>Airborne</i> 3) Droplet e. Rapat evaluasi penerapan kewaspadaan isolasi dan hasil surveilans setiap 1 bulan f. Rapat evaluasi setiap tahun untuk menilai/mengkaji ulang pelaksanaan kebijakan dan pedoman PPIRS yang berlaku dan mendeteksi hambatan

2	Surveilans PPIRS	a. Pengumpulan data kejadian infeksi di rumah sakit meliputi, 1. infeksi saluran kemih (ISK) terkait pemakaian kateter urine, 2. phlebitis berkaitan dengan penggunaan kateter intravena, 3. infeksi daerah operasi (IDO), 4. <i>ventilator associated pneumonia</i> (VAP) terkait pemasangan ventilator, 5. dekubitus terkait kejadian tirah baring, 6. infeksi aliran darah (IAD) terkait pemasangan CVC (<i>central venus chateter</i>) b. Audit kepatuhan petugas untuk <i>hand hygiene</i> dan penggunaan APD c. Pengolahan data untuk menentukan insiden rate suatu infeksi rumah sakit, angka mortalitas, dan lama hari rawat d. Pelaporan hasil Analisa surveilans HAIs oleh komite PPI kepada Direktur setiap 3 bulan
3	Pelaksanaan penggunaan antibiotika yang bijak dan rasional (PPRA)	a. Rapat dengan komite medik, komite PPRA dan bagian farmasi tentang standar pengendalian kuman dan resisten di RS Prima Husada Sukorejo b. Menentukan jumlah kuman dan jenis kuman yang paling tinggi diidentifikasi di rumah sakit dengan pelaksanaan kultur kuman di setiap ruangan
4	Pengembangan kegiatan pelatihan PPI	. Pelatihan Eksternal 1. PPI dasar 2. IPCN Lanjutan 3. IPCD 4. Workshop PPI 5. Seminar PPI . Pelatihan Internal 1. PPI Dasar pelayanan 2. PPI Dasar penunjang 3. PPI Dasar umum/keuangan 4. Pelatihan PPI untuk IPCLN . Sosialisasi PPI pada peserta didik yang akan melaksanakan praktik di RS

		. Penyuluhan tentang PPI pada pasien dan pengunjung rumah sakit dalam bentuk media leaflet dan video edukasi . Lomba penerapan standar PPI di ruangan . Pembuatan video edukasi PPI
5	Kesehatan karyawan	a. Pemeriksaan Kesehatan untuk karyawan baru b. Pemeriksaan kesehatan berkala sesuai risiko dan unit kerja (semua tenaga medis dilakukan pemeriksaan Kesehatan berkala (HBsAg) dan semua tenaga di bagian gizi dilakukan pemeriksaan anal swab
6	Pelaksanaan kajian risiko pembongkaran, konstruksi, dan renovasi gedung	a. Membuat formulir kajian risiko yang meliputi probabilitas, dampak dan sistem dan b. Melakukan kajian risiko dengan cara mengisi formulir kajian risiko c. Kemudian dilakukan perkalian pada probabilitas, dampak, dan system d. Tentukan prioritas masalah kewaspadaan standar
7	Uji Lingkungan	a. Swab lantai b. Swab dinding c. Uji udara ruangan d. Swab linen e. Swab meja OK f. Swab alkes rutin g. Swab alkes re-use h. Swab alat makan dan dapur i. Uji mikrobiologi makanan j. Uji udara ambient dan kebisingan k. Uji emisi l. Uji kebisingan m. Uji pencahayaan n. Uji air bersih o. Uji air minum p. Uji limbah

3. Sasaran

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
1.	Penerapan Kewaspadaan Isolasi meliputi a. Penyusunan anggaran sarana dan prasana <i>hand hygiene</i> dan APD b. Penyusunan pedoman SPO terkini sesuai dengan prinsip PPI c. Penyusunan kebutuhan stiker PPI dan pemasangan pada semua area pelayanan dan tempat pengunjung rumah sakit d. Pengawasan penerapan kewaspadaan standart [ada seluru area pelayanan pasien yang terdiri atas a) 11 kewaspadaan standart	Pemenuhan dan peningkatan kapasitas serta fasilitas pemenuhan kewaspadaan isolasi	1. Komite PPI 2. Staf seluruh RS a. Pelayanan b. Penunjang c. Umum/Keuangan d. Manajemen	Internal	100%	a. Penyusunan anggaran sarana dan prasana <i>hand hygiene</i> dan APD b. Penyusunan pedoman SPO terkini sesuai dengan prinsip PPI c. Penyusunan kebutuhan stiker PPI dan pemasangan pada semua area pelayanan dan tempat pengunjung rumah sakit d. Pengawasan penerapan kewaspadaan standart [ada seluru area pelayanan pasien yang terdiri atas 1. 11 kewaspadaan standart 2. kewaspadaan berdasarkan transmisi	



	b) 3 kewaspadaan berdasarkan transmisi						
2.	Surveilans PPIRS a. Pengumpulan data kejadian infeksi di rumah sakit meliputi, 1. Infeksi saluran kemih (ISK) terkait pemakaian kateter urine, 2. phlebitis berkaitan dengan penggunaan kateter intravena, 3. infeksi daerah operasi (IDO), 4. <i>ventilator associated pneumonia</i> (VAP) terkait pemasangan ventilator, 5. dekubitus terkait	Pemenuhan dan peningkatan surveilans PPIRS dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pengendalian dan pencegahan infeksi diseluruh unit RS	IPCN IPCLN	Internal	100%	a. Pengumpulan data kejadian infeksi di rumah sakit meliputi, 1. Infeksi saluran kemih (ISK) terkait pemakaian kateter urine, 2. phlebitis berkaitan dengan penggunaan kateter intravena, 3. infeksi daerah operasi (IDO), 4. <i>ventilator associated pneumonia</i> (VAP) terkait pemasangan ventilator, 5. dekubitus terkait kejadian tirah baring, 6. infeksi aliran darah (IAD) terkait pemasangan	

	kejadian tirah baring, 6. infeksi aliran darah (IAD) terkait pemasangan CVC (<i>central venus chateter</i>) b. Audit kepatuhan petugas untuk <i>hand hygiene</i> dan penggunaan APD c. Pengolahan data untuk menentukan insiden rate suatu infeksi rumah sakit, angka mortalitas, dan lama hari rawat d. Pelaporan hasil Analisa surveilans HAls oleh komite PPI kepada Direktur setiap 3 bulan					CVC (<i>central venus chateter</i>) b. Audit kepatuhan petugas untuk <i>hand hygiene</i> dan penggunaan APD c. Pengolahan data untuk menentukan insiden rate suatu infeksi rumah sakit, angka mortalitas, dan lama hari rawat d. Pelaporan hasil Analisa surveilans HAls oleh komite PPI kepada Direktur setiap 3 bulan	
3	Pelaksanaan penggunaan antibiotika yang bijak dan rasional (PPRA)	Pelaksanaan PPRA dapat digunakan sebagai tolak	IPCN Komite PPRA	Internal	100%	a. Rapat dengan komite medik, komite PPRA dan bagian farmasi	

	a. Rapat dengan komite medik, komite PPRA dan bagian farmasi tentang standar pengendalian kuman dan resisten di RS Prima Husada Sukorejo b. Menentukan jumlah kuman dan jenis kuman yang paling tinggi diidentifikasi di rumah sakit dengan pelaksanaan kultur kuman di setiap ruangan	ukur dalam mengontrol penggunaan antibiotic secara bijak dan rasional dalam penyelenggaraan fasilitas Kesehatan				tentang standar pengendalian kuman dan resisten di RS Prima Husada Sukorejo b. Menentukan jumlah kuman dan jenis kuman yang paling tinggi diidentifikasi di rumah sakit dengan pelaksanaan kultur kuman di setiap ruangan	
4	Pengembangan kegiatan PPI a. Pelatihan Eksternal 1. PPI dasar 2. IPCN Lanjutan 3. IPCD 4. Workshop PPI 5. Seminar PPI b. Pelatihan Internal	Pengembangan kegiatan PPI dalam meningkatkan kualitas SDM Dimana dapat meningkatkan pelayanan di area fasilitas kesehatan	Komite PPI IPCLN/Komite Lain (PJ PPI UNIT) Seluruh staff RS	Internal Eksternal	100%	a. Pelatihan Eksternal 1. PPI dasar 2. IPCN Lanjutan 3. IPCD 4. Workshop PPI 5. Seminar PPI b. Pelatihan Internal 1. PPI Dasar pelayanan	

	1. PPI Dasar pelayanan 2. PPI Dasar penunjang 3. PPI Dasar umum/keuangan 4. Pelatihan PPI untuk IPCLN c. Sosialisasi PPI pada peserta didik yang akan melaksanakan praktik di RS d. Penyuluhan tentang PPI pada pasien dan pengunjung rumah sakit dalam bentuk media leaflet dan video edukasi e. Lomba penerapan standar PPI di ruangan f. Pembuatan video edukasi PPI					2. PPI Dasar penunjang 3. PPI Dasar umum/keuangan 4. Pelatihan PPI untuk IPCLN c. Sosialisasi PPI pada peserta didik yang akan melaksanakan praktik di RS d. Penyuluhan tentang PPI pada pasien dan pengunjung rumah sakit dalam bentuk media leaflet dan video edukasi e. Lomba penerapan standar PPI di ruangan f. Pembuatan video edukasi PPI	
5	Kesehatan karyawan a. Pemeriksaan Kesehatan untuk karyawan baru	Penyelenggaraan Kesehatan karyawan bertujuan untuk meningkatkan	Seluruh staff RS	Internal	100%	a. Pemeriksaan Kesehatan untuk karyawan baru b. Pemeriksaan kesehatan berkala	

	b. Pemeriksaan kesehatan berkala sesuai risiko dan unit kerja (semua tenaga medis dilakukan pemeriksaan Kesehatan berkala (HBsAg) dan semua tenaga di bagian gizi dilakukan pemeriksaan anal swab	dan mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja yang berakibat kepada Kesehatan karyawan				sesuai risiko dan unit kerja (semua tenaga medis dilakukan pemeriksaan Kesehatan berkala (HBsAg) dan semua tenaga di bagian gizi dilakukan pemeriksaan anal swab	
6	Pelaksanaan kajian risiko pembongkaran, konstruksi, dan renovasi gedung a. Membuat formulir kajian risiko yang meliputi probabilitas, dampak dan sistem dan b. Melakukan kajian risiko dengan cara mengisi formulir kajian risiko c. Kemudian dilakukan perkalian	Pembuatan ICRA Program atau ICRA bangunan bertujuan untuk pengendalian dan pencegahan infeksi diarea fasilitas Kesehatan	IPCN	Internal	100%	a. Membuat formulir kajian risiko yang meliputi probabilitas, dampak dan sistem dan b. Melakukan kajian risiko dengan cara mengisi formulir kajian risiko c. Kemudian dilakukan perkalian pada probabilitas, dampak, dan system d. Tentukan prioritas masalah	

	pada probabilitas, dampak, dan system d. Tentukan prioritas masalah kewaspadaan standar					kewaspadaan standar	
7	Uji Lingkungan 1. Swab lantai 2. Swab dinding 3. Uji udara ruangan 4. Swab linen 5. Swab meja OK 6. Swab alkes rutin 7. Swab alkes re-use 8. Swab alat makan dan dapur 9. Uji mikrobiologi makanan 10. Uji udara ambient dan kebisingan 11. Uji emisi 12. Uji kebisingan 13. Uji pencahayaan	Pelaksanaan uji lingkungan bertujuan untuk pengendalian dan pencegahan infeksi diarea fasilitas Kesehatan	Lingkungan rumah sakit yang meliputi, a. IPAL b. TPS B3 c. Unit khusus (ICU, Neonatologi, IKO, IGD) d.	Eksternal	100%	1. Swab lantai 2. Swab dinding 3. Uji udara ruangan 4. Swab linen 5. Swab meja OK 6. Swab alkes rutin 7. Swab alkes re-use 8. Swab alat makan dan dapur 9. Uji mikrobiologi makanan 10. Uji udara ambient dan kebisingan 11. Uji emisi 12. Uji kebisingan 13. Uji pencahayaan	

3. Cara Melaksanakan Kegiatan

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
1	Penerapan Kewaspadaan Isolasi meliputi a. Penyusunan anggaran sarana	Mengisi usulan di SIM Membuat TOR Umandok Membuat telaah	a. rapat komite	a. Visual b. Media audio visual	Sesuai dengan jadwal pada tabel 3.4 pelaksanaan	Umandok Laporan bulanan Hasil supervisi	

	dan prasana <i>hand hygiene</i> dan APD b. Penyusunan pedoman SPO terkini sesuai dengan prinsip PPI c. Penyusunan kebutuhan stiker PPI dan pemasangan pada semua area pelayanan dan tempat pengunjung rumah sakit d. Pengawasan penerapan kewaspadaan standart [ada seluru area pelayanan pasien yang terdiri atas, 1. 11 kewaspadaan standart 2. kewaspadaan berdasarkan transmisi		b. rapat komite c. rapat komite d. umandok, sosialisasi, simulasi, disko, role-play	c. Media elektronik	kegiatan tahun 2025		
2	Surveilans PPIRS a. Pengumpulan data kejadian infeksi di rumah sakit meliputi,	Umandok Mengisi usulan di SIM Membuat telaan staff	a. Supervisi, observasi, disko	a. Visual b. Media audio visual c. Media elektronik		Umandok Laporan bulanan Hasil supervisi	



	1. Infeksi saluran kemih (ISK) terkait pemakaian kateter urine, 2. phlebitis berkaitan dengan penggunaan kateter intravena, 3. infeksi daerah operasi (IDO), 4. <i>ventilator associated pneumonia</i> (VAP) terkait pemasangan ventilator, 5. dekubitus terkait kejadian tirah baring, 6. infeksi aliran darah (IAD) terkait pemasangan						
			b. Supervisi, observasi c. Observasi, surveilans				



	CVC (<i>central venus chateter</i>) b. Audit kepatuhan petugas untuk <i>hand hygiene</i> dan penggunaan APD c. Pengolahan data untuk menentukan insiden rate suatu infeksi rumah sakit, angka mortalitas, dan lama hari rawat d. Pelaporan hasil Analisa surveilans HAls oleh komite PPI kepada Direktur setiap 3 bulan		d. Surveilans, observasi				
3	Pelaksanaan penggunaan antibiotika yang bijak dan rasional (PPRA) a. Rapat dengan komite medik, komite PPRA dan bagian farmasi tentang standar pengendalian kuman dan resisten	Umandok	a. Rapat komite PPRA,	a. Visual b. Media audio visual c. Media elektronik		Umandok Laporan bulanan Hasil supervisi	

Jl. Raya Surabaya – Malang Km 54, Desa Lemahbang Kec. Sukorejo – Pasuruan
Telp : 0343 – 6745000 | Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com

	melaksanakan praktik di RS d. Penyuluhan tentang PPI pada pasien dan pengunjung rumah sakit dalam bentuk media leaflet dan video edukasi e. Lomba penerapan standar PPI di ruangan f. Pembuatan video edukasi PPI		e. Demonstrasi f. Role-play				
5	Kesehatan karyawan a. Pemeriksaan Kesehatan untuk karyawan baru b. Pemeriksaan kesehatan berkala sesuai risiko dan unit kerja (semua tenaga medis dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala (HBsAg) dan semua tenaga di bagian gizi dilakukan pemeriksaan anal swab	Membuat TOR Umandok	Observasi	Visual		Umandok Laporan bulanan	

6	Pelaksanaan kajian risiko pembongkaran, konstruksi, dan renovasi gedung a. Membuat formulir kajian risiko yang meliputi probabilitas, dampak dan sistem dan b. Melakukan kajian risiko dengan cara mengisi formulir kajian risiko c. Kemudian dilakukan perkalian pada probabilitas, dampak, dan system d. Tentukan prioritas masalah kewaspadaan standar	Umandok	Disko Observasi	Visual Media cetak		Umandok Laporan	
7	Uji Lingkungan a. Swab lantai b. Swab dinding c. Uji udara ruangan d. Swab linen e. Swab meja OK f. Swab alkes rutin	a. Membuat TOR b. Umandok c. Pemberitahuan ke secretariat d. Disetujui PT DPM e. Pembuatan jadwal pelaksanaan f. Evaluasi	Observasi	-	a. Dilakukan perbulan b. Dilakukan per-enam bulan	Umandok Laporan Sertifikat	-

	g. Swab alkes re-use						
	h. Swab alat makan dan dapur						
	i. Uji mikrobiologi makanan						
	j. Uji udara ambient dan kebisingan						
	k. Uji emisi						
	l. Uji kebisingan						
	m. Uji pencahayaan						

5. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

NO	KEGIATAN	SASARAN	BULAN												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET	
			12/24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12
1	Penerapan kewaspadaan isolasi																		
	a. Menyusun anggaran sarana dan prasaran HH dan APD	Komite PPI	√											√	√	Rumah Sakit	Komite PPI K	RS	Penyusunan Pedoman, SPO disesuaikan dengan case yang berada di lapangan
	b. Penyusunan pedoman, SPO terkini dengan prinsip PPI	Komite PPI	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rumah Sakit			
	c. Penyusunan kebutuhan stiker PPI dan pemasangan pada semua area pelayanan dan tempat pengunjung rumah sakit	Komite PPI	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rumah Sakit			
	d. Pengawasan penerapan kewaspadaan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rumah Sakit			



	standar pada sleuruh area pelayanan pasien meliputi,																		
	1. 11 kewaspadaan standart a) Asesmen risiko b) Kebersihan tangan c) Etika batuk d) Penempatan pasien e) Penggunaan APD f) Penyuntikkan yang aman g) Teknik aseptik h) Pengendalian lingkungan i) Penanganan linen j) Penanganan limbah k) Pemrosesan alat kesehatan	Seluruh staff	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	All Unit	IPCN IPCLN	RS	-
	2. 3 kewaspadaan transmisi a) Kontak b) Airbone c) Droplet	Seluruh staff	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				

	e. Rapat evaluasi penerapan kewaspadaan isolasi dan hasil surveilans setiap 1 bulan	Komite PPI	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	R. Meeting	IPCN	RS	-
	f. Rapat evaluasi setiap tahun	Komite PPI	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
2	Surveilans PPIRS																		
	a. Pengumpulan data kejadian infeksi di RS meliputi 1. CAUTI 2. Phlebitis 3. IDO 4. VAP 5. Decubitus 6. IAD	IPCLN Komite PPI	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rumah sakit All Unit	IPCLN	RS	-
	b. Audit kepatuhan petugas untuk HH dan penggunaan APD	IPCN	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		IPCN		
	c. Pengelolaan data untuk menentukan insiden rate suatu infeksi rumah sakit, angka mortalitas, dan lama hari rawat	IPCN	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		IPCN		
	d. Pelaporan hasil Analisa surveilans HAIs oleh komite PPI kepada direktur setiap 3 bulan	IPCN	√			√			√			√			√		IPCN		
3	Pelaksanaan penggunaan antibiotika yang bijak dan rasional (PPRA)																		

	a. Rapat dengan komite medik, komite PPRA dan bagian farmasi tentang standar pengendalian kuman dan resisten di RS Prima Husada Sukorejo	Komite PPRA IPCN	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rumah Sakit	IPCN Komite PPRA	RS	-
	b. Menentukan jumlah kuman dan jenis kuman yang paling tinggi diidentifikasi di rumah sakit dengan pelaksanaan kultur kuman di setiap ruangan	Komite PPRA IPCN	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
4	Pengembangan kegiatan pelatihan PPI																		
	a. Pelatihan Eksternal																		
	1. PPI Dasar	IPCLN		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Eksternal	IPCLN	Rumah sakit	Disesuaikan dengan jadwal penyelenggara
	2. IPCN Lanjutan	IPCN		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		IPCN		
	3. IPCD	IPCD		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		IPCD		
	4. Workshop PPI	IPCN IPCLN		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		IPCN IPCLN		
	5. Seminar PPI	IPCN IPCLN		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		IPCN IPCLN		
	b. Pelatihan Internal																		
	1. PPI dasar pelayanan	Seluruh staff RS		√												Rumah Sakit	Komite PPI SDM	Rumah sakit	
	2. PPI dasar penunjang			√															
	3. PPI dasar umum/keuangan			√															

	4. Pelatihan PPI untuk IPCLN			√																	
	c. Sosialisasi PPI pada peserta didik yang akan melaksanakan praktik di RS	IPCN Seluruh staff RS baru		√						√					√						Disesuaikan dengan jadwal rekrutmen SDM
	d. Penyuluhan tentang PPI pada pasien dan pengunjung rumah sakit dalam bentuk media leaflet dan video edukasi	IPCLN IPCN		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√						Disesuaikan dengan jadwal PKRS
	e. Lomba penerapan standart PPI di ruangan	Unit pelayanan dan penunjang		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√						Disesuaikan dengan hari besar
	f. Pembuatan video edukasi PPI	IPCLN		√	√		√		√		√		√		√						
5	Kesehatana karyawan																				
	a. Pemeriksaan Kesehatan untuk karyawan baru	Staff baru RS	Menyesuaikan jadwal SDM													Rumah Sakit	SDM	RS	Note Hasil pemeriksaan ditembuskan kepada PPI		
	b. Pemeriksaan kesehatan berkala sesuai risiko dan unit kerja (semua tenaga medis dilakukan pemeriksaan Kesehatan berkala (HBsAg) dan semua tenaga di bagian gizi dilakukan pemeriksaan anal swab	Seluruh staff RS a. Pelayanan b. Penunjang c. Umum / keuangan d. Manajemen	Menyesuaikan jadwal SDM																		
6	Pelaksanaan kajian resiko pembongkaran, konstruksi, dan renovasi Gedung																				

	a. Membuat formulir kajian resiko yang meliputi probabilitas, dampak dan sistem	IPCN	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Area Rumah Sakit	Komite PPI	Rumah sakit	Menyesuaikan dengan agenda Pembangunan RS
	b. Melakukan kajian resiko dengan cara mengisi formulir kajian resiko		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
	c. Kemudian dilakukan perkalian pada probabilitas, dampak dan system		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
	d. Tentukan prioritas masalah kewaspadaan standart		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
7	Uji lingkungan																		
	a. Swab lantai	a. ICU	√						√						√	Area Rumah Sakit	Komite PPI Kesling	Rumah sakit	
	b. Swab dinding	b. IKO	√						√						√				
	c. Uji udara ruangan	c. IGD	√						√						√				
	d. Swab linen	d. CSSD	√						√						√				
	e. Swab meja OK	e. Rawat Inap	√						√						√				
	f. Swab alkes rutin	f. Neonatologi	√						√						√				
	g. Swab alkes re-use	g. Sumber titik air bersih	√						√						√				
	h. Swab alat makan dan dapur	h. Sumber titik air minum	√						√						√				
	i. Uji mikrobiologi makanan	i. IPAL	√						√						√				
	j. Uji udara ambien dan kebisingan		√						√						√				
	k. Uji emisi		√						√						√				
	l. Uji kebisingan		√						√						√				
	m. Uji pencahayaan		√						√						√				

	n. Uji air bersih (fisika dan biologi)		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				Note : 1. Fisika (1bulan sekali) 2. Biologi (1 bulan sekali) 3. Kimia air 6 bulan sekali
	Uji air bersih (kimia)		√						√						√				
	o. Uji air limbah		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
	p. Uji air minum (fisika dan biologi)		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
	Uji air minum (kimia)		√						√						√				

5. Kebutuhan Anggaran

Semua anggaran akan dibiayai dari anggaran RS Prima Husada Sukorejo yang telah disetujui oleh PT.DPM dengan rincian sebagaimana terlampir :

Tabel 3.5.1 Perhitungan biaya berdasarkan pemakaian rata-rata perbulan sebagai berikut :

No	Kebutuhan	Rata-Rata/Bulan	Satuan	Kebutuhan 1 tahun	Harga satuan (Rp)	Total (Rp)
Penerapan Kewaspadaan Isolasi						
1	Penyusunan anggaran sarana dan prasaran HH dan APD	-				
2	Penyusunan pedoman SPO terkini dengan prinsip PPI					
3	Penyusunan kebutuhan stiker PPI dan pemasangan pada semua area pelayanan dan tempat pengunjung rumah sakit	10	lembar A3	120	Rp 15,000.00	Rp 1,800,000.00
4	Pengawasan penerapan kewaspadaan standar pada sleuruh area pelayanan pasien meliputi,					
5	11 Kewaspadaan standart					
	a. Assesmen resiko	-				
	b. Kebersihan tangan					
	Handwash	100	liter	1200	Rp 18,000.00	Rp 21,600,000.00
	Handrub gel 5L	20	jirigen	240	Rp 249,600.00	Rp 59,904,000.00
	Handrub gel 500mL	3	box	36	Rp 299,520.00	Rp 10,782,720.00
	Bracket bed	-	pcs	70	Rp 39,000.00	Rp 2,730,000.00
	Bracket dinding	-	pcs	24	Rp 18,000.00	Rp 432,000.00
	Dispenser tisu	-	pcs	15	Rp 135,000.00	Rp 2,025,000.00
	Tissu Hasil	28	pack	336	Rp 17,000.00	Rp 5,712,000.00
	Handtowel	1000	pack	12000	Rp 5,800.00	Rp 69,600,000.00
	Botol 500 ml		pcs	100	Rp 10,000.00	Rp 1,000,000.00
	c. Etika batuk					
	Handtowel	RBA mengikuti kebutuhan APD dalam satu tahun				
	Masker					
	Leaflet	10	lembar	120	Rp 5,000.00	Rp 600,000.00
	d. Penempatan pasien					
	Magnahelic	-	pcs	4	Rp 2,500,000.00	Rp 10,000,000.00
	e. Penggunaan APD					
	Sepatu boots	-	-	50	Rp 90,000.00	Rp 4,500,000.00
	Apron	40	pcs	480	Rp 36,780.00	Rp 17,654,400.00
	Celemek	20	pcs	240	Rp 25,000.00	Rp 6,000,000.00



Faceshield	10	pcs	120	Rp 110,000.00	Rp 13,200,000.00
Kacamata google	10	pcs	120	Rp 22,000.00	Rp 2,640,000.00
Nurse cap	20	pcs	240	Rp 46,860.00	Rp 11,246,400.00
Masker tali	40	box	480	Rp 18,800.00	Rp 9,024,000.00
Masker karet	200	box	2400	Rp 13,500.00	Rp 32,400,000.00
Masker N95	5	box	60	Rp 350,000.00	Rp 21,000,000.00
Handsocon non steril Uk L nitril	30	box	360	Rp 107,000.00	Rp 38,520,000.00
Handsocon non steril Uk M nitril	70	box	840	Rp 107,000.00	Rp 89,880,000.00
Handsocon non steril Uk S nitril	100	box	1200	Rp 107,000.00	Rp 128,400,000.00
Handsocon steril Uk 6,5	10	box	120	Rp 309,800.00	Rp 37,176,000.00
Handsocon steril Uk 7,5	20	box	240	Rp 309,800.00	Rp 74,352,000.00
Handsocon steril Uk 7	20	box	240	Rp 309,800.00	Rp 74,352,000.00
Handsocon steril Uk 8	5	box	60	Rp 309,800.00	Rp 18,588,000.00
Sarung tangan karet	20	pcs	240	Rp 30,000.00	Rp 7,200,000.00
f. Penyuntikan yang aman					
Alcohol swab	60	box	720	Rp 50,000.00	Rp 36,000,000.00
Stardine SOL 1L	20	botol	240	Rp 165,000.00	Rp 39,600,000.00
Odex 0,5L	1	botol	12	Rp 123,874.00	Rp 1,486,488.00
H2O2 3% 800ml	1	botol	12	Rp 38,200.00	Rp 458,400.00
Chlorhexidine 4% 100ml	8	botol	96	Rp 34,100.00	Rp 3,273,600.00
Perhidrol	1	botol	12	Rp 400,000.00	Rp 4,800,000.00
g. Teknik aseptik					
Alcohol swab	RBA ikut dalam penyuntikan yang aman				
h. Pengendalian Lingkungan					
Tempat sampah 50L	-	pcs	45	Rp 360,000.00	Rp 16,200,000.00
Tempat sampah 25L	-	pcs	45	Rp 125,000.00	Rp 5,625,000.00
Safety box 12,5L	240	pcs	2880	Rp 8,000.00	Rp 23,040,000.00
Polybag besar	16	pack	192	Rp 71,500.00	Rp 13,728,000.00
Kantong limbah non infeksius besar	72	pack	864	Rp 50,000.00	Rp 43,200,000.00
Kantong limbah non infeksius sedang	40	pack	480	Rp 18,000.00	Rp 8,640,000.00
Kantong limbah infeksius sedang	32	pack	384	Rp 18,000.00	Rp 6,912,000.00
Kantong limbah infeksius besar	48	pcs	576	Rp 40,000.00	Rp 23,040,000.00
Kantong plastic kimia	1	pack	12	Rp 28,000.00	Rp 336,000.00
Sulo hijau		pcs	5	Rp 950,000.00	Rp 4,750,000.00
Sulo kuning		pcs	10	Rp 950,000.00	Rp 9,500,000.00
Tong linen hijau		pcs	4	Rp 500,000.00	Rp 2,000,000.00
Tong linen kuning		pcs	4	Rp 500,000.00	Rp 2,000,000.00
Klorin	30	botol	360	Rp 30,449.00	Rp 10,961,640.00
Klorin tablet	1	kg	12	Rp 200,000.00	Rp 2,400,000.00

	Wipol	30	bottle	360	Rp 28,000.00	Rp 10,080,000.00
	Superpel antiseptic	12	doz	144	Rp 98,400.00	Rp 14,169,600.00
	Precept	-	pack	3	Rp 950,000.00	Rp 2,850,000.00
	Clinicare	-	jurigen	10	Rp 1,967,726.00	Rp 19,677,260.00
	Disinfektan alcohol	20	liter	240	Rp 34,217.00	Rp 8,212,080.00
	Karbol pewangi	52	pcs	624	Rp 10,000.00	Rp 6,240,000.00
	Pembersih lantai	28	pcs	336	Rp 8,000.00	Rp 2,688,000.00
	Gandasil D		pcs	5	Rp 40,000.00	Rp 200,000.00
	Curacon	1	bottle	12	Rp 35,000.00	Rp 420,000.00
	Roundap	1	bottle	12	Rp 95,000.00	Rp 1,140,000.00
	Glass cleaner	2	galon	24	Rp 34,000.00	Rp 816,000.00
	Ecolab lime way	2	bottle	24	Rp 385,000.00	Rp 9,240,000.00
	Ecolab lime eze	1	bottle	12	Rp 300,000.00	Rp 3,600,000.00
	Ecolab medallion		bottle	5	Rp 607,000.00	Rp 3,035,000.00
	i. Penanganan linen					
	Chemical Clax Lite 20 L	40	liter	480	Rp 1,271,500.00	Rp 610,320,000.00
	Chemical Clax OB 20 L	40	liter	480	Rp 1,530,000.00	Rp 734,400,000.00
	Chemical Clax Sunril Ultra 25	50	liter	600	Rp 1,445,000.00	Rp 867,000,000.00
	Chemical Clax Soft 20 L	40	liter	480	Rp 742,050.00	Rp 356,184,000.00
	Pewangi Kispray 5L	8	liter	96	Rp 250,000.00	Rp 24,000,000.00
	j. Penanganan limbah					
	Limbah Domestik		kilogram	12	Rp 2,000,000.00	Rp 24,000,000.00
	Limbah B3	2397.421	kilogram	28769.052	Rp 7,500.00	Rp 215,767,890.00
	k. Pemrosesan alat kesehatan					
	Metracide	12	bottle	144	Rp 2,925,000.00	Rp 421,200,000.00
	Metrazyme	5	bungkus	60	Rp 860,000.00	Rp 51,600,000.00
	Pouches flat 10cm/200m	2	roll	24	Rp 895,000.00	Rp 21,480,000.00
	Pouches flat 15cm/200m	1	roll	12	Rp 1,355,000.00	Rp 16,260,000.00
	Pouches flat 20cm/200m	1.5	roll	18	Rp 1,645,000.00	Rp 29,610,000.00
	pouches gussete 15cmx5cm/100 m	2	roll	24	Rp 1,130,000.00	Rp 27,120,000.00
	Pouches gussete 20cmx5cm/100m	1.5	roll	18	Rp 1,360,000.00	Rp 24,480,000.00
	Pouches gussete 25cm/100 m	1.5	roll	18	Rp 1,650,000.00	Rp 29,700,000.00
	Pouches gussete 25x6,5/100m	1.5	roll	18	Rp 1,650,000.00	Rp 29,700,000.00
	Indikator strip	2	box	24	Rp 650,000.00	Rp 15,600,000.00
	Indikator tapes	2	box	24	Rp 120,000.00	Rp 2,880,000.00
	3 Kewaspadaan transmisi					
	a. Kontak	RBA mengikuti penempatan pasien dalam 11 kewaspadaan standart				
	b. Droplet					
	c. Airbone					
6	Rapat evaluasi penerapan kewaspadaan	1	kali kesempatan	12	Rp 50,000.00	Rp 600,000.00

	isolasi dan hasil surveilans setiap 1 bulan					
7	Rapat evaluasi setiap tahun	1	kali kesempatan	1	Rp 50,000.00	Rp 50,000.00
Total						Rp 4,614,589,478.00
Surveilans PPIRS						
1	Pengumpulan data kejadian infeksi di RS meliputi 1. CAUTI 2. Phlebitis 3. IDO 4. VAP 5. Decubitus 6. IAD	Pengumpulan data menggunakan 1. WEB Komite PPI 2. SIM RS				
2	Audit kepatuhan petugas untuk HH dan penggunaan APD					
3	Pengelolaan data untuk menentukan insiden rate suatu infeksi rumah sakit, angka mortalitas, dan lama hari rawat					
4	Pelaporan hasil Analisa surveilans HAls oleh komite PPI kepada direktur setiap 3 bulan					
Pelaksanaan penggunaan antibiotika yang bijak dan rasional (PPRA)						
1	Rapat dengan komite medik, komite PPRA dan bagian farmasi tentang standart pengendalian kuman dan resisten di RS Prima Husada Sukorejo	1	per bulan	12	Rp 50,000.00	Rp 600,000.00
2	Menentukan jumlah kuman dan jenis kuman yang paling tinggi diidentifikasi di rumah sakit dengan pelaksanaan kultur kuman di setiap ruangan	1	kali dalam setahun	2	-	-
	Uji kultur kuman	-	sampel	20	Rp 500,000.00	Rp 10,000,000.00
Total						Rp 10,600,000.00
Pengembangan kegiatan pelatihan PPI						
1	Pelatihan Eksternal					
	1. PPI Dasar	-	orang	1	Rp 1,000,000.00	Rp 1,000,000.00
	2. IPCN Lanjutan	-	orang	1	Rp 6,000,000.00	Rp 6,000,000.00
	3. IPCD	-	orang	1	Rp 6,000,000.00	Rp 6,000,000.00
	4. Workshop PPI	-	orang	2	Rp 1,000,000.00	Rp 2,000,000.00
	5. Seminar PPI	-	orang	2	Rp 1,000,000.00	Rp 2,000,000.00



2	Pelatihan Internal	-				
	PPI dasar pelayanan	RBA ikut SDM				
	PPI dasar penunjang					
	PPI dasar umum/keuangan					
	Pelatihan PPI untuk IPCLN					
3	Sosialisasi PPI pada peserta didik yang akan melaksanakan praktik di RS	RBA ikut SDM menyesuaikan dengan jadwal perekrutan karyawan baru				
4	Penyuluhan tentang PPI pada pasien dan pengunjung rumah sakit dalam bentuk media leaflet dan video edukasi (18 unit)	2	kali edukasi	24	Rp 50,000.00	Rp 1,200,000.00
5	Lomba penerapan standart PPI di ruangan (21 unit)	3	kategori penilaian tertinggi	36	Rp 150,000.00	Rp 5,400,000.00
6	Pembuatan video edukasi PPI	1	kali pembuatan edukasi	4	-	-
Total						Rp 23,600,000.00
Kesehatana karyawan						
1	Pemeriksaan Kesehatan untuk karyawan baru	RBA ikut SDM Jenis pemeriksaan sesuai dengan kondisi terjadinya pajanan				
2	Pemeriksaan kesehatan berkala sesuai risiko dan unit kerja (semua tenaga medis dilakukan pemeriksaan Kesehatan berkala (HBsAg) dan semua tenaga di bagian gizi dilakukan pemeriksaan anal swab					
	Cek HIV		orang	200	Rp 212,600.00	Rp 42,520,000.00
	Cek HbsAg		orang	200	Rp 350,000.00	Rp 70,000,000.00
	Vaksin HbsAg		orang	200	Rp 500,000.00	Rp 100,000,000.00
	Foto thorax		orang	200	Rp 110,000.00	Rp 22,000,000.00
	Rectal swab		orang	20	Rp 100,000.00	Rp 2,000,000.00
Total						Rp 236,520,000.00
Pelaksanaan kajian resiko pembongkaran, konstruksi, dan renovasi Gedung						
1	Membuat formulir kajian resiko yang meliputi probabilitas, dampak dan sistem	30	lembar	300	Rp 2,000.00	Rp 600,000.00
2	Melakukan kajian resiko dengan cara					

	mengisi formulir kajian resiko					
3	Kemudian dilakukan perkalian pada probabilitas, dampak dan system					
4	Tentukan prioritas masalah kewaspadaan standart					
Total						Rp 600,000.00
Uji Lingkungan						
1	Swab lantai	8	sampel	16	Rp 150,000.00	Rp 2,400,000.00
2	Swab dinding	8	sampel	16	Rp 150,000.00	Rp 2,400,000.00
3	Uji udara ruangan	8	sampel	16	Rp 50,000.00	Rp 800,000.00
4	Swab linen	5	sampel	10	Rp 150,000.00	Rp 1,500,000.00
5	Swab meja OK	4	sampel	8	Rp 150,000.00	Rp 1,200,000.00
6	Swab alkes rutin	3	sampel	6	Rp 250,000.00	Rp 1,500,000.00
7	Swab alkes re-use	3	sampel	6	Rp 250,000.00	Rp 1,500,000.00
8	Swab alat makan dan dapur	3	sampel	6	Rp 150,000.00	Rp 900,000.00
9	Uji mikrobiolgi makanan	3	sampel	6	Rp 200,000.00	Rp 1,200,000.00
10	Uji udara ambien dan kebisingan	8	sampel	16	Rp 150,000.00	Rp 2,400,000.00
11	Uji emisi	8	sampel	16	Rp 100,000.00	Rp 1,600,000.00
12	Uji kebisingan	8	sampel	16	Rp 75,000.00	Rp 1,200,000.00
13	Uji pencahayaan	8	sampel	16	Rp 75,000.00	Rp 1,200,000.00
14	Uji air bersih (fisika dan biologi)	1	sampel	12	Rp 150,000.00	Rp 1,800,000.00
15	Uji air bersih (kimia)	2	sampel	4	Rp 150,000.00	Rp 600,000.00
16	Uji air limbah	1	sampel	12	Rp 150,000.00	Rp 1,800,000.00
17	Uji air minum (fisika dan biologi)	1	sampel	12	Rp 150,000.00	Rp 1,800,000.00
18	Uji air minum (kimia)	2	sampel	4	Rp 150,000.00	Rp 600,000.00
Total						Rp 26,400,000.00
TOTAL						Rp 4,912,309,478.00

Tabel 3.5.2 Kebutuhan biaya berdasarkan pengembangan SDM Komite PPI Tahun 2025 sebagai berikut;

No	Kegiatan	Internal / Eksternal	Jumlah (satuan)	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1.	Sertifikasi IPCN atau IPCP (lanjutan)	Eksternal	1 orang	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
2.	Workshop PPI	Eksternal	2 orang	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000
3.	Seminar PPI	Eksternal	2 orang	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000
4.	Pelatihan PPI Dasar	Eksternal	2 orang	Rp 1.000.000	Rp 2.000.000
5.	Pelatihan IPCD	Eksternal	1 orang	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
Total					Rp 17.000.000

B. KOMITE MUTU

3.1. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

No	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1.	Pemenuhan Kebutuhan SDM	Berdasarkan PMK No 80 Tahun 2020 Susunan Organisasi Komite Mutu paling sedikit terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota, tetapi di RS Prima Husada Sukorejo belum terpenuhi adapun perinciannya sebagai berikut: 1. Hanya terdapat penanggung jawab program Mutu RS perlunya Penambahan Dokter Umum sebagai Ketua Komite PMKP di RS Prima Husada Sukorejo 2. Ketua Sub Komite Peningkatan Mutu belum ada 3. Ketua Sub Keselamatan Pasien belum ada 4. Ketua Komite Manajemen Resiko belum ada 5. Kepala Instalasi (Penanggung jawab) unit 39 orang sudah terpenuhi 6. PIC Data Mutu Unit 39 orang sudah terpenuhi
2.	Pendidikan dan Pelatihan (Seminar dan Workshop) terkait Mutu	1. Pelatihan Eksternal: • Sasaran: Ketua Komite PMKP, Sekretaris Komite PMKP, Sub Komite Peningkatan Mutu, Sub Komite Keselamatan Pasien, Sub Komite Manajemen Resiko • Materi: a. Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) dan Manajemen Resiko b. Pelatihan Penyusunan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan Root Cause Analysis (RCA) c. Pelatihan Implementasi Kendali Mutu Biaya pada bab PMKP • Seminar dan Workshop harus dari KARS sebagai Standar Akreditasi Rumah Sakit 2. Pelatihan Internal: a. Orientasi Umum: • Sasaran: Pegawai baru di RS Prima Husada Sukorejo • Materi: Pengenalan Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) di RS Prima Husada Sukorejo b. <i>Refreshment & Training</i> PMKP untuk keseluruhan staf di RS Prima Husada Sukorejo: • Sasaran: Keseluruhan staff di RS Prima Husada Sukorejo (Dokter, Perawat, Bidan, Gizi, Farmasi, dsb) • Materi:

		1) Indikator Mutu Nasional, Indikator Mutu Prioritas RS, Indikator Mutu Unit 2) Macam-macam Insiden Keselamatan Pasien dan Alur Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien 3) Budaya Keselamatan Pasien 4) Manajemen Resiko c. Pelatihan Pengambilan Data Mutu: • Sasaran: PIC Data Mutu di setiap Unit • Materi: 1) Refreshment Indikator Mutu yang berlaku di Unit 2) Alur Pengumpulan Data Mutu baik di SIMRS maupun <i>Google Spreadsheet</i> 3) Cara analisa permasalahan sesuai dengan kondisi di unit sampai dengan tindak lanjut perbaikan 4) Praktik mengumpulkan data Mutu baik di SIMRS maupun <i>Google Spreadsheet by name</i> 5) Praktik mengunduh laporan mutu di SIMRS d. Pelatihan terkait pengisian CP di Unit: (Kolaborasi dengan Komite Medik) • Sasaran: PPA (Program Pemberi Asuhan) yakni DPJP, Perawat, Bidan, Gizi dan Farmasi • Materi: 1) Refreshment Praktik Klinis yang dilakukan Audit 2) Pengisian Form CP di <i>Google Spreadsheet</i>
3.	Regulasi terkait Komite Mutu	• RS Prima Husada Sukorejo menetapkan kebijakan dan langkah-langkah upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta manajemen resiko di rumah sakit. untuk dapat melaksanakan upaya peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit, maka langkah awal yang perlu dilakukan adalah kebijaksanaan dan langkah-langkah upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien dari Direktur. • Regulasi di review dan di buat sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak ada regulasi yang <i>expired</i>. Regulasi yang perlu di review yakni: 1. Penetapan SK Komite Mutu 2. Penetapan SK PJ Mutu 3. Penetapan SK PIC Mutu 4. Penetapan SK Validator Mutu 5. Penetapan Pedoman Komite Mutu RS 6. Penetapan Program Kerja Komite Mutu RS

		7. Penetapan tentang Sistem Pelaporan dan Pembelajaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit (SP2KP RS) 8. Penetapan tentang Program Budaya Keselamatan Rumah Sakit 9. Penetapan tentang Program Manajemen Risiko Tingkat Rumah Sakit
4.	Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Indikator Nasional Mutu adalah indikator mutu nasional yang wajib dilakukan pengukuran dan digunakan sebagai informasi mutu secara nasional. Adapun Indikator Nasional Mutu (INM) adalah sebagai berikut: 1. Kepatuhan kebersihan tangan ($\geq 85\%$) 2. Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (100%) 3. Kepatuhan identifikasi pasien (100%) 4. Waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi ($>80\%$) 5. Waktu tunggu rawat jalan ($\geq 80\%$) 6. Penundaan operasi elektif ($<5\%$) 7. Kepatuhan waktu visite dokter ($\geq 80\%$) 8. Pelaporan hasil kritis laboratorium (100%) 9. Kepatuhan penggunaan formularium nasional ($\geq 80\%$) 10. Kepatuhan terhadap alur klinis (<i>Clinical Pathway</i>) ($\geq 80\%$) 11. Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh (100%) 12. Kecepatan waktu tanggap komplain ($\geq 80\%$) 13. Kepuasan pasien (76.61%) Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut: a. Terlaksananya pengumpulan dan analisa data b. Terlaksananya pelaporan indikator mutu Nasional ke Aplikasi SIMAR c. Terlaksananya rencana perbaikan & pelaksanaan perbaikan d. Terlaksananya monitoring indikator nasional mutu
5.	Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit (IMP-RS)	1. Direkur beserta Komite Mutu RS. Prima Husada Sukorejo melakukan persiapan berupa pertemuan atau rapat dengan seluruh kepala ruangan, sehingga ada kesamaan pengertian tentang mutu, keselamatan pasien dan manajemen risiko sehingga ditemukan kesepakatan tentang langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan. 2. Pemilihan Indikator Mutu Prioritas RS (IMP-RS) dan sesuai dengan TKRS 5 mencakup: a. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien (ISKP)

		b. Indikator Pelayanan Klinis Prioritas c. Indikator sesuai Tujuan Strategis Rumah Sakit (KPI) d. Indikator terkait Perbaikan Sistem e. Indikator terkait Manajemen Risiko 3. Indikator pelayanan klinis prioritas ditetapkan melalui SK penetapan direktur 4. Terlaksananya pengumpulan data, analisa, interpretasi data dan <i>feedback</i> data 5. Terlaksananya pelaporan capaian indikator mutu prioritas RS
6.	Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Unit	Indikator Mutu Prioritas Unit (IMP – Unit) adalah indikator prioritas yang khusus dipilih kepala unit terdiri dari minimal 1 indikator. Adapun uraiannya sebagai berikut: 1. Terlaksananya pemilihan Indikator Mutu Unit 2. Terlaksananya penetapan Indikator Mutu Unit a. IGD b. Instalasi Rawat Jalan c. Instalasi Rawat Inap 2A d. Instalasi Rawat Inap 2B e. Instalasi Rawat Inap 3A f. Instalasi Rawat Inap 3B g. Instalasi Kamar Operasi h. Maternitas i. Ponak j. Neonatologi k. ICU l. Radiologi m. Laboratorium n. Rehab Medis o. Farmasi p. Gizi q. Rekam Medis r. Limbah-K3RS s. SDM t. Kesekretariatan u. Driver v. Pemulasaran Jenazah

		w. ATEM-IPSRs x. Laundry y. CSSD z. Cleaning Service - aa. Keamanan - bb. Gudang Umum - cc. PPI - dd. PKRS - ee. Verifikator - ff. Humas & Marketing - gg. MOD-MPP-PIPP - hh. TB di IRJA ii. Keuangan - jj. HIV - kk. KB - ll. Stunting - mm. IT-SIMRS 3. Terlaksananya pengumpulan dan analisa data 4. Terlaksananya pelaporan indikator mutu unit 5. Terlaksananya rencana perbaikan & pelaksanaan perbaikan 6. Publikasi capaian mutu unit di dashboar mutu unit 7. Terlaksananya monitoring mutu unit kerja
7.	Analisa, Pelaporan dan <i>feedback</i> data indikator mutu terintergrasi	1. Terlaksananya pengumpulan data indikatotor mutu oleh PIC disetiap unit kerja sesuai dengan profil indikator 2. Terlaksananya analisa data pencapaian indikator sesuai dengan ketentuan analisa data 3. Terlaksananya validasi data sesuai dengan ketentuan validasi data 4. Terlaksananya pelaporan data indikator mutu dari tingkat unit sampai dengan ke pemilik 5. Terlaksananya penyampaian <i>feedback</i> hasil capaian indikator mutu ke semua staf di unit kerja 6. Terlaksananya publikasi data indikator mutu 7. Terlaksananya <i>benchmark</i> data

8.	Penerapan Standar Pelayanan Kedokteran di Rumah Sakit	Terkait dengan pengukuran prioritas perbaikan pelayanan klinis yang ditetapkan oleh Direktur, maka direktur bersama-sama dengan pimpinan medis, ketua komite medik menetapkan paling sedikit 5 evaluasi pelayanan prioritas standar pelayanan kedokteran. 1. Terlaksananya evaluasi CP dengan Komite Medik 2. Terlaksananya audit medis dengan Pimpinan Medis dan Komite Medik
9.	Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien	Sistem pelaporan dan pembelajaran keselamatan pasien di rumah sakit (SP2KP-RS) meliputi kejadian sentinel, Kejadian yang Tidak Diharapkan (KTD), Kejadian Tidak Cedera (KTC), Kejadian Nyaris Cedera (KNC) dan Kejadian Potensial Cedera (KPC). Mekanisme pelaporan insiden keselamatan pasien baik internal maupun eksternal, grading matriks risiko serta investigasi dan analisa insiden berdasarkan hasil grading. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut: 1. Terlaksananya pelaporan IKP secara internal ke tim KPRS 2. Terlaksananya investigasi dan perbaikan berdasarkan risk matrix grading 3. Terlaksana pelaporan IKP ke representative pemilik 4. Terlaksananya pelaporan IKP secara eksternal ke KNKP
10.	Pengukuran Budaya Keselamatan	Pengukuran budaya keselamatan pasien perlu dilakukan oleh RS dengan melakukan survei budaya keselamatan pasien setiap tahun. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut: 1. Terlaksananya pengukuran budaya keselamatan 2. Terlaksananya analisa dan tindak lanjut hasil budaya keselamatan
11.	Penerapan Manajemen Risiko	Komite Mutu membuat daftar risiko tingkat rumah sakit berdasarkan daftar risiko yang dibuat tiap unit setiap tahun. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut: 1. Melakukan identifikasi risiko ditingkat unit dan tingkat RS 2. Menyusun Risk register 3. Menyusun strategi untuk menurunkan risiko 4. Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap risiko di unit 5. Terlaksananya pelaporan hasil monitoring kepada direktur dan representative pemilik

		6. Menyusun FMEA 7. Melakukan monitoring tindak lanjut FMEA
--	--	--

3.2. Sasaran

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
1.	Penambahan Ketua Komite PMKP full time (diutamakan dengan latar pendidikan Dokter Umum)	Optimalisasi program & strategi pelaksanaan PMKP	Dokter Umum	Rekrutmen	Terpenuhi	Penambahan 1 staff untuk Ketua Komite PMKP	-
2.	Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) dan Manajemen Resiko	Meningkatkan pengetahuan, softskill dalam manajerial tim PMKP	1. Ketua PMKP 2. Sekretaris PMKP 3. Ketua Sub Komite Peningkatan Mutu 4. Ketua Sub Keselamatan Pasien 5. Ketua Sub Manajemen Risiko	Diklat	1 kali dalam setahun	Adanya : 1. Sertifikat 2. Materi 3. Laporan 4. Surat Tugas	Diklat diselenggarakan oleh KARS
3.	Pelatihan Penyusunan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan Root Cause Analysis (RCA)	Meningkatkan pengetahuan, softskill dalam manajerial tim PMKP	1. Ketua PMKP 2. Sekretaris PMKP 3. Ketua Sub Keselamatan Pasien	Diklat	1 kali dalam setahun	Adanya : 1. Sertifikat 2. Materi 3. Laporan 4. Surat Tugas	Diklat diselenggarakan oleh KARS

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
4.	Pelatihan Implementasi Kendali Mutu Biaya pada bab PMKP	Meningkatkan pengetahuan, softskill dalam manajerial tim PMKP	1. Ketua Komite PMKP 2. Sekretaris PMKP 3. Ketua Sub Komite Peningkatan Mutu	Diklat	1 kali dalam setahun	Adanya : 1. Sertifikat 2. Materi 3. Laporan 4. Surat Tugas	Diklat diselenggarakan oleh KARS
5.	Orientasi Umum - Pengenalan Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) di RS Prima Husada Sukorejo	Meningkatkan pengetahuan karyawan baru terkait program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) di RS Prima Husada Sukorejo	Karyawan Baru	Pembelajaran Kontekstual	Terpenuhi	1. 100% karyawan baru mengikuti pelatihan 2. 100% karyawan baru yang mengikuti pelatihan mengalami peningkatan pengetahuan & keterampilan	-
6.	<i>Refreshment & Training</i> PMKP Materi: 1. Indikator Mutu Nasional, Indikator Mutu Prioritas RS, Indikator Mutu Unit 2. Macam-macam Insiden Keselamatan	Memperkuat dan memperbarui pengetahuan serta keterampilan terkait program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) di	All Staff	Sosialisasi & Pelatihan	100% karyawan	1. 100% karyawan mengikuti pelatihan 2. 100% karyawan yang mengikuti pelatihan mengalami peningkatan	

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	Pasien dan Alur Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien 3. Budaya Keselamatan Pasien 4. Manajemen Resiko	RS Prima Husada Sukorejo				pengetahuan & keterampilan	
7	Pelatihan Pengambilan Data Mutu Materi: 1. Refreshment Indikator Mutu yang berlaku di Unit 2. Alur Pengumpulan Data Mutu baik di SIMRS maupun <i>Google Spreadsheet</i> 3. Cara analisa permasalahan sesuai dengan kondisi di unit sampai dengan tindak lanjut perbaikan 4. Praktik mengumpulkan data Mutu baik di SIMRS maupun <i>Google Spreadsheet</i> <i>by name.</i>	Meningkatnya kemampuan PIC Mutu Unit dalam pengumpulan data, analisa data, dan interpretasi data	PIC Mutu Unit	Pelatihan Internal	1 kali dalam setahun	1. Semua PIC dapat mengumpulkan, menganalisa dan menginterpretasi indikator mutu unit nya 2. Semua PIC mutu mendapatkan sertifikat pelatihan pengambilan data mutu	

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	5. Praktik mengunduh laporan mutu di SIMRS						
8.	Pelatihan terkait pengisian CP di Unit Materi: 1. Refreshment Praktik Klinis yang dilakukan Audit 2. Pengisian Form CP di Google Spreadsheet	Meningkatnya kemampuan PPA (Profesional Pemberi Asuhan) pengumpulan data, analisa data, dan interpretasi data	Karu Rawat Inap, Dokter, Gizi, Farmasi	Pelatihan Internal	1 kali dalam setahun	1. Semua PPA dapat mengisi Form CP 2. Semua PPA mendapatkan sertifikat pelatihan pengisian CP	
9.	Regulasi terkait Komite Mutu. Regulasi di review dan di buat sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak ada regulasi yang <i>expired</i> . Regulasi yang perlu di review yakni: 1. Penetapan SK Komite Mutu 2. Penetapan SK PJ Mutu 3. Penetapan SK PIC Mutu 4. Penetapan SK Validator Mutu	Memperbarui regulasi mutu sesuai dengan undang-undang / PMK yang berlaku	Komite PMKP	Review Dokumen Regulasi	1 kali dalam setahun	Regulasi dapat terbaru sesuai UU/PMK/Pedoman Terbaru	

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	5. Penetapan Pedoman Komite Mutu RS 6. Penetapan Program Kerja Komite Mutu RS 7. Penetapan tentang Sistem Pelaporan dan Pembelajaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit (SP2KP RS) 8. Penetapan tentang Program Budaya Keselamatan Rumah Sakit 9. Penetapan tentang Program Manajemen Risiko Tingkat Rumah Sakit						
10.	Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM). Indikator Nasional Mutu adalah indikator mutu nasional yang wajib dilakukan pengukuran	Sebagai tolak ukur kepatuhan dan bahan analisa capaian RS dalam menjalankan INM	Setiap Unit di RS	Observasi lapangan	Setiap bulan	Indikator Nasional Mutu terlaksana dengan data real dan sesuai dengan kondisi lapangan	

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	dan digunakan sebagai informasi mutu secara nasional. Adapun Indikator Nasional Mutu (INM) adalah sebagai berikut: 1. Kepatuhan kebersihan tangan ($\geq 85\%$) 2. Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (100%) 3. Kepatuhan identifikasi pasien (100%) 4. Waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi ($>80\%$) 5. Waktu tunggu rawat jalan ($\geq 80\%$) 6. Penundaan operasi elektif ($<5\%$) 7. Kepatuhan waktu visite dokter ($\geq 80\%$)						

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	8. Pelaporan hasil kritis laboratorium (100%) 9. Kepatuhan penggunaan formularium nasional ($\geq 80\%$) 10. Kepatuhan terhadap alur klinis (<i>Clinical Pathway</i>) ($\geq 80\%$) 11. Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh (100%) 12. Kecepatan waktu tanggap komplain ($\geq 80\%$) 13. Kepuasan pasien (76.61%) Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut: a. Terlaksananya pengumpulan dan analisa data b. Terlaksananya pelaporan indikator mutu						

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	Nasional ke Aplikasi SIMAR c. Terlaksananya rencana perbaikan & pelaksanaan perbaikan d. Terlaksananya monitoring indikator nasional mutu						
11.	Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit (IMP-RS) 1. Direkur beserta Komite Mutu RS. Prima Husada Sukorejo melakukan persiapan berupa pertemuan atau rapat dengan seluruh kepala ruangan, sehingga ada kesamaan pengertian tentang mutu, keselamatan pasien dan manajemen risiko sehingga ditemukan kesepakatan tentang langkah-langkah	Memilih Indikator Mutu Prioritas RS 2025 pada tahun 2024, untuk dilakukan target perbaikan pada tahun 2025	Pelayanan Bedah	FGD (<i>Focus Group Discussion</i>)	1. Penentuan IMP RS dilakukan 1 kali dalam setahun 2. Pengambilan data IMP RS dilakukan setiap hari 3. Pelaporan Capaian Indikator Mutu dilakukan setiap bulan	1. Indikator Mutu Prioritas RS terlaksana dengan data real dan sesuai dengan kondisi lapangan 2. Adanya SK penetapan Indikator Mutu Prioritas RS	

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	kegiatan yang akan dilakukan. 2. Pemilihan Indikator Mutu Prioritas RS (IMP-RS) dan sesuai dengan TKRS 5 mencakup: a. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien (ISKP) b. Indikator Pelayanan Klinis Prioritas c. Indikator sesuai Tujuan Strategis Rumah Sakit (KPI) d. Indikator terkait Perbaikan Sistem e. Indikator terkait Manajemen Risiko 3. Indikator pelayanan klinis prioritas ditetapkan melalui SK penetapan direktur. 4. Terlaksananya pengumpulan data, analisa, interpretasi data dan <i>feedback</i> data 5. Terlaksananya pelaporan capaian						

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	indikator mutu prioritas RS						
12.	Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Unit Indikator Mutu Prioritas Unit (IMP – Unit) adalah indikator prioritas yang khusus dipilih kepala unit terdiri dari minimal 1 indikator. Adapun uraiannya sebagai berikut: 1. Terlaksananya pemilihan Indikator Mutu Unit 2. Terlaksananya penetapan Indikator Mutu Unit a. IGD b. Instalasi Rawat Jalan c. Instalasi Rawat Inap 2A d. Instalasi Rawat Inap 2B e. Instalasi Rawat Inap 3A f. Instalasi Rawat Inap 3B	Memilih Indikator Mutu Prioritas Unit 2025 pada tahun 2024, untuk dilakukan target perbaikan pada tahun 2025	Setiap unit di RS	FGD	1. Penentuan IMP Unit dilakukan 1 kali dalam setahun 2. Pengambilan data IMP Unit dilakukan setiap hari 3. Pelaporan Capaian Indikator Mutu dilakukan setiap bulan	1. Indikator Mutu Prioritas Unit terlaksana dengan data real dan sesuai dengan kondisi lapangan 2. Adanya SK penetapan Indikator Mutu Prioritas Unit	

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	g. Instalasi Kamar Operasi h. Maternitas i. Ponsek j. Neonatologi k. ICU l. Radiologi m. Laboratorium n. Rehab Medis o. Farmasi p. Gizi q. Rekam Medis r. Limbah-K3RS s. SDM t. Kesekretariatan u. Driver v. Pemulasaran Jenazah w. ATEM-IPSRs x. Laundry y. CSSD z. Cleaning Service aa. Keamanan bb. Gudang Umum cc. PPI dd. PKRS ee. Verifikator ff. Humas & Marketing gg. MOD-MPP-PIPP hh. TB di IRJA						

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	ii. Keuangan jj. HIV kk. KB ll. Stunting mm. IT-SIMRS 3. Terlaksananya pengumpulan dan analisa data 4. Terlaksananya pelaporan indikator mutu unit 5. Terlaksananya rencana perbaikan & pelaksanaan perbaikan 6. Terlaksananya monitoring mutu unit kerja						
13.	Analisa, Pelaporan dan <i>feedback</i> data indikator mutu terintegrasi 1. Terlaksananya pengumpulan data indikator mutu oleh PIC disetiap unit kerja sesuai dengan profil indikator	Untuk mendata setiap indikator yang berlaku di setiap unit sebagai bahan yang digunakan untuk menganalisis perbaikan / berburukan dan	Setiap unit di RS	Observasi lapangan & Analisa data	1. Terlaksana 100% 2. Terlaksana 100% 3. Terlaksana 100% 4. Terlaksana 100% 5. Terlaksana 100%	Terlaksananya tindak lanjut untuk setiap unit yang melaporkan capaiannya	

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	2. Terlaksananya analisa data pencapaian indikator sesuai dengan ketentuan analisa data 3. Terlaksananya validasi data sesuai dengan ketentuan validasi data 4. Terlaksananya pelaporan data indikator mutu dari tingkat unit sampai dengan ke pemilik 5. Terlaksananya penyampaian <i>feedback</i> hasil capaian indikator mutu ke semua staf di unit kerja 6. Terlaksananya publikasi data indikator mutu. 7. Terlaksananya <i>benchmark</i> data	dilakukan tindaklanjut dan feedback perbaiki kepada setiap unit			6. Terlaksana 100% 7. Terlaksana 100%		
14.	Penerapan Standar Pelayanan Kedokteran di Rumah Sakit. Terkait dengan pengukuran prioritas	1. Untuk menilai efektivitas penerapan standar pelayanan kedokteran di rumah sakit	1. PPA (Profesional Pemberi Asuhan) yakni: a. DPJP b. Perawat/Bidan c. Gizi d. Farmasi	Observasi lapangan & Analisa data	1 bulan sekali	Terlaksananya audit medis di setiap pelayanan prioritas standar pelayanan kedokteran	

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	perbaikan pelayanan klinis yang ditetapkan oleh Direktur, maka direktur bersama-sama dengan pimpinan medis, ketua komite medik menetapkan paling sedikit 5 evaluasi pelayanan prioritas standar pelayanan kedokteran. 1. Terlaksananya evaluasi CP dengan Komite Medik 2. Terlaksananya audit medis dengan Pimpinan Medis dan Komite Medik	2. Untuk mengurangi variasi dari proses, hasil dan efisiensi biaya	2. Komite PMKP 3. Komite Medik				
15.	Sistem pelaporan dan pembelajaran keselamatan pasien di rumah sakit (SP2KP-RS) meliputi kejadian sentinel, Kejadian yang Tidak Diharapkan (KTD), Kejadian Tidak Cedera (KTC), Kejadian Nyaris	Sebagai bentuk partisipasi dan kepedulian petugas dalam meningkatkan budaya lapor IKP yang terjadi di unitnya dan sebagai bukti	Setiap unit di RS	Laporan IKP	1. Terlaksana setiap kali terjadi insiden 2. Terlaksana setiap kali terjadi insiden 3. Terlaksana setiap 3 bulan sekali	setiap IKP dilaporkan < 2 x 24 jam terutama KPC yang terjadi di unit	

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	Cedera (KNC) dan Kejadian Potensial Cedera (KPC). Mekanisme pelaporan insiden keselamatan pasien baik internal maupun eksternal, grading matriks risiko serta investigasi dan analisa insiden berdasarkan hasil grading. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut: 1. Terlaksananya pelaporan IKP secara internal ke tim KPRS 2. Terlaksananya investigasi dan perbaikan berdasarkan risk matrix grading 3. Terlaksana pelaporan IKP ke representative pemilik 4. Terlaksananya pelaporan IKP	bahwa RS telah memprioritaskan keselamatan pasien			4. Terlaksana setiap bulan sekali		

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	secara eksternal ke KNKP						
16.	Pengukuran budaya keselamatan pasien perlu dilakukan oleh RS dengan melakukan survei budaya keselamatan pasien setiap tahun. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut: 1. Terlaksananya pengukuran budaya keselamatan 2. Terlaksananya analisa dan tindak lanjut hasil budaya keselamatan	untuk mengukur tingkat budaya keselamatan pasien dan Menyusun program kerja keselamatan pasien pada tahun berikutnya	All Staf di RS Prima Husada Sukorejo	Survey	1 kali dalam setahun	Pengukuran dapat terlaksana dan dilaporkan kepada direktur & PT 1 kali dalam setahun	
17.	Komite Mutu membuat daftar resiko tingkat rumah sakit berdasarkan daftar risiko yang dibuat tiap unit setiap tahun. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut:	untuk menghindari risiko yang dimiliki di unit agar dapat terminimalisis kejadiannya dan menganalisis alur	Setiap unit di RS	Observasi dan analisa	1 kali dalam setahun	Tercatatnya risiko yang terjadi di setiap unit dan pengendalian risiko di unit dapat dilaksanakan sesuai dengan hasil pada risk register	

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	1. Melakukan identifikasi risiko ditingkat unit dan tingkat RS 2. Menyusun Risk register 3. Menyusun strategi untuk menurunkan risiko 4. Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap risiko di unit 5. Terlaksananya pelaporan hasil monitoring kepada direktur dan representative pemilik 6. Menyusun FMEA 7. Melakukan monitoring tindak lanjut FMEA	sebelum insidennya terjadi					

3.3. Cara Melaksanakan Kegiatan

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
1.	Penambahan Ketua Komite PMKP full time (diutamakan dengan latar pendidikan Dokter Umum)	1. Pengajuan SDM 2. Rekrutmen Staff	Seleksi Kompetensi	Media Poster	Januari 2025	1. Poster Rekrutmen 2. Kontrak Kerja 3. SK Pegawai	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
2.	Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) dan Manajemen Resiko	1. Pengajuan pelatihan eksternal ke SDM	Diklat Eksternal	- Google Zoom - Datang langsung ke penyelenggaraan pelatihan	Tentatif (Menyesuaikan Jadwal dari KARS)	1. Surat Tugas 2. Sertifikat 3. Materi 4. Laporan	
3.	Pelatihan Penyusunan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan Root Cause Analysis (RCA)	Pengajuan pelatihan eksternal ke SDM	Diklat Eksternal	- Google Zoom Datang langsung ke penyelenggaraan pelatihan	Tentatif (Menyesuaikan Jadwal dari KARS)	1. Surat Tugas 2. Sertifikat 3. Materi 4. Laporan	
4.	Pelatihan Implementasi Kendali Mutu Biaya pada bab PMKP	Pengajuan pelatihan eksternal ke SDM	Diklat Eksternal	- Google Zoom Datang langsung ke penyelenggaraan pelatihan	Tentatif (Menyesuaikan Jadwal dari KARS)	1. Surat Tugas 2. Sertifikat 3. Materi 4. Laporan	
5.	Orientasi Umum - Pengenalan Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) di RS Prima Husada Sukorejo	1. Undangan 2. Pelaksanaan 3. LPJ	Diklat Internal	- PPT - Google Classroom	Tentatif (Menyesuaikan Jadwal dari Perekrutan SDM)	1. UMANDOK 2. Hasil Pre & Post Test 3. LPJ	
6.	<i>Refreshment & Training</i> PMKP Materi:	1. Pengajuan TOR 2. Pelaksanaan 3. LPJ	Diklat Internal	- PPT Google Classroom	Bulan Maret 2025 Bulan Juni 2025 Bulan Desember 2025	1. TUMANDOK 2. Hasil Pre & Post Test 3. Sertifikat 4. LPJ	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	1. Indikator Mutu Nasional, Indikator Mutu Prioritas RS, Indikator Mutu Unit 2. Macam-macam Insiden Keselamatan Pasien dan Alur Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien 3. Budaya Keselamatan 4. Manajemen Resiko						
7.	Pelatihan Pengambilan Data Mutu Materi: 1. Refreshment Indikator Mutu yang berlaku di Unit 2. Alur Pengumpulan Data Mutu baik di SIMRS maupun <i>Google Spreadsheet</i> 3. Cara analisa permasalahan sesuai dengan kondisi di unit sampai dengan tindak lanjut perbaikan 4. Praktik mengumpulkan data Mutu baik di SIMRS maupun <i>Google Spreadsheet by name.</i>	1. Undangan 2. Pelaksanaan 3. LPJ	Diklat Internal	- PPT - SIMRS - Google Classroom - Google Spreadsheet	Bulan Januari 2025	1. UMANDOK 2. Hasil Pre & Post Test 3. LPJ	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	5. Praktik mengunduh laporan mutu di SIMRS						
8.	Pelatihan terkait pengisian CP di Unit Materi: - Refreshment Praktik Klinis yang dilakukan Audit - Pengisian Form CP di Google Spreadsheet	- Pengajuan TOR - Pelaksanaan - LPJ	Diklat Internal	- PPT - Google Spreadsheet	Bulan Januari 2025	- TUMANDOK - Hasil Pre & Post Test - Sertifikat - LPJ	
9.	Regulasi terkait Komite Mutu. Regulasi di review dan di buat sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak ada regulasi yang <i>expired</i> . Regulasi yang perlu di review yakni: - Penetapan SK Komite Mutu - Penetapan SK PJ Mutu - Penetapan SK PIC Mutu - Penetapan SK Validator Mutu - Penetapan Pedoman Komite Mutu RS	Membandingkan peraturan baru dan pedoman / SPO / Alur yang dimiliki oleh komite mutu	Review dokumen	Pedoman	Bulan Januari 2025	Perbaikan regulasi	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	6. Penetapan Program Kerja Komite Mutu RS 7. Penetapan tentang Sistem Pelaporan dan Pembelajaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit (SP2KP RS) 8. Penetapan tentang Program Budaya Keselamatan Rumah Sakit 9. Penetapan tentang Program Manajemen Risiko Tingkat Rumah Sakit						
10.	Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM). Indikator Nasional Mutu adalah indikator mutu nasional yang wajib dilakukan pengukuran dan digunakan sebagai informasi mutu secara nasional. Adapun Indikator Nasional Mutu (INM) adalah sebagai berikut:	Melakukan pemantauan secara berkesinambungan melalui pengecekan pengambilan data, kevalidan dari lembar laporan harian kepada setiap kepala ruangan	Observasi lapangan	Instrumen pangambilan data	Januari – Desember 2025	UMANDOK	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	1. Kepatuhan kebersihan tangan ($\geq 85\%$) 2. Kepatuhan penggunaan alat pelindung diri (100%) 3. Kepatuhan identifikasi pasien (100%) 4. Waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi ($>80\%$) 5. Waktu tunggu rawat jalan ($\geq 80\%$) 6. Penundaan operasi elektif ($<5\%$) 7. Kepatuhan waktu visite dokter ($\geq 80\%$) 8. Pelaporan hasil kritis laboratorium (100%) 9. Kepatuhan penggunaan formularium nasional ($\geq 80\%$) 10. Kepatuhan terhadap alur klinis (<i>Clinical Pathway</i>) ($\geq 80\%$) 11. Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh (100%)						

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	12. Kecepatan waktu tanggap komplain ($\geq 80\%$) 13. Kepuasan pasien (76.61%) Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut: - Terlaksananya pengumpulan dan analisa data - Terlaksananya pelaporan indikator mutu Nasional ke Aplikasi SIMAR - Terlaksananya rencana perbaikan & pelaksanaan perbaikan - Terlaksananya monitoring indikator nasional mutu						
11.	Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit (IMP-RS): Direkur beserta Komite Mutu RS. Prima Husada Sukorejo melakukan persiapan berupa pertemuan atau rapat	Diskusi Bersama dengan kepala ruang, PIC, komite dan direksi untuk dilakukan grading dalam menentukan layanan prioritas yang akan di	FGD	Diskusi & tanya jawab	Oktober – Desember 2024	UMANDOK	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	dengan seluruh kepala ruangan, sehingga ada kesamaan pengertian tentang mutu, keselamatan pasien dan manajemen risiko sehingga ditemukan kesepakatan tentang langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan. 2. Pemilihan Indikator Mutu Prioritas RS (IMP-RS) dan sesuai dengan TKRS 5 mencakup: a. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien (ISKP) b. Indikator Pelayanan Klinis Prioritas c. Indikator sesuai Tujuan Strategis Rumah Sakit (KPI) d. Indikator terkait Perbaikan Sistem e. Indikator terkait Manajemen Risiko 3. Indikator pelayanan klinis prioritas ditetapkan	selesaikan pada tahun mendatang					

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	melalui SK penetapan direktur. 4. Terlaksananya pengumpulan data, analisa, interpretasi data dan <i>feedback</i> data 5. Terlaksananya pelaporan capaian indikator mutu prioritas RS						
12.	Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Unit Indikator Mutu Prioritas Unit (IMP – Unit) adalah indikator prioritas yang khusus dipilih kepala unit terdiri dari minimal 1 indikator. Adapun uraiannya sebagai berikut: 1. Terlaksananya pemilihan Indikator Mutu Unit 2. Terlaksananya penetapan Indikator Mutu Unit a. IGD b. Instalasi Rawat Jalan c. Instalasi Rawat Inap 2A	Diskusi Bersama dengan kepala ruang, PIC, komite dan direksi untuk menjelaskan maslaah yang terjadi di setiap unit, SPM dan memilih masalah yang akan di gunakan sebagai indikator mutu unit pada tahun mendatang	FGD	Instrumen pangambilan data	Oktober – Desember 2024	UMANDOK	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	d. Instalasi Rawat Inap 2B e. Instalasi Rawat Inap 3A f. Instalasi Rawat Inap 3B g. Instalasi Kamar Operasi h. Maternitas i. Ponak j. Neonatologi k. ICU l. Radiologi m. Laboratorium n. Rehab Medis o. Farmasi p. Gizi q. Rekam Medis r. Limbah-K3RS s. SDM t. Kesekretariatan u. Driver v. Pemulasaran Jenazah w. ATEM-IPSRS x. Laundry y. CSSD z. Cleaning Service aa. Keamanan bb. Gudang Umum						

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	cc. PPI dd. PKRS ee. Verifikator ff. Humas & Marketing gg. MOD-MPP-PIPP hh. TB di IRJA ii. Keuangan jj. HIV kk. KB ll. Stunting mm. IT-SIMRS 3. Terlaksananya pengumpulan dan analisa data						
13.	Analisa, Pelaporan dan <i>feedback</i> data indikator mutu terintergrasi 1. Terlaksananya pengumpulan data indikator mutu oleh PIC di setiap unit kerja sesuai dengan profil indikator 2. Terlaksananya analisa data pencapaian indikator sesuai dengan ketentuan analisa data 3. Terlaksananya validasi data sesuai dengan ketentuan validasi data	Melakukan pemantauan secara berkesinambungan melalui pengecekan pengambilan data, kevalidan dari lembar laporan harian kepada setiap kepala ruangan	Observasi lapangan & Analisa data	Instrumen pengambilan data	Januari – desember 2025	UMANDOK	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	4. Terlaksananya pelaporan data indikator mutu dari tingkat unit sampai dengan ke pemilik 5. Terlaksananya penyampaian <i>feedback</i> hasil capaian indikator mutu ke semua staf di unit kerja 6. Terlaksananya publikasi data indikator mutu 7. Terlaksananya <i>benchmark</i> data						
14.	Penerapan Standar Pelayanan Kedokteran di Rumah Sakit. Terkait dengan pengukuran prioritas perbaikan pelayanan klinis yang ditetapkan oleh Direktur, maka direktur bersama-sama dengan pimpinan medis, ketua komite medik menetapkan paling sedikit 5 evaluasi pelayanan prioritas standar pelayanan kedokteran.	Melakukan pemantauan CP Pasien dengan membandingkan observasi lapangan	Observasi lapangan & Analisa data	Instrumen pangambilan data	Januari – desember 2025	UMANDOK	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	1. Terlaksananya evaluasi CP dengan Komite Medik 2. Terlaksananya audit medis dengan Pimpinan Medis dan Komite Medik						
15.	Sistem pelaporan dan pembelajaran keselamatan pasien di rumah sakit (SP2KP-RS) meliputi kejadian sentinel, Kejadian yang Tidak Diharapkan (KTD), Kejadian Tidak Cedera (KTC), Kejadian Nyaris Cedera (KNC) dan Kejadian Potensial Cedera (KPC). Mekanisme pelaporan insiden keselamatan pasien baik internal maupun eksternal, grading matriks risiko serta investigasi dan analisa insiden berdasarkan hasil grading. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut: 1. Terlaksananya pelaporan IKP secara internal ke tim KPRS	Melaporkan insiden yang terjadi di unit menggunakan form laporan dan billing RS	Laporan langsung / tidak langsung	Instrumen pangambilan data	Januari – desember 2025	UMANDOK	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	2. Terlaksananya investigasi dan perbaikan berdasarkan risk matrix grading 3. Terlaksana pelaporan IKP ke representative pemilik 4. Terlaksananya pelaporan IKP secara eksternal ke KNKP						
16.	Pengukuran budaya keselamatan pasien perlu dilakukan oleh RS dengan melakukan survei budaya keselamatan pasien setiap tahun. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut: 1. Terlaksananya pengukuran budaya keselamatan 2. Terlaksananya analisa dan tindak lanjut hasil budaya keselamatan	Melakukan survei secara online menggunakan google form dengan sasaran seluruh petugas	Survey	Instrumen pangambilan data	Juni 2025	UMANDOK	
17.	Komite Mutu membuat daftar resiko tingkat rumah sakit berdasarkan daftar risiko	Melakukan Analisa resiko yang mungkin terjadi di unitnya Bersama dengan kepala	Observasi dan analisa	Instrumen pangambilan data	Desember 2024	UMANDOK	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	yang dibuat tiap unit setiap tahun. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut: 1. Melakukan identifikasi risiko ditingkat unit dan tingkat RS 2. Menyusun Risk register 3. Menyusun strategi untuk menurunkan risiko 4. Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap risiko di unit 5. Terlaksananya pelaporan hasil monitoring kepada direktur dan representative pemilik 6. Menyusun FMEA 7. Melakukan monitoring tindak lanjut FMEA	ruang dan tim manajemen risiko dan membuat risk register					

3.4. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

NO	KEGIATAN	SASARAN	BULAN 2025												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET
			12/ 24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Penambahan Ketua Komite PMKP full time (diutamakan dengan latar pendidikan Dokter Umum)	Dokter Umum		√												RSPHS	SDM RS	PT Disa Prima Medika
2.	Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) dan Manajemen Resiko	1. Ketua PMKP 2. Sekretaris PMKP 3. Ketua Sub Komite Peningkatan Mutu 4. Ketua Sub Keselamatan Pasien 5. Ketua Sub Manajemen Risiko	Tentatif menyesuaikan Jadwal Pelatihan PMKP dan Manajemen Risiko dari KARS												Tergantung Penyelenggaraan	SDM RS	PT Disa Prima Medika	
3.	Pelatihan Penyusunan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan Root Cause Analysis (RCA)	1. Ketua PMKP 2. Sekretaris PMKP 3. Ketua Sub Keselamatan Pasien	Tentatif menyesuaikan Jadwal Pelatihan PMKP dan Manajemen Risiko dari KARS												Tergantung Penyelenggaraan	SDM RS	PT Disa Prima Medika	
4.	Pelatihan Implementasi Kendali	1. Ketua PMKP 2. Sekretaris PMKP														Zoom	SDM RS	PT Disa Prima Medika

NO	KEGIATAN	SASARAN	BULAN 2025												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET
			12/ 24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Mutu Biaya pada bab PMKP	3. Ketua Sub Komite Peningkatan Mutu	9&10 Desember 2024															
5.	Orientasi Umum - Pengenalan Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) di RS Prima Husada Sukorejo	Karyawan Baru	Tentatif menyesuaikan Jadwal Orientasi dari SDM RS Prima Husada Sukorejo												Hall Sakura RSPH Sukorejo	Komite PMKP	-	
6.	<i>Refreshment & Training PMKP</i> Materi: 1. Indikator Mutu Nasional, Indikator Mutu Prioritas RS, Indikator Mutu Unit 2. Macam-macam Insiden Keselamatan Pasien dan Alur Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien 3. Budaya Keselamatan 4. Manajemen Resiko	Seluruh Staff di RS Prima Husada Sukorejo				√			√						√	Hall Sakura RSPH Sukorejo	Komite PMKP	-

NO	KEGIATAN	SASARAN	BULAN 2025												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET	
			12/ 24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12
7.	Pelatihan Pengambilan Data Mutu Materi: 1. Refreshment Indikator Mutu yang berlaku di Unit 2. Alur Pengumpulan Data Mutu baik di SIMRS maupun <i>Google Spreadsheet</i> 3. Cara analisa permasalahan sesuai dengan kondisi di unit sampai dengan tindak lanjut perbaikan 4. Praktik mengumpulkan data Mutu baik di SIMRS maupun <i>Google Spreadsheet by name.</i> 5. Praktik mengunduh	PIC Data Mutu Unit		√												Hall Andalusia Lantai 3 RSPH Sukorejo	Komite PMKP	-	

NO	KEGIATAN	SASARAN	BULAN 2025												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET
			12/ 24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	laporan mutu di SIMRS																	
8.	Pelatihan terkait pengisian CP di Unit Materi: 1. Refreshment Praktik Klinis yang dilakukan Audit 2. Pengisian Form CP di Google Spreadsheet	Karu Rawat Inap, Dokter, Gizi, Farmasi		√												Hall Andalusia Lantai 3 RSPH Sukorejo	Komite PMKP Komite Medik	-
9.	Regulasi terkait Komite Mutu. Regulasi yang perlu di review yakni:			√														
	a. Penetapan SK Komite Mutu	Direktur RS		√												Sekretariat	Komite PMKP	-
	b. Penetapan SK PJ Mutu	Komite PMKP		√														
	c. Penetapan SK PIC Mutu	Komite PMKP		√														
	d. Penetapan SK Validator Mutu	Direktur RS		√														

NO	KEGIATAN	SASARAN	BULAN 2025												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET
			12/ 24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	e. Penetapan Pedoman Komite Mutu RS	Direktur RS		√														
	f. Penetapan Program Kerja Komite Mutu RS	Direktur RS		√														
	g. Penetapan tentang Sistem Pelaporan dan Pembelajaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit (SP2KP RS)	Direktur RS		√														
	h. Penetapan tentang Program Budaya Keselamatan Rumah Sakit	Direktur RS		√														
	i. Penetapan tentang Program Manajemen Risiko Tingkat Rumah Sakit	Direktur RS		√														
10.	Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM). Indikator Nasional Mutu adalah indikator mutu nasional yang wajib dilakukan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			

NO	KEGIATAN	SASARAN	BULAN 2025												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET	
			12/ 24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12
	pengukuran dan digunakan sebagai informasi mutu secara nasional.																		
	a. Terlaksananya pengumpulan dan analisa data	All Unit	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	b. Terlaksananya pelaporan indikator mutu Nasional ke Aplikasi SIMAR	Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	c. Terlaksananya rencana perbaikan & pelaksanaan perbaikan	Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	d. Terlaksananya monitoring indikator nasional mutu	Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
11.	Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit (IMP-RS):			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
	Direkur beserta Komite Mutu RS. Prima Husada Sukorejo melakukan persiapan berupa pertemuan	Direktur RS & Komite PMKP	√													Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-

NO	KEGIATAN	SASARAN	BULAN 2025												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET	
			12/ 24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12
	atau rapat dengan seluruh kepala ruangan, sehingga ada kesamaan pengertian tentang mutu, keselamatan pasien dan manajemen risiko sehingga ditemukan kesepakatan tentang langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan.																		
	Pemilihan Indikator Mutu Prioritas RS (IMP-RS) dan sesuai dengan TKRS 5 mencakup: a. Indikator Sasaran Keselamatan Pasien (ISKP) b. Indikator Pelayanan Klinis Prioritas c. Indikator sesuai Tujuan Strategis Rumah Sakit (KPI) d. Indikator terkait Perbaikan Sistem	Direktur RS & Komite PMKP	√													Hall Andalusia Lantai 3	Komite PMKP	-	-

NO	KEGIATAN	SASARAN	BULAN 2025												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET	
			12/ 24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12
	e. Indikator terkait Manajemen Risiko																		
	Indikator pelayanan klinis prioritas ditetapkan melalui SK penetapan direktur	Direktur RS	√													Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	Terlaksananya pengumpulan data, analisa, interpretasi data dan <i>feedback</i> data	Komite PMKP		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	Terlaksananya pelaporan capaian indikator mutu prioritas RS	Komite PMKP		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	12.	Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Unit Indikator Mutu Prioritas Unit (IMP – Unit) adalah indikator prioritas yang khusus dipilih kepala unit terdiri dari minimal 1 indikator.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				

NO	KEGIATAN	SASARAN	BULAN 2025												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET	
			12/ 24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12
	Terlaksananya pemilihan Indikator Mutu Unit	Komite PMKP Kepala Unit	√													Hall Andalusia Lantai 3	Komite PMKP	-	-
	Terlaksananya penetapan Indikator Mutu Unit		√																
	a. IGD																		
	b. Instalasi Rawat Jalan																		
	c. Instalasi Rawat Inap 2A																		
	d. Instalasi Rawat Inap 2B																		
	e. Instalasi Rawat Inap 3A																		
	f. Instalasi Rawat Inap 3B																		
	g. Instalasi Kamar Operasi																		
	h. Maternitas																		
	i. Ponek																		
	j. Neonatologi																		
	k. ICU																		
	l. Radiologi																		
	m. Laboratorium																		
	n. Rehab Medis																		
	o. Farmasi																		
	p. Gizi																		
	q. Rekam Medis																		

NO	KEGIATAN	SASARAN	BULAN 2025												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET
			12/ 24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	r. Limbah-K3RS s. SDM t. Kesekretariatan u. Driver v. Pemulasaran Jenazah w. ATEM-IPSRS x. Laundry y. CSSD z. Cleaning Service aa. Keamanan bb. Gudang Umum cc. PPI dd. PKRS ee. Verifikator ff. Humas & Marketing gg. MOD-MPP-PIPP hh. TB di IRJA ii. Keuangan jj. HIV kk. KB ll. Stunting mm. IT-SIMRS																	
	Terlaksananya pengumpulan dan analisa data	Komite PMKP Kepala Unit		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-
13	Analisa, Pelaporan dan <i>feedback</i> data		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				

NO	KEGIATAN	SASARAN	BULAN 2025												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET	
			12/ 24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12
	indikator mutu terintergrasi																		
	a. Terlaksananya pengumpulan data indikatotor mutu oleh PIC disetiap unit kerja sesuai dengan profil indikator	Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	b. Terlaksananya analisa data pencapaian indikator sesuai dengan ketentuan analisa data	Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	c. Terlaksananya validasi data sesuai dengan ketentuan	Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	d. Terlaksananya pelaporan data indikator mutu dari tingkat unit sampai dengan ke pemilik	PIC Data Mutu Kepala Unit Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	e. Terlaksananya penyampaian <i>feedback</i> hasil	Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-

NO	KEGIATAN	SASARAN	BULAN 2025												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET	
			12/ 24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12
	capaian indikator mutu ke semua staf di unit kerja																		
	f. Terlaksananya publikasi data indikator mutu	Komite PMKP		√			√			√			√			Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	g. Terlaksananya <i>benchmark</i> data	Komite PMKP		√			√			√			√			Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
14.	Penerapan Standar Pelayanan Kedokteran di Rumah Sakit.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
	a. Terlaksananya evaluasi CP dengan Komite Medik	Komite Medik Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	b. Terlaksananya audit medis dengan Pimpinan Medis dan Komite Medik	Komite Medik Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
15.	Sistem pelaporan dan pembelajaran keselamatan pasien di rumah sakit (SP2KP-RS) meliputi kejadian sentinel, Kejadian yang Tidak		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				

NO	KEGIATAN	SASARAN	BULAN 2025												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET	
			12/ 24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12
	Diharapkan (KTD), Kejadian Tidak Cedera (KTC), Kejadian Nyaris Cedera (KNC) dan Kejadian Potensial Cedera (KPC). Mekanisme pelaporan insiden keselamatan pasien baik internal maupun eksternal, grading matriks risiko serta investigasi dan analisa insiden berdasarkan hasil grading.																		
	a. Terlaksananya pelaporan IKP secara internal ke tim KPRS	Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	b. Terlaksananya investigasi dan perbaikan berdasarkan risk matrix grading	Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	c. Terlaksananya pelaporan IKP ke representative pemilik	Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-

NO	KEGIATAN	SASARAN	BULAN 2025												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET	
			12/ 24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12
	d. Terlaksananya pelaporan IKP secara eksternal ke KNKP	Komite PMKP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
16.	Pengukuran budaya keselamatan pasien perlu dilakukan oleh RS dengan melakukan survei budaya keselamatan pasien setiap tahun.								√										
	a. Terlaksananya pengukuran budaya keselamatan	All Karyawan RSPH Sukorejo							√							Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	b. Terlaksananya analisa dan tindak lanjut hasil budaya keselamatan	Komite PMKP							√	√						Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
17.	Komite Mutu membuat daftar resiko tingkat rumah sakit berdasarkan daftar risiko yang dibuat tiap unit setiap tahun.		√																
	a. Melakukan identifikasi risiko	All Unit	√													Hall Andalusia Lantai 3	Komite PMKP	-	-

NO	KEGIATAN	SASARAN	BULAN 2025												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET	
			12/ 24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12
	ditingkat unit dan tingkat RS																Komite PPI Komite K3RS		
	b. Menyusun Risk register	Komite PMKP	√													Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	c. Menyusun strategi untuk menurunkan risiko	Komite PMKP	√													Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	d. Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap risiko di unit	Komite PMKP	√													Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	e. Terlaksananya pelaporan hasil monitoring kepada direktur dan representative pemilik	Komite PMKP	√													Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	f. Menyusun FMEA	Komite PMKP	√													Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-
	g. Melakukan monitoring tindak lanjut FMEA	Komite PMKP	√													Tempat Unit Masing-Masing	Komite PMKP	-	-

Kebutuhan Anggaran

Semua anggaran akan dibiayai dari anggaran RS Prima Husada Sukorejo yang telah disetujui oleh PT. Disa Prima Medika dengan rincian sebagaimana terlampir:

Tabel 3.5. Kebutuhan biaya pengembangan SDM Komite PMKP tahun 2025

No	Kegiatan/Rincian Kegiatan	Internal Eksternal	Jumlah (Satuan)	Harga Satuan	Total
1	Penambahan Ketua Komite PMKP full time (diutamakan dengan latar pendidikan Dokter Umum)	Eksternal	1	Rp 20.000	Rp 20.000
2	Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) dan Manajemen Resiko	Eksternal	5	Rp 5.000.000	Rp 25.000.000
3	Pelatihan Penyusunan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dan Root Cause Analysis (RCA)	Eksternal	3	Rp 3.500.000	Rp 10.500.000
4	Pelatihan Implementasi Kendali Mutu Biaya pada bab PMKP	Eksternal	3	Rp 2.000.000	Rp 6.000.000
5	Orientasi Umum - Pengenalan Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) di RS Prima Husada Sukorejo	Internal	3	Rp 20.000	Rp 60.000
6	<i>Refreshment & Training</i> PMKP Materi:	Internal	3	Rp 20.000	Rp 60.000

No	Kegiatan/Rincian Kegiatan	Internal Eksternal	Jumlah (Satuan)	Harga Satuan	Total
	a. Indikator Mutu Nasional, Indikator Mutu Prioritas RS, Indikator Mutu Unit b. Macam-macam Insiden Keselamatan Pasien dan Alur Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien c. Budaya Keselamatan d. Manajemen Resiko				
7	Pelatihan Pengambilan Data Mutu Materi: a. Refreshment Indikator Mutu yang berlaku di Unit b. Alur Pengumpulan Data Mutu baik di SIMRS maupun <i>Google Spreadsheet</i> c. Cara analisa permasalahan sesuai dengan kondisi di unit sampai dengan tindak lanjut perbaikan d. Praktik mengumpulkan data Mutu baik di SIMRS maupun <i>Google Spreadsheet by name.</i> e. Praktik mengunduh laporan mutu di SIMRS	Internal	2	Rp 20.000	Rp 40.000

No	Kegiatan/Rincian Kegiatan	Internal Eksternal	Jumlah (Satuan)	Harga Satuan	Total
8	Pelatihan terkait pengisian CP di Unit Materi: a. Refreshment Praktik Klinis yang dilakukan Audit b. Pengisian Form CP di Google Spreadsheet	Internal	2	Rp 20.000	Rp 40.000
9	Honorarium narasumber pelatihan insidentil (DPJP) 4 kali pelatihan x 4 org DPJP	Eksternal	20	Rp 250.000	Rp 5.000.000
TOTAL					Rp 46.720.000

C. PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT (PKRS)

1. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

NO	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1.	Peningkatan Sumber Daya Manusia	Pengadaan : 1) Penambahan staf PKRS yang full time (diutamakan latar Pendidikan DKV) Pelatihan Eksternal : 1) Manajemen PKRS 2) Pembuatan Media 3) Bimtek Edukator Kesehatan untuk Tenaga PKRS Pelatihan Internal : 1) Orientasi Umum – Pengenalan Program PKRS & Komunikasi Efektif Dasar 2) Refreshment Training : Komunikasi Efektif PPA & Non PPA 3) Peltihan Pembuatan media cetak, media audiovisual, media audio serta media social
2.	Pengembangan Media PKRS	Komunikasi Efektif adalah penyampaian informasi dari komunikator ke komunikan menggunakan media. Komunikasi dapat berjalan efektif jika media & metode yang digunakan sesuai dengan assessment kebutuhan pasien. Oleh karena itu penyediaan media juga harus direncanakan agar komunikasi dapat berjalan secara efektif dan efisien, berikut kebutuhan media PKRS yng ada di RS PHS : 1. Leaflet 2. Brosur 3. Flipchart / Lembar Balik 4. Poster 5. Banner 6. Media Sosial (IG, FB, YTB, TIKTOK) 7. Radio Sentral 8. Video 9. Papnisasi (Signage) 10. Pelabelan 11. IG 12. Tktok

NO	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
		13. Massa / Radio 14. WEB
3.	KIE Pasien & Keluarga Pasien	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi merupakan salah satu hak pasien dan keluarga oleh karena itu perencanaan program untuk KIE Pasien dan Keluarga harus dijadwalkan terutama untuk edukasi kelompok yang terdiri dari 5-10 orang. Sebagai Profesional Pemberi Asuhan (PPA) wajib memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien baik secara individu maupun kelompok, oleh karena itu disusun beberapa usulan program edukasi sebagai berikut : 1) KIE Individu 2) KIE Kelompok (5-10 orang) 3) KIE Massa (Seminar, Media Sosial, Radio)
4.	Pemberdayaan Komunitas Berbasis RSPHS	Sesuai dengan Permenkes No.44 Tahun 2018, sasaran PKRS juga meliputi Masyarakat sekitar RS, oleh karena itu komunitas Masyarakat di sekitar RS perlu diberdayakan diantaranya : 1) Forum Kesehatan Usia Lanjut (F-KUL) Melaksanakan pemberdayaan kepada lansia untuk mencapai Kesehatan geriatric melalui kegiatan senam lansia, pemeriksaan tensi gratis, dan penyuluhan Kesehatan. 2) Duta Online Peduli Ibu dan Anak (DOLINA) Melaksanakan pemberdayaan kepada ibu hamil untuk mencapai Kesehatan ibu dan anak melalui kegiatan senam hamil dan konsultasi Kesehatan seputar kehamilan dan perawatan bayi. 3) Pengajian Sirrotul Jannah RSPHS 4) Komunitas TB-SO
5.	Peringatan Hari Besar	1) Peringatan Hari Besar Nasional 2) PHB Kesehatan 3) PHBA 4) PHUT RSPHS Melalui seminar, lomba Kesehatan, maupun peringatan melalui media social. Melakukan list hari-hari besar pada tahun 2025 beserta cara memperingatinya, segera membuat TOR untuk acara yang diperingati melalui seminar dan lomba.

NO	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
		Mempertimbangkan evaluasi kegiatan pada tahun sebelumnya untuk perbaikan acara pada tahun yang akan berjalan.
6.	Program Nasional (PROGNAS)	Upaya Preventif & Promotif Dalam mendukung program nasional maka tim PKRS menyediakan media untuk melaksanakan penyuluhan Kesehatan maupun seminar dan IG Live dengan materi yang berkaitan dengan : a) Kesehatan Ibu dan Bayi b) TBC c) HIV/AIDS d) Stunting dan Wasting e) Keluarga Berencana (KB) Rumah Sakit
7.	Pengabdian Masyarakat / CSR / Edukasi Luar Gedung	Penyuluhan Kesehatan di luar Gedung bekerjasama dengan Sekolah, Pondok, PKK, Instansi dan Organisasi di sekitar Rumah Sakit.
8.	PHBS Karyawan	Meningkatkan perilaku hidup sehat karyawan berkoordinasi dengan K3
9.	Monitoring & Evaluasi	1) Supervise (OMRR & CMRR) 2) Rapat Tim PKRS

2. Sasaran

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDART	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
1.	Penambahan 1 orang staf PKRS full time (diutamakan yang latar Pendidikan DKV)	Optimalkan program & strategi pelaksanaan PKRS	Sarjana Desain Komunikasi Visual / D4 Promosi Kesehatan	Rekrutmen	Terpenuhi	Penambahan 1 staf PKRS disetujui	-
2.	Pelatihan manajemen PKRS	Meningkatnya manajerial PJ PKRS	PJ PKRS	Diklat	1x/thn	Sertifikat Materi Laporan Suart Tugas	Ikut diklat yang diselenggarakan HPH di Bogor / KARS
3.	Diklat pembuatan media	Meningkatnya manajerial PJ PKRS	PJ PKRS	Diklat	1x/thn	Sertifikat Materi Laporan Suart Tugas	Ikut diklat yang diselenggarakan HPH di Bogor atau online
4.	Pelatihan pembuatan materi leaflet untuk membuat tiktok	Meningkatnya jumlah leaflet, tersedianya edukasi melalui tiktok di RSPHS	PIC PKRS	Pelatihan Internal	1x/thn Target tiktok 1x/mngg	Masing-masing peserta dapat membuat content per minggu	Materi sesuai kebutuhan unit
5.	Bimtek Edukator Kesehatan untuk tenaga PKRS	Meningkatnya kemampuan & ketrampilan PIC PKRS dalam memberikan KIE	Semua PIC PKRS unit	Pelatihan Internal	1x/thn	Semua PIC PKRS unit mahir dan terampil dalam melakukan edukasi	
6.	Orientasi Umum – Pengenalan	Meningkatkan pengetahuan karyawan baru terkait program	Staf baru	CTJ	Terpenuhi	1) 100% karyawan baru mengikuti 2) 100% karyawan baru yang mengikuti pelatihan	

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDART	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
		PKRS dan Komunikasi Efektif dasar di RS				mengalami peningkatan pengetahuan & keterampilan.	
7.	Refreshment Training : Komunikasi Efektif PPA & Non PPA	Memperkuat dan memperbarui pengetahuan serta keterampilan yang sudah diperoleh sebelumnya	All staf	Sosialisasi & pelatihan	100% staf	1) 100% karyawan yang mengikuti pelatihan 2) 100% mengalami peningkatan pengetahuan & keterampilan	
8.	Pemberdayaan DOLINA	Memberdayakan komunitas Ibu Hamil agar secara mandiri dapat memelihara & meningkatkan kesehatannya	Komunitas Ibu Hamil	Community Development	2x/bln	Terlaksananya pemberdayaan minimal 1x dalam 1 bulan	50 peserta
9.	Pemberdayaan Komunitas F-KUL	Memberdayakan komunitas lansia agar secara mandiri dapat memelihara & meningkatkan kesehatannya	Komunitas lansia	Community Development	1x/mngg	Terlaksananya pemberdayaan minimal 3x dalam 1 bulan	40 peserta
10	Pemberdayaan Komunitas TAHU BAKSO (TB-SO)	Memberdayakan komunitas	Pasien TBC	Community	1X/bln	100% pasien TBC dan keluarga ikut aktif	

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDART	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
		pasien TBC agar terjadi perubahan perilaku		Development			
11.	Pemberdayaan Komunitas Pengajian	Memberdayakan komunitas pengajian sebagai ajang pemasaran RS	Pasien, keluarga pasien, pengunjung SDM RS, dan Masyarakat sekitar RS	Community Development	1x/bln	Terlaksana pemberdayaan 1x dalam 1 bulan	100 peserta
12.	Pengembangan Media	Media PKRS mudah dipahami dan diberikan sesuai dengan kebutuhan tiap sasaran	Pasien, keluarga pasien, pengunjung SDM RS, dan Masyarakat sekitar RS	Elektronik, cetak, social, audio & audio visual	Tersedianya berbagai media sesuai kebutuhan sasaran dengan materi yang up to date	Tersedia sedikitnya 100 materi edukasi dalam bentuk bervariasi (elektronik, cetak, social, audio & audiovisual)	
13.	KIE Individu	Meningkatnya pengetahuan & kemampuan pasien atau keluarga pasien terkait kesehatannya	Pasien & keluarga pasien	Media cetak		100% pasien telah mendapatkan KIE secara lengkap oleh petugas sesuai dengan kebutuhannya	
14.	KIE Kelompok	Meningkatkan pengetahuan & kemampuan pengunjung atau keluarga pasien terkait upaya Promotif,	Pengunjung RS & keluarga pasien	Media cetak		Edukasi kelompok dilaksanakan minimal 8x/bulan	

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDART	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
		Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif tentang 10 besar penyakit					
15.	KIE Massa	Meningkatkan pengetahuan & kemampuan massa terkait info Kesehatan, terkini atau 10 besar penyakit	Pengunjung Masyarakat sekitar & followers media social RSPHS	Video	2x/hari	Upload konten edukasi di media massa (medsos, radio spot, dan WAG)	Rekaman di radio disetting jam keluarnya siaran saat makan pagi dan saat makan siang
16.	Peringatan Hari Besar	Memperingati hari besar Kesehatan, hari besar nasional & hari besar keagamaan	Pasien, keluarga pasien, pengunjung SDM RS, dan Masyarakat sekitar RS	Seminar, poster, medos	PHBN-A (HUT RI, Kartini, hr ibu, idul fitri, iduldadha) Semua PHBK PHUT RSPHS	100% hari besar yang sudah dicatat diperingati seluruhnya	Rekaman VIDEO DPJP Di radio Di IG
17.	CSR/ Edukasi Luar Gedung	Menjaga citra & nama baik Perusahaan	Masyarakat sekitar RSPHS	Penyuluhan langsung	4x/tahun	Umandok Laporan	Kerjasama dgn LSM komunitas sekitar mengisi di acara-acara komunitas
18.	Pembuatan Video	Memperbanyak jenis media dan tema	Pengunjung RS	Video	5 video/tahun	Tersedianya 5 video baru tahun 2025	1. HPK terupdate 2. General konsen 3. IGD 4. APS 5. Hypno pragnency

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDART	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
18.	Supervise 9OMRR & CMRR)	Monitoring & evaluasi kinerja PIC PKRS	Pasien, keluarga pasien, rekam medis	Supervise/ survei	100 rm/bln	Laporan supervise/survei kelengkapan komunikasi antar PPA dan edukasi pasien dan keluarga 100% dilakukan PPA	
19.	Rapat Tim PKRS	Monitoring & evaluasi kinerja PIC PKRS	ALL PIC PKRS	Brain stroming & diskusi	Terpenuhi	Pelaksanaan rapat bulanan dihadiri minimal 75% dari seluruh total tim PKRS	

3. Pelaksanaan Kegiatan

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
1.	Penambahan 1 orang staf PKRS full Time (diutamakan yang latar belakang Pendidikan DKV)	1. Pengajuan SDM 2. Closed Rekrutemen staf	Seleksi kompetensi	Media sosial	Sesuai table 3.4 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024	1. Poster rekrutmen 2. Kontrak kerja 3. SK pegawai	
2.	Pelatihan manajemen PKRS	1. Pengajuan 2. Pelaksanaan 3. Laporan	Diklat	eksternal		1. Surtug 2. Sertifikat 3. Laporan 4. Materi	Sesuai jadwal HPH
3.	Diklat Pembuatan Media	1. Pengajuan 2. Pelaksanaan 3. Laporan	Diklat	Eksternal		1. Surtug 2. Sertifikat 3. Laporan 4. Materi	Sesuai jadwal eksternal
4.	Pelatihan membuat media	1. TOR 2. Pelaksanaan 3. Monev 4. Laporan	Pelatihan eksternal	Buku, PPT		1. Serif 2. SPJ 3. Absensi	
5.	Bimtek Edukator Kesehatan untuk Tenaga PKRS	1. Pengajuan Pelatihan 2. Pelaksanaan 3. Tot & Monev	Pelatihan Eksternal	Buku, PPT		1. Sertif 2. Tumandok	
6.	Orientasi Umum – Pengenalan Program PKRS & Komunikasi Efektif Dasar	1. Pengajuan TOR Pelatihan 2. Pelaksanaan 3. LPJ	Pelatihan Internal	PPT		1. Tumandok 2. Anbsensi 3. Sertifikat 4. LPJ	
7.	Refreshment Training : Komunikasi Efektif PPA & Non PPA	1. Pengajuan TOR Pelatihan 2. Pelaksanaan 3. LPJ	Pelatihan internal	PPT & Alat peraga		1. Tumandok 2. Anbsensi 3. Sertifikat 4. LPJ	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
8.	Pemberdayaan Komunitas DOLINA	1. Pengajuan Program Kerja 2. Pelaksanaan 3. LPJ	CTJ	PPT & Media Cetak		1. Tumandok 2. Laporan	
9.	Pemberdayaan Komunitas F-KUL	1. Pengajuan Program Kerja 2. Pelaksanaan 3. LPJ	CTJ	PPT & Media Cetak		1. Tumandok 2. Laporan	
10.	Pemberdayaan Komunitas TAHU BAKSO (TB-SO)	1. Pengajuan Program Kerja 2. Pelaksanaan 3. LPJ	Luring	Elektronik		Tumandok	Koordinasi dg PJ TBC
11.	Pemberdayaan Komunitas Sirotul Jannah	1. Pengajuan TOR 2. Advocacy toga 3. Pelaksanaan 4. Evaluasi	CTJ Pembelajaran	Direct		Umandok	Pendekatan pada muslimat dan toga sekitar
12.	Pembuatan Video	1. Buat scenario persiapan pemain 2. Shooting 3. Editing	Drama/ simulasi bermain peran	Audiovisual		Tersedia 5 video baru : 1. HPK terupdate 2. General konsen 3. IGD 4. APS 5. Hypnopragnency	
13.	KIE Individu	1. Assessment 2. Planning 3. Implementation 4. Evaluation	Penjelasan, konseling, diskusi	Direct, Tab, RM		RM edukasi terintegrasi, dan RM Edukasi kolaborasi	
14.	KIE kelompok	1. Assessment 2. Planning 3. Implementation	CTJ, Roleplay,	Elektronik, media cetak		Umandok di buku SAP + Llapbul	

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
		4. Evaluation	Demostrasi, DKT				
15.	KIE massa	1. Assessment 2. Planning 3. Implementation 4. Evaluation	Talkshow, seminar, siaran	Radio IG tiktok		Uamndok + Lapbul	
16.	Peringatan Hari besar	1. Pengajuan TOR 2. Pelatihan 3. Pengajuan 4. LPJ	Seminar Lomba Ucapan	Media elektronik + media cetak		Umandok	
17.	CSR/ Edukasi Luar Gedung	1. Pengajuan TOR 2. Pelatihan 3. Pelaksanaan 4. LPJ	CTJ	PPT + Media Cetak		Umandok	
18.	Supervise (OMRR & CMRR)	Supervise Open & Closed Medical Record	Supervise	Form		Form supervise lapbul	
19.	PHBS Staf	Koordinasi dengan k3, Konseling karyawan PHBS	Konseling	direct		Umandok + laporan	
20.	Rapat Tim PKRS	Undangan	Brainstorming & diskusi kelompok terarah	PPT		Umandok	

5. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

NO	KEGIATAN	SASARAN	BULAN												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET	
			12/24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12
1	Penambahan 1 staf PKRS Full Time (diutamakan yang latar belakang Pendidikan DKV)	Sarjanan DK/ D4 Promkes		√												RSPHS	SDM	PT. DPM	-
2	Pelatihan membuat leaflet	PIC PKRS		√												KOMPAS TV	SDM	PT. DPM	-
3	Pelatihan manajemen PKRS	PJ PKRS														BOGOR	SDM	PT. DPM	Sesuai jadwal eksternal
4	Diklat membuat media	PJ PKRS														Sesuai penyelenggara	SDM	PT. DPM	Sesuai jadwal eksternal
5	Bimtek educator Kesehatan untuk tenaga PKRS	PIC PKRS yang berkomitmen & memiliki evaluasi kinerja yang baik selama menjabat sebagai PIC PKRS			√											TENTATIF	SDM	PT. DPM	-
6	Orientasi umum – Pengenalan Program PKRS & Komunikasi Efektif Dasar	Staff Baru	TENTAIF MENYESUAIKAN JADWAL SDM												RSPHS (Hall Sakura)	SDM	-	-	
7	Refreshment Training : Komunikasi Efektif Medis & Non Medis	All Staf				√					√					RSPHS (Hall Sakura)	SDM	Dapur RSPHS	-
8	Pemberdayaan DOLINA	Komunitas Ibu Hamil	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	RSPHS (Hall Cordoba)	Pj kia	Dapur RSPHS	-

NO	KEGIATAN	SASARAN	BULAN												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET	
			12/24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12
9	Pemberdayaan Komunitas F-KUL	Komunitas Lansia	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	RSPHS (lahan parkir samping kantin)	PJ Geriatri	PT. DPM	-
10	Pengembangan Media PKRS	Pasen, keluarga pasien, pengunjung SDM RS, dan Masyarakat sekitar RS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	RSPHS	PJ Program PKRS	PT. DPM	-
11	Pembuatan Komunitas TAHU BAKSO	Pasien TBC		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	RSPHS	PJ TBC	PT. DPM	
12	Pemberdayaan Komunitas Sirotul Jannah	Masyarakat sekitar RS yang beragama Islam	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	RSPHS	PJ PKRS	PT. DPM	
13	Pembuatan video	5 program														RSPHS	PJ PKRS	PT. DPM	
14	KIE Individu	Pasien & Keluraga pasien,	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	RSPHS	PIC PKRS Ruangn	PT. DISA PRIMA MEDIKA	-
15	KIE Kelompok	Pengunjung & Keluarga Pasien	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	RSPHS	PIC PKRS Ruangn	PT. DISA PRIMA MEDIKA	-
16	KIE Massa	Masyarakat sekitar & Followers media sosial RSPHS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Radio spot dan Medsos RSPHS	PJ Program PKRS	PT. DISA PRIMA MEDIKA	-
17	Peringatan Hari Besar	Pasien, Keluraga pasien,	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	TENTATIF	PJ Program PKRS	PT. DISA PRIMA MEDIKA	-

NO	KEGIATAN	SASARAN	BULAN												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET	
			12/24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12
		Pengunjung, SDM RS, dan Masyarakat sekitar RS																	
18	CSR/ Edukasi Luar Gedung	Masyarakat sekitar RSPHS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Luar RS	PJ Program PKRS & Marketing	PT. DISA PRIMA MEDIKA	-
19	Supervisi (OMRR & CMRR)	Pasien, Keluarga Pasien, Rekam Medis	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	IRNA, ICU, Maternitas, Perinatologi	PJ Program PKRS, Karu, PIC PKRS Ruangan	-	-
20	PHBS Karyawan			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	MCU	K3		
21	Rapat Tim PKRS	All PIC PKRS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	RSPHS (Hall Andalusia)	Ketua Tim PKRS	Dapur RSPHS	-

6. Kebutuhan Anggaran

Semua anggaran akan dibiayai dari Rencana Bisnis Anggaran yang telah disetujui oleh PT. Disa Prima Medika

NO	KEBUTUHAN	RATA-RATA/ BULAN	KEBUTUHAN 1 TAHUN	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Cetak Leaflet	500 Leaflet (13 titik ruang tunggu. 5 slot dalam 1 box leaflet)	7000	1000	7.000.000
2	Cetak Poster	10	12	55.000	6.600.000
3	Cetak Banner	2	12	55.000	660.000
4	Konsumsi acara Komunitas DOLINA	20 peserta (2x/bulan)	480 px	10.000	4.800.000
5	Fee Instruktur Senam di Komunitas F-KUL	4x – 5x /bulan	52x pertemuan	150.000	7.800.000
TOTAL					26.860.000

NO	KEGIATAN	INTERNAL/ EKSTERNAL	JUMLAH (SATUAN)	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Penambahan 1 orang staf PKRS full time (diutamakan yang latar Pendidikan DKV)	Eksternal	-	-	-
2	Pelatihan Jurnalistik	Eksternal	800.000 (@10 peserta)	8.000.000	8.000.000
3	Bimtek Edukator Kesehatan untuk Tenaga PKRS	Eksternal	3.750.000	7.500.000	7.500.000
4	Orientasi Umum – Pengenalan Program PKRS & Komunikasi Efektif Dasar	Internal	-	-	-
5	Refreshment Training : Komunikasi Efektif Medis & Non Medis	Internal	-	-	-
6	Pengembangan Media PKRS a. 1 Set Panthom (anatomi, gigi, mata, dan panggung) b. 1 Set LCD Proyektor Portable	Internal	a. 1 Set b. 1 Set	a. 5.000.000 b. 3.000.000	8.000.000
7	Perayaan HUT RSPHS Ke-6 (11 Januari)	Internal & Eksternal	-	8.000.000	8.000.000
8	Hari Perempuan Internasional (8 Maret)	Internal & Eksternal	-	5.000.000	5.000.000



9	Hari Lanjut Usia Nasional (29 Mei)	Internal & Eksternal	-	6.000.000	6.000.000
10	Hari Anak Nasional (23 Juli)	Internal & Eksternal	-	7.000.000	7.000.000
11	Perayaan HUT RI (17 Agustus)	Internal & eksternal	-	9.000.000	9.000.000
12	Hari Kesehatan Gigi & Mulut Nasional (12 September)	Internal & Eksternal	-	6.000.000	6.000.000
13	Hari Kesehatan Nasional (12 November)	Internal & Eksternal	-	7.000.000	7.000.000
14	Hari Diabetes Sedunia (14 November)	Internal & Eksternal	-	4.000.000	4.000.000
TOTAL					75.500.000

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi Program kerja Rumah sakit Prima Husada Sukorejo bertujuan untuk menjamin mutu pelayanan di Rumah Sakit Prima Husada dengan membuat program pengendalian dan peningkatan untuk mutu tersebut. Perumusan dan penyusunan kebijakan pengendalian dan peningkatan mutu pelayanan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi melalui masukan dari seluruh jajaran dan staf yang terlibat dan berdasarkan hasil evaluasi kinerja secara periodik yang kemudian ditindaklanjuti untuk dilaporkan kepada direksi.

Beberapa Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Kerja dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Rapat Unit

Sebagai sarana pemecahan masalah pelayanan yang terjadi baik secara Teknik operasional maupun Teknik pengelolaan atau manajerial di lingkungan rumah sakit dalam lingkup kecil yang lebih intens per unit.

2. Supervisi Berjenjang

Kegiatan pemantauan, pengawasan dan penilaian terhadap seluruh kegiatan di ruangan dalam pelaksanaan pelayanan di rumah sakit mulai dari sikap, pengetahuan dan ketrampilan sebagai bahan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan mutu pelayanan yang dilakukan secara berjenjang pada masing-masing unit.

3. Evaluasi Pelaksanaan

Evaluasi dilaksanakan oleh pejabat struktural yang berada pada unit kerja yang bersangkutan dan dilaporkan secara berjenjang kepada pejabat struktural di atasnya. Hasil pelaksanaan dianalisa oleh pejabat struktural yang ada pada unit kerja yang bersangkutan dan dilaporkan kepada atasannya secara periodik untuk dilaksanakan perbaikan sebagai upaya tindak lanjut sesuai kebutuhan unit kerja yang bersangkutan

BAB V

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pencatatan dan pelaporan program di rumah sakit dimaksudkan untuk mendapatkan laporan yang valid sesuai dengan pelaporan data yang disampaikan setiap unit. Sistem pelaporan di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo memakai sistem berjenjang dimana system pelaporan dilakukan dari unit pelaksana hingga ke manajerial dan direktur.

Adapun jenis pelaporan yang ada di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu :

1. Laporan Internal Rumah Sakit

- a. Sensus harian
- b. Laporan efisiensi Rumah sakit
- c. Kegiatan pelayanan Medis
- d. Kegiatan pelayanan Penunjang rumah sakit

2. Laporan Eksternal Rumah Sakit

- a. Data Kegiatan Rumah Sakit
- b. Data keadaan morbiditas pasien rawat inap
- c. Data keadaan morbiditas penyakit khusus rawat inap
- d. Data keadaan morbiditas pasien rawat jalan
- e. Data keadaan morbiditas pasien rawat jalan
- f. Data keadaan morbiditas penyakit khusus pasien rawat jalan
- g. Data individual morbiditas pasien rawat inap
- h. Data Inventaris rumah sakit
- i. Data keadaan ketenagaan
- j. Data peralatan Rumah Sakit

Periode Pelaporan

Periode Laporan dibuat berdasarkan catatan harian yang dikompilasi dan dilaporkan setiap :

a. Laporan Bulanan

Sebagai laporan internal yang merupakan rekapitulasi hasil kerja kepada Direktur setiap bulan.

b. Laporan Trwulan

Sebagai laporan internal yang merupakan rekapitulasi hasil kerja kepada Direktur setiap tiga bulan.

c. Laporan Tahunan

Sebagai laporan internal yang merupakan rekapitulasi hasil kerja kepada Direktur setiap tahun.

BAB VI
PENUTUP

Demikian Program Kerja Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Tahun 2025 ini kami susun sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo, serta sebagai pedoman rumah sakit dalam mencapai tujuan yang diinginkan, juga sebagai tolak ukur dalam pencapaian target tahun 2025 serta dasar evaluasi di akhir tahun nantinya

Kami menyadari dalam penyusunan program kerja ini masih banyak kekurangan sehingga diharapkan adanya kritik dan saran untuk perbaikan selanjutnya

Pasuruan, 01 Januari 2025

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS